Die allgemeine Anamnese

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Anamnese	3
1. Gesprächsbeginn	4
Im Notfall	5
2. Patientendaten	6
3. Aktuelle Anamnese	7
4. Vegetative Anamnese	7
5. Vorerkrankungen	8
6. Voroperationen	8
7. Medikamente	8
8. Allergien und Unverträglichkeiten	9
9. Noxen	9
10. Familienanamnese	10
11. Sozialanamnese	10
12. Schlussformeln	10
Schmerzanalyse	11
Ort	11
Charakter	11
Ausstrahlung	12
Dauer	12
Einflussfaktoren	13
Begleitbeschwerden	13
Kardiologie	13
Pneumologie	14
Nephrologie	16
Neurologie	16
Frauenheilkunde	17
Sexualanamnese	18
Hautheilkunde	18
Orthopädie	19
Infektiologie	20
Hämatologie	20
Psychiatrie	21

Handlungsplan im Notfall	22
Notfall bei der Anamnese	23
Kommunikative Strategien	23
Kommunikationswege bei schwierigen Patientensituationen	24
Patient zeigt keine Krankheitseinsicht	24
Patient verweigert Zusammenarbeit	25
Patient spricht nicht klar und deutlich	26
Patient fordert sofortige Diagnose	27
Patient fordert sofortige Therapie	28
Arztbrief (Dokumentation)	29
Über die Anamnese berichten	30
Einleitung	30
Arztbrief: Aktuelle Anamnese	31
Einleitung + Hauptsymptom	31
Charakter der Schmerzen	31
Intensität der Schmerzen	31
Charakter und Intensität der Schmerzen in einem Satz	31
Subjektive Symptome	31
Begleitsymptome	31
Objektive Symptome	32
Vegetative Anamnese	32
Vorerkrankungen	32
Verdachtsdiagnose / Differentialdiagnosen	33
Weiteres Vorgehen / Therapie	33
Diagnose, Therapie, Prognose	34
Schlussformeln	35
Typische Formulierungen	36
Arzt-Arzt-Gespräch / Fallvorstellung	38
Das Arzt-Arzt-Gespräch	39
Diagnostische Maßnahmen	41
PATIENTENVORSTELLUNG (PV)/ARZT-ARZT GESPRÄCH:	57
	60

	61
	61
KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG:	68
ALLGEMEINE TIPPS und INFORMATIONEN:	69
EINIGE AUFKLÄRUNGEN:	76
Apparative Diagnostik und Eingriffe	77
Röntgen	77
Computertomografie (CT)	78
Ultraschall (US)	78
Bronchoskopie	78
Angiographie	78
Bypass-Operation	78
ÖGD	79
Koloskopie	79
ERCP	79
Laparoskopie	80
Allgemeine OP-Aufklärung	81

Allgemeine Anamnese ↩️

dryes

Allgemeinanamnese:

• ***Sprechen Sie **während der Anamnese** mit dem Patienten kein „Fachchinesisch“. (Teknik Dil)***

1. Gesprächsbeginn ↩️

1. Gesprächsbeginn

=>*Zuerst **stellt** der Arzt (Prüfungskandidat) **sich** kurz **vor** und fragt den Patienten (Prüfer), **ob er einverstanden ist**, dass man die Anamnese mit ihm durchführt. Beispiel:*

- *Guten Tag,*

=> Mein Name ist Savran. Ich bin hier der zuständige Arzt für Sie.
=> Zuerst **möchte** ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person **stellen**, dann **kommen** wir gleich zu Ihren Beschwerden.

- „Was kann ich für Sie tun? “

*Manchmal passiert es bei der Prüfung, dass der Patient sagt:
„Nein, Sie sind doch zu jung“☺, oder: „Nein. Aus welchem Land kommen Sie eigentlich? Was machen Sie hier? Haben Sie genug Erfahrung?“ ☺ Manchmal antworten die Patienten: „ Sie können nichts für mich tun. Sie sind zu jung und unerfahren. (Bazen hastalar, "Benim için yapabileceğin bir şey yok. Çok genç ve tecrübesizsin.) Seit wann sind Sie überhaupt in Deutschland? Ich will **mit dem** Oberarzt sprechen.“ Ruhig bleiben. Schon darauf vorbereitet sein. (Buna hazırlıklı ol)
****Denn die Zustimmung des Patienten brauchen Sie auf jeden Fall.*
****Çünkü kesinlikle hastanın rızasına ihtiyacınız var.*

A: „Frau Müller, in Deutschland darf man erst dann als Assistenzarzt arbeiten, **wenn man eine Prüfung bestanden hat** – diese habe ich bestanden und meine Approbation bekommen. Und wir arbeiten hier im Team. Jetzt würde ich das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Bevor wir dann über therapeutische Maßnahmen entscheiden, werde ich den Fall mit einem Oberarzt besprechen. Machen Sie sich **also** bitte keine Sorgen, die wichtigen Entscheidungen treffen wir gemeinsam – im Team.“

- Wenn der Patient zu schnell oder undeutlich spricht:
„Frau Müller, bitte sprechen Sie etwas langsamer,
ich **muss** mir auch Notizen machen.“

-Wenn der Patient sofort Medikamente gegen ihre Beschwerden möchte:
„Frau Müller, ich glaube Ihnen, dass Sie **das** nicht mehr ertragen

können. Wenn ich Ihnen aber die falschen Medikamente gebe, wird das auch nichts Gutes bringen. Ich muss Ihnen zuerst noch ein paar Fragen stellen. Dann sind wir gleich fertig.“

Im Notfall ↩️

********** Im Notfall **********

Herr Müller, **um** herausz**u**finden, **was** Sie genau **haben**,
würde ich Sie zuerst untersuchen. Wenn *die Untersuchungsergebnisse* vorliegen, **besprechen** wir *das weitere Vorgehen*.
Auf jeden Fall **werden** wir *die beste Therapie* für Ihre Beschwerden **finden.**

=> Frau Müller, Nehmen Sie bitte hier Platz,
=> Ich denke, **es handelt sich um** einen Notfall.
=> Ich habe **den** Verdacht **auf ein Akutes Koronarsyndrom.**
=> Sie brauchen jetzt eine intensivmedizinische/**stationäre Behandlung.**
=> **Zuerst werde** ich Sie sofort **untersuchen** und Ihre Vitalzeichen **überprüfen**, Ihren Blutdruckt, Ihren Puls, Ihre Sauerstoffsättigung und Ihre Temperatur **messen.**
=> **Dann legen** wir einen venösen Zugang und **nehmen** gleichzeitig Blut **ab.**
(Tn I und T, Blutgasanalyse, Glukose, INR, D-Dimer)
=> **Danach machen** wir ein EKG und ich **schließe** Sie zur Überwachung an einen Monitor **an.**
=> **Anschließend werden** wir einen Ultraschall Ihres Herzens **durchführen,** und dann **sehen** wir weiter.
=> Sie **bekommen** Sauerstoff /ein Schmerzmittel/oder ASS, usw.
=> Sie **brauchen** keine Angst **zu** haben, wir **schauen** uns gleich alles **an**.
=> Wir **machen** jetzt eine Blutuntersuchung. Es dauert ungefähr eine Stunde, **bis** ich die Ergebnisse **bekomme**. ***(in der Zwischenzeit können wir unser Gespräch fortsetzen.)***
=> Sie **werden** weiter überwacht.
=> Wenn Sie Schmerzen **haben, können** Sie **sich** jederzeit **melden**.
=> Wenn Sie **sich** nun besser **fühlen, können** wir mit der Anamnese **fortfahren.**
=> Darf ich? <= *Prüfere söylenerek Anamneze devam.*

****

Auf keinen Fall Angst vor komischen Fragen oder Reaktionen des Patienten haben! Das ist *Ihre Chance*, den Prüfern zu zeigen, dass Sie gut reagieren können. Auch wenn Sie vielleicht ängstlich sind und einige Sprachfehler machen – wichtig ist, *dass* Sie reagieren und nicht stumm bleiben! Sie können *alles* beantworten, glauben Sie mir auch wenn Sie eine falsche Antwort geben.

Hastadan gelen garip sorulardan veya tepkilerden asla korkmayın! Bu, sınav görevlilerine reaksiyoner cevap vermede iyi olduğunuzu gösterme şansınız. Endişeli olsanız ve konuşurken birkaç hata yapsanız bile reaksiyon vermeniz ve sessiz kalmamanız önemlidir! Her şeye cevap verebilirsin, inan bana (yanlış cevap versen bile..)

Im klinischen Alltag gibt es keinen „Chef“ im Arzt-Patienten- Gespräch, oft bestimmen die Bedürfnisse des Patienten das Tempo. Aber in der FSP haben die Schauspieler manchmal einen großen Redebedarf; sie unterbrechen Sie und stellen viele,

gern auch fiese Fragen. Bleiben Sie höflich und nett, aber machen Sie auch klar, dass Sie das Aufnahmegespräch bis zum Ende durchführen möchten. Beantworten Sie die Fragen am Ende des Gesprächs. Sonst sind Ihre 20 Minuten schnell vorbei und die Anamnese ist noch nicht abgeschlossen ;-)

Günlük klinik uygulamada, doktor-hasta tartışmalarında "patron" yoktur; hastanın ihtiyaçları genellikle hızı belirler. Ama FSP'de oyuncular bazen çok konuşmaya ihtiyaç duyarlar; sözünüzü keserler ve kötü sorular da dahil olmak üzere birçok soru sorarlar. Kibar ve net olun, ancak anamnez görüşmesini sonuna kadar götürmek istediğinizi de açıkça belirtin. Sonuna kadar sorularınizi sorun. Aksi takdirde 20 dakikanız çabucak biter ve anamnez henüz tamamlanamaz.
☺ Hauptsache ist jedoch, den Namen richtig **zu** schreiben. *Ancak asıl önemli olan, ismi doğru hecelemektir.*

2. Patientendaten ↩️

2. Patientendaten

☺ *=> mit Doppel-T oder mit D / T am Ende?* Vor- und Nachnamen

- „Wie heißen Sie? **Können Sie** bitte Ihren ^ buchstabieren? "

Ich muss Sie fragen. Damit kann ich Ihre zeitliche Orientierug überprüfen. Beantworten Sie bitte die Frage.
Manchmal wollen die Patienten das Geburtsjahr nicht sagen: „Das können Sie auch allein ausrechnen, oder?" Ruhig bleiben.

- „Wie alt sind Sie? "
- „Wann genau sind Sie geboren?"
- „Wie groß sind Sie?"
- „Wie viel wiegen Sie?" *Könnten Sie mir bitte sagen, wie viel Sie **wiegen?***
- „Was sind Sie von Beruf?" *Rentner-in=>**Was waren Sie von Beruf**?* Sind Sie **angestellt** oder **selbständing?***
- „Was genau machen Sie **in Ihrem Beruf**?"* *=> meslek üzerine fikrin yoksa sor!*
- **„Wie heißt Ihr Hausarzt?"** => *Die Frage nach dem Hausarzt ist wichtig, besonders bei älteren Patienten oder Patienten, die ihre eigenen Vorerkrankungen oder **Ihre Medikation** nicht so genau kennen.*
„Rücksprache mit dem HA steht aus / folgt", schreiben Sie dann im Arztbrief.

3. Aktuelle Anamnese

- *„**Was kann ich für Sie tun?**"*
- „**Seit wann** haben Sie diese Beschwerden? " Wo genau **sind** die Schmerzen? "
- „**Wie sind** die Beschwerden **aufgetreten**?" => ***eher** langsam oder plötzlich?*
- „**Wie** *haben sich* die Beschwerden *im Laufe der Zeit verändert*?" *Haben **sie** sich verbessert oder verschlechtert?*
- „**Können** Sie die Schmerzen *genauer* **beschreiben, sind sie** eher drückend, stechend, ziehend, brennend, dumpf, kolikartig? ^ *Wann hat das angefangen?*
- „**Haben** Sie *so etwas früher* schon einmal **gehabt**? "oder *ist das zum ersten Mal?* Wenn ja => Wann ?
- „Wie stark **sind** die Schmerzen auf einer Skala von 1-10 ? *(wobei 1 sehr leichte **und** 10 starken Schmerzen entspricht)*
- „**Können** Sie mir **zeigen**, wo die Schmerzen am stärksten **sind**? "
- „**Strahlen die** Schmerzen irgendwohin **aus?** "
- „**Sind** die Schmerzen dauerhaft da, oder **gehen** sie wieder **weg**? "
- „**Sind** die Beschwerden **belastungsabhängig, nahrunsgabhängig, atemabhängig oder lageabhängig**?``
- **„Gibt es** etwas, dass die Schmerzen **lindert** oder **verstärkt**? " ***Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?***
- „**Haben** Sie etwas gegen die Schmerzen/Beschwerden **eingenommen**? "***Hat das geholfen***?„
- „**War** Ihnen schwindelig oder ist Ihnen *"schwarz vor Augen* geworden." => *Synkope*
- „**Haben** Sie **das** Bewusstsein **verloren?** "
- „**Waren** Sie in letzter Zeit im Ausland? "
- „Also Frau Müller, Sie **haben gesagt**, dass **Sie** seit *5 Tagen Kopfschmerzen* **haben**."
- „**Waren** Sie **deswegen** *schon einmal **bei** einem Arzt* ?"/*im KH* ? *Ja: Was **wurde** damals **festgestellt***?
- „**Ist** Ihnen ein Engegefühl in der Brust **aufgefallen**?"
- „**Sind** Ihnen Herzrasen, Herzklopfen oder Herzstolpern **aufgefallen** "
- „**Leiden** Sie unter Atemnot, Husten oder *pfeifenden Atemgeräuschen*?"

- „**Ist** Ihnen Nervosität, Unruhe oder Hyperaktivität **aufgefallen**?"
- „**Ist** Ihnen in letzter Zeit eine Urin- oder Hautverfärbung **aufgefallen**?"
- „**Haben** Sie *sonst noch etwas* Ungewöhnliche**s** **bemerkt?** "*** *(Haben Sie weitere Beschwerden?)*
- „**Gibt** es *noch andere begleitende Beschwerden*?" *(Fiebergefühl, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Schwindelgefühl)*
- „Ich **möchte** ***auf Ihre aktuellen Beschwerden*** noch einmal **zurückkommen.** "
- „**Haben** Sie vor Kurzem eine längere Reise **gemacht**? (z.B) ***mit dem*** *Auto oder Flugzeug?* "
- „**Verbessern sich** die Schmerzen *bei Hochlagerung* oder *bei Tieflagerung?* "
- „**Möchten** Sie bezüglich Ihre**r** aktuelle**n** Beschwerde**n** noch etwas **hinzufügen**? "
- „**Wenn** ich weitere Informationen **benötige**, **würde** ich gerne mit Ihrem Hausarzt **besprechen.** "

4. Vegetative Anamnese

*-Haben Sie zu Hause **Fieber** gemessen? Wie hoch war es?*

- „Haben Sie **Fieber, Schüttelfrost** oder **Nachtschweiß** ?"
- „Leiden Sie unter **Schweißausbrüche**n oder **kaltem Schweiß**? "
- „Haben Sie Probleme **mit dem** Stuhlgang oder **beim** Wasserlassen?
- „Haben Sie **Übelkeit, Durchfall** oder **Erbrechen**? " *Wie sieht **das Erbrochene** aus? ,"*
- „Wie ist **Ihr Appetit**? " Ist Ihre Hose in letzter Zeit **zu** eng oder **zu** weit geworden?
- „**Hat sich** **Ihr Appetit** oder **Ihr Gewicht** in letzter Zeit **verändert**?"
- „Haben Sie **ungewollt ab-** oder zugenommen? *"=> War das oder gewünscht?*

=> Wie viel kg haben Sie **-** / **+** ? Haben Sie in der letzten Zeit vermehrten Appetit oder Durstgefühl?

=> In welchem Zeitraum haben Sie ..... kg **-** / **+** ? *z.B. im letzten halben Jahr.*

- „Sind Sie Stress **ausgesetzt**?"**Gibt es bestimmte Auslöser?* *Es **gäbe** keinen Auslöser für die Schmerzen.*
- „Schlafen Sie gut? Haben Sie **Ein-** oder **Durch**schlafstörungen? "
- „Darf ich Sie fragen, **ob** es Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr gibt? "

****(FSP'de Psikolojik durumu ile ilgili soruları yalnızca "hastadan" aşırı ayrıntılı bir anlatımı kontrol edebileceğinizden eminseniz sorun.)*

- „Haben Sie Schlaffprobleme wegen Ihrer aktuellen Beschwerden?

3. Aktuelle Anamnese ↩️

4. Vegetative Anamnese ↩️

- „Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt, Ihre**n** Urologen, Ihre**n** Hausarzt? "

=> Wann war Ihre letzte Periode? Sind Sie in den Wechseljahren?

=> Leiden Sie unter Menstruationsbeschwerden?

=> Ist es möglich, dass Sie im Moment schwanger sind?

=> Haben Sie eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschafsabbruch?

Fast alle Patientinnen antworten auf die Frage, ob sie sich regelmäßig checken lassen, mit Nein, besonders die mit Z. n. Hysterektomie. Klären Sie kurz darüber auf, wie wichtig die Vorsorgeuntersuchungen sind. (Hemen hemen tüm hastalar, özellikle histerektomi sonrası, düzenli kontrolleri olup olmadığı sorusuna hayır cevabı vermektedir. (Kontrollerin ne kadar önemli olduğunu kısaca açıklayınız.)

- „Frau Müller, das ist aber wichtig. In jedem Alter gibt es spezifische Krankheiten, die vermieden

werden können, wenn man den Frauenarzt regelmäßig besucht.“
• „Frau Müller, ein Frauenarzt behandelt nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Brüste, die Scheide, die Eierstöcke und die Drüsen, die Sie im Genitalbereich haben. Die können auch krank werden. Vereinbaren Sie bitte einen Termin beim Frauenarzt.“
• “Bayan Müller, bu önemli. Her yaşta düzenli olarak jinekoloğa gidilerek önlenebilecek belirli hastalıklar vardır.”
• „Bayan Müller Jinekologlar sadece rahmi değil aynı zamanda göğüsleri, vaginayı, yumurtalıkları ve genital bölgenizdeki bezleri de tedavi eder. Onlar da hastalanabilirler. Lütfen jinekologdan randevu alınız.”
• Dieselben Fragen gelten auch für Männer (stattdessen können Sie z.B. ein Prostata -karzinom oder hyperplasie erwähnen).
• „Treiben Sie **regelmäßig** Sport?“

5. Vorerkrankungen ↩️

5. Vorerkrankungen => In Ordnung, Frau Müller;

• „ Nun würde ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Krankenvorgeschichte stellen. “ __ • „Leiden Sie an irgendwelchen Erkrankungen? *Seit wann haben Sie diese?“* *=> Ich meine damit Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit, erhöhte Blutfettwerte Krebserkrankungen…*_ • „Was **nehmen** Sie dagegen **ein**?“ *=>Hatten Sie einen Insektenstich?* • „Wie **wurde** das **behandelt**? “*Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland?* • „**Waren** Sie schon einmal im Krankenhaus? “*Wie wurden die Beschwerden behandelt?* • „Hatten Sie bestimmte Kinderkrankheiten? “
• „**Gibt es** noch weitere Erkrankungen? “
• „Wann **waren Sie** das letzte Mal zur Kontrolle? “
• „Wann **wurden Ihre Werte** das letzte Mal **kontrolliert?** “
• „Notieren Sie Ihren Blutdruck/ Ihre Blutzucker/….. täglich? “

6. Voroperationen ↩️

• „Sind Sie *schon einmal* operiert worden? *Wann war das? Warum hatten Sie die OP?*
• „**Warum** und **wann**? “ *Bei Frakturen: Welche Seite und wie ist es passiert?*
• „**Gab** es Komplikationen?“

7. Medikamente ↩️

7. Medikamente

• „**Nehmen** Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente **ein**? “ *Welche?*
• „**Nehmen** Sie außer den genannten Medikamenten noch etwas **ein**? “
• „Welche Dosierung? Wann? Wie oft?“ Er/Sie konnte **sich** nicht dar**an erinnern.** • „**Sind** Sie vollständig / regelmäßig **geimpft**?“ *Gegen Covid-19 schon wie viel Mal?* • „**Sind** Sie gegen *alle Kinderkrankheiten*,

Covid-19 und Tetanus **geimpft**?“ • „**Haben** Sie *Ihr Impfbuch / Ihre Medikamenteliste* dabei? “ • „Wie viele **Einheiten** Insulin **spritzen** Sie? “ Wie oft **spritzen** Sie Insulin? “ => Ich **werde bei** Ihren Hausarzt **nachfragen.** (Name, Dosierung)

- Warum **nehmen** Sie das Medikament **ein**?

*Manche Patienten **erwähnen** nun erst alle Vorerkrankungen.*
Bei Kontrazeptiva brauchen Sie nicht nach der Dosierung zu fragen.
Einfach: „Die Patientin nimmt Kontrazeptiva und ..... ein.
****Das kann ich verstehen! ***Es wird mit .....behandelt.*
*=> Können Sie sich an den Namen des Medikaments erinnern? => Ich kann / konnte **mich** nicht daran erinnern.*
=> Er habe sich impfen lassen. Der Diabetes wird mit Metformin 500 mg dreimal täglich eingestellt.
*=> ACE-Hemmer **führen zu** einem trockenen Husten = ACE Hemmer **kann** dafür verantwortlich **sein.***
*=> Wurde er/sie deswegen **von einem Psychiater** unterschützt/behandelt?*
*=> Sie haben mir schon gesagt, dass Sie an Bluthochdruck leiden. **Was nehmen Sie dagegen?***

8. Allergien und Unverträglichkeiten ↩️

8. Allergien und Unverträglichkeiten

- „Haben Sie **Allergien** oder **Unverträglichkeiten**? *Welche?*“

=> Sind bei Ihnen noch andere Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt?

- „Wie **äußert** sich die Allergie? “=> **Sie äußert** sich **durch** Pruritus?
- „Wie **hat** sich die Allergie **geäußert**? “ *=> Vergangenheit*
- „**Reagieren** Sie allergisch auf bestimmte Medikamente?“ **<=!**

=> *Vergessen Sie bitte nicht, **nach** Medikamentenallergien zu **fragen**! *** Wie **wurde das festgestellt?***
=> *Er habe eine Pollenallergie, die **sich** durch Pruritus **äußere, und** mit einer Hyposensibilisierung behandelt **wurde**.*

9. Noxen ↩️

9. Noxen *-Haben Sie je versucht, mit dem Rauchen aufzuhören??)*

- „Rauchen Sie oder haben Sie früher geraucht? “ *Was rauchen Sie?*
- „Wie viele Zigaretten / Schachteln / haben Sie früher pro Tag geraucht?“
- „Seit wann?“ => *Seit ihrem 40. Geburtstag raucht die Patientin nur E-Zigaretten.*

*Aha, Sie rauchen **also** seit 10 Jahren.* (Bu cevap iyi puan getirir ☺) *(Rauchen Sie Schischa (Wasserpfeife)? (Wie viele Köpfe?)*

- „Trinken Sie Alkohol?“ „Seit wann?“ *Was trinken Sie?*
- „Wie häufig und wie viel ? “ *Trinken Sie täglich oder nur **zu** bestimmten Anlässen?*

=> *Frau Müller, nehmen Sie **meine nächste Frage** bitte nicht persönlich,*
*aber routinemäßig **muss** ich Sie **fragen, ob** Sie Erfahrung **mit Drogen haben**?*

- „Hatten Sie *jemals* Kontakt **mit Drogen**?“ *z. B. Cannabis, Kokain, Heroin, Amphetamin usw.?“*

=> *Wir **möchten eine richtige Diagnose** feststellen und **eine richtige Behandlung** für Sie beginnen.*

10. Familienanamnese ↩️

11. Sozialanamnese ↩️

10. Familienanamnese

• *„Jetz **würde** ich **einige Fragen zu Erkrankungen in Ihrer Familie stellen**. “*

• „Gibt es wesentliche Erkrankungen *in Ihrer Familie* “ Wie **wurde** Ihr Vater **behandelt?**

(Eltern, Geschwister, Kinder) ➔*Ich meine damit Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit, Krebserkrankungen ... ansteckende Krankheiten ... Schilddrüse, Magen, Leber, Herz, Nieren ...?*

• „Sind **sie** gesund?“ *(Sind Ihnen **in Ihrer Familie** **vererbbare Krankheiten** bekannt?)*

• „Woran ist Ihr Vater/Ihre Mutter gestorben? “ • „Haben Sie Geschwister? “ =>Der Vater **ist** vor 3 Jahren **an** oberer GI- Blutung ***infolge von Ösophagusvarizen*** **verstorben.**

11. Sozialanamnese

• *„Was machen Sie beruflich? “* • „Wie ist Ihr Familienstand?“ ***Also Frau Müller, Sie **sagten bereits**, dass Sie **verheiratet** sind, richtig? Falls verwitwet → Reaktion! „Mein Beileid.“ / „Es tut mir leid.“ Immer Empathie zeigen! ****

• „Haben Sie Kinder? Sind alle gesund? Ist er / sie gesund? “

• „Haben Sie Haustiere?`` *Gibt es **jemanden** zu Hause, **der sich** **im Notfall** **um** **Sie** **kümmern** kann?*

• „Wohnen Sie allein? oder mit wem wohnen Sie zusammen? ‘‘

(uns interessiert, wie viele Menschen auf wie vielen Quadratmetern wohnen – Infektionsrisiko?)

• „In welcher Etage wohnen Sie?“ *(Wichtig bei Herz-, pAVK-, Lungen- Beschwerden)*

12. Schlussformeln ↩️

➔ *Jetzt bin ich fertig*. *„Ich denke*; Ich **habe** alle wichtigen **Fragen gestellt**.“

➔ „Möchten Sie **noch etwas** hinzufügen oder **haben Sie Fragen**?“

➔ • **Erste Maßnahme:** Herr Doktor, **was habe ich?** Was machen Sie jetzt?

Ich **denke**, dass Sie.....**haben.** => Aber das ist nur **ein Verdacht.**

*-Bisher **haben** wir nur ein Aufnahmegespräch **gemacht**. Deshalb **sind** weitere Untersuchungen **erforderlich.** **Um** herauszufinden, was Sie genau **haben**, zuerst **möchte** ich Sie **untersuchen** und Vitalzeichen **überprüfen.** Dann **lege** ich einen Zugang und **nehme** Blut **ab**. Danach **mache** ich ein EKG, eine USG und **veranlasse** ein Röntgen. Wenn wir alle Untersuchungsergebnisse **haben**, **besprechen** wir **die weiteren Schritte.***

Es war gut, dass Sie hierhergekommen sind.

Nach der alle Untersuchung kann ich Ihnen sagen, was genau Sie haben. **eine OP benötigen.**

➪ im Moment kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, ob Sie..... **einen Krebs haben.**

➔ Frau Müller, Sie können (nicht) **ambulant behandelt werden.** **bei uns bleiben müssen.**

➔ Sie **sollten** bei uns im Krankenhaus bleiben, *bis wir **wissen**, was Sie genau haben.*

➔ Ich **möchte** Ihren Blutdruck, Ihren Puls und Ihre Temperatur messen.

➔ Ich **werde** Ihr Herz und Ihre Lungen **abhören**, Ihren Bauch **abtasten**, Ihre Nieren **abklopfen**, **um** die richtige Diagnose **festzustellen**, **brauchen** wir eine Blutprobe, eine Urinprobe sowie eine routinemäßige Stuhlprobe.

➔ Ich **lege einen Zugang** und **nehme** gleichzeitig etwas Blut **ab.**

➔ Wir **schreiben ein** EKG, so **können** wir **ein** Herzproblem **ausschließen.**

➔ Wir **machen ein Röntgenbild** Ihres Brustkorbs in zwei Ebenen,
so **können** wir Herzgröße **sehen** und ein Lungenproblem **ausschließen.**
➔ Sie **bekommen** etwas gegen Schmerzen. Sie brauchen Bettruhe.
Die Anamnese, die körperliche Untersuchung, die Laborwerte sowie die apparative Diagnostik deuten auf.....eine TVT.....hin.
➔ Vielleicht müssen wir Sie **zu** einem Facharzt / **ins** KH **überweisen.**
• **Verabschiedung:** ➔„Ich **werde** Ihren Fall mit dem Oberarzt **besprechen.**
Danach **werde** ich **alles** Ihnen ausführlich **erklären.**
*Die Hausmedikation dürfen Sie nicht mehr einnehmen. ***Sie bekommen Neue von uns.**
*Sie dürfen nicht mehr rauchen, Alkohol trinken oder Drogen nehmen.
*Sie bekommen ein Medikament gegen Fieber, ein Medikament gegen Schmerzen,
ein Medikament zum Magenschutz,.....
*Ich habe **ein** endokrinologisches Konsil für Sie organisiert.
*Sie müssen sich besser ernähren. *Sie müssen auch Sport treiben.
*Sie müssen mit dem Rauchen aufhören. ``*Jede Zigarette weniger ist **ein** wichtiger Schritt.*``
➔ **Nach der Entlassung** möchte ich Ihnen einige Ratschläge geben:
-Essen Sie mehr Obst und Gemüse. Gehen Sie im Wald spazieren.
-Verzichten Sie **auf** Nikotin, Alkohol, Drogen. ``*Sie **sollten** Ihren Alkoholkonsum **einschränken**.*``
➔ **Frau Müller, das kann** ambulant behandelt **werden.**
-Ich gebe Ihnen **ein** Antibiotikum. Nehmen Sie jeden Morgen **eine** Tablette
nach dem Frühstück. Nehmen Sie alle Tabletten bis zum Ende ein.
-Ich **verschreibe** Ihnen Nasentropfen. Sie **sollten** dar**auf achten.**
-Ich **schreibe** Sie für 5 Tage **krank.** -Bitte **Vereinbaren Sie** einen Kontrolltermin in 7 Tagen.
➔ **Nun, alle** Ihre Beschwerden deuten (nicht) auf ..... hin.
=>Frau Schmidt, denken Sie auch über ***die Ernährungsumstellung*** nach und vermeiden Sie **fettige Speisen zu essen.**

Schmerzanalyse ↩️

Ort ↩️

Schmerzanalyse:

Ort

- „Können Sie mir zeigen, wo es wehtut?“
- „Wie stark sind die Schmerzerzen auf einer Skala von 1-10?

Benutzen Sie unbedingt Fachbegriffe beim Schreiben und Vorstellen des Falls – aber bitte nicht im Gespräch mit dem Patienten! ***Schmerzen in +Dativ

Charakter ↩️

Charakter

- „Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben?

Sind sie eher – dumpf– stechend– ziehend– brennend– kribbelnd– bohrend – drückend– pochend – pulsierend – klopfend– scharf– kolikartig– wellenförmig ?“

- Bei Abdominalschmerzen auch:
- „Leiden Sie unter Blähungen?“(Meteorismus)
- „Haben Sie Sodbrennen ? (Pyrosis)

- „Haben Sie saures Aufstoßen?“ (Regurgitation) => Gas oder Nahrungsbrei
- „Werden die Schmerzen immer stärker oder lassen sie nach?“
- „Von 1 bis 10 – wie stark tut es weh?“

=> Die Schmerzen **seien nach einer fetthaltigen Mahlzeit aufgetreten.**
=> Vor 2 Stunden **habe** er **die Schmerzen im Epigastrium verspürt**,
dann **seien sie** in den rechten Unterbauch **gewandert.**
=> Oder **sie würden** in den rechten Hypogastrium **ausstrahlen.**

„Wie stark ...?“ frage ich in besonderen Fällen, z. B. bei Kopfschmerzen, da ist es mir sehr wichtig. In anderen Fällen merke ich, wie sich die Patienten verhalten, und kann auch allein einschätzen, wie stark die Schmerzen sind. Das Schmerzempfinden ist sehr subjektiv. Ich zum Beispiel bin sehr sensibel und kann überhaupt keine Schmerzen ertragen. Ich weine schon, wenn ich nur vermute, dass Schmerzen kommen [mein Zahnarzt hasst mich .
"Ne kadar güçlü ...?" Özel durumlarda soruyorum, ör. Baş ağrıları için benim için çok önemli. Diğer durumlarda, hastaların nasıl davrandığını fark ederim ve ağrının ne kadar şiddetli olduğuna kendim karar verebilirim. Ağrı algısı çok özneldir. Mesela ben çok hassasım ve hiç acıya dayanamıyorum. Acının geldiğinde bilerek ağlıyorum [diş hekimim benden nefret ediyor.``

Ausstrahlung ↩️

Ausstrahlung

- „Strahlen die Schmerzen aus? Wohin?“
- „Sind die Schmerzen nur an einer Stelle (Ort), also lokalisiert? *

Beim Migräne => Oder sind sie eher diffus?“

- „Wandern die Schmerzen?“

***Ausstrahlung in +Akkusativ!

Dauer ↩️

- „Seit wann haben Sie die Schmerzen?“
- „Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden aufgetreten sind?‘‘
- „Haben sie eher plötzlich oder langsam begonnen?‘‘
- „Wie lange dauern die Schmerzen schon an?“
- „Haben Sie *solche Beschwerden* schon mal gehabt?“
- „Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie auch wieder weg?‘‘
- „Wie häufig treten die Schmerzen auf? “

Einflussfaktoren ↩

Einflussfaktoren (Etkileyen Faktörler)

- „Gibt es etwas, das die Symptome/Beschwerden/Schmerzen verbessert oder verschlimmert?“(z.B. eine körperliche Belastung, Bewegung, Essen usw.) Semptomları/rahatsızlığı/ağrıyı iyileştiren veya kötüleştiren herhangi bir şey var mı?”
- „Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen?‘‘
- „Hat es Ihnen geholfen?‘‘
- „Seit gestern sind diese Schmerzen unerträglich. ‘‘
- ***„Sind die Beschwerden*** bewegungsabhängig? / belastungsabhängig? / lageabhängig? / atemanhängig?/hustenabhängig?/nahrungsabhängig? /schlafenabhängig? /tageszeitabhängig?

Wenn ja:

belastungsabhängig: *Wie viele Stockwerke können Sie hinaufgehen, ohne diese Beschwerde zu bekommen?*
Wie weit können Sie laufen, ohne diese Beschwerde zu bekommen?
bewegungsabhängig*? Welche Bewegungen diese Beschwerde verursachen?*
lageabhängig? *Welche Position/Lage diese Beschwerde verursachen?*
atemanhängig? *Haben Sie diese Beschwerde, wenn Sie ein- oder ausatmen?*
nahrungsabhängig*? Welche Lebensmittel diese Beschwerde verursachen?*
Haben Sie diese Beschwerde bei fester Nahrung oder bei flüssiger Nahrung?
Wechseln sie von der Mahlzeit zur Mahlzeit?
schlafenabhängig? *Konnten Sie flach liegen, wenn Sie schlafen?*
Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen?
tageszeitabhängig? *Sind diese Beschwerden am Morgen /nach dem Aufstehen) / in der Nacht/tagsüber/nachtsüber aufgetreten?*

Begleitbeschwerden ↩

Begleitbeschwerden

- „Haben Sie auch **andere** Beschwerden? Welche?“

Kardiologie ↩

- „Haben Sie *Schmerzen* oder *ein Engegefühl in der Brust?*“
- „Wo genau haben Sie die Schmerzen?

Hinter dem Brustbein oder eher in der Magengrube?“ (Epigastrisch.)

- „Strahlen die Schmerzen aus? Wohin?“
- „Sind die Schmerzen **hinter dem Brustbein** oder **in der Magengrube** lokalisiert?“
- „Treten die Schmerzen nur bei Belastung oder auch in Ruhe auf?“

(Belastungsabhängig.)

- „Sind die Beschwerden atemsabhängig?
- „Sind die Beschwerden nahrungsabhängig?
- „Sind die Beschwerden lageabhängig?
- „Bekommen Sie schwer/schlecht Luft?“
- „Haben Sie sich übergeben?“ ("Kustunuz mu?")
- „Haben Sie ein Nitrospray benutzt? II
- „Haben sich die Beschwerden dadurch verbessert?“
- „Haben Sie **Herzrasen** bemerkt?“ (Tachykardie.)
- „Haben Sie **Herzklopfen** bemerkt?“ (Palpitationen.)
- „Haben Sie **Herzstolpern** bemerkt?“ (Extrasystole.)
- „Ist Ihnen schwindelig geworden?“
- „Wird es Ihnen manchmal schwarz vor Augen, z. B. beim Aufstehen?“
- „Sind Sie schon einmal ohnmächtig geworden?“
- „Müssen Sie nachts Wasser lassen? Wie oft?“
- „Haben Sie **geschwollene Beine** bemerkt? *Besonders nachts?“*
- „Wie weit können Sie beschwerdefrei laufen?
- „Wie viele Treppen können Sie beschwerdefrei laufen / steigen.“
- „Müssen Sie beim Laufen stehen bleiben und eine Pause machen? “
- „Wie viele Kissen nutzen Sie beim Schlafen?“

***Risikofaktoren : • Diabetes mellitus • aHT • Rauchen, Drogen • Hypercholesterinämie • Herzfehler, Herzschrittmacher, Stentimplantation

geschwollene Beine: dicke Beine – Wasser in den Beinen- Beinödeme

Pneumologie ↩️

- „Haben Sie Probleme beim Atmen?“
- „Wenn ja, haben Sie eher Probleme beim Einatmen,

ggf. beim tiefen Luftholen, oder eher beim Ausatmen?“

- „Wann treten die Beschwerden auf? Bei Belastung oder auch in Ruhe
- „Bekommen Sie auch Brust(korb)schmerzen beim Atmen?

Wenn ja, eher beim tiefen Einatmen oder beim Ausatmen?“

- „Bekommen Sie diese Schmerzen nur bei Belastung?“
- „Wie viele Kissen nutzen Sie, wenn Sie schlafen?“
- „Klagt Ihr Partner / Ihre Partnerin, dass Sie beim Schlafen schnarchen?“
- „Ist es Ihnen passiert, dass Sie beim Schlafen Luftnot bekamen?“
- „Seit wann haben Sie Husten?“
- „Ist der Husten trocken oder haben Sie Auswurf bemerkt?“ *(= produktiv)*
- „Welche Farbe und Konsistenz hat der Auswurf?“ *transparent, gelblich, grünlich, eitrig, blutig / nur mit Blutfäden, dünn, wässerig, schleimig, schaumig*
- „Haben Sie etwas verschluckt?“
- „Sind Sie heiser?“
- „Wird in Ihrer Umgebung geraucht? “

Risikofaktoren

- Rauchen
- Arbeit: Dämpfe, Schadstoffe (z. B. Asbest) usw.
- Haben Sie auf der Arbeit mit belastenden Dämpfen oder Stäuben zu tun?

Bergbau: *Madencilik* *Schleifrei:* *Taslama* *Asbest am Bau:* *Insaat Asbesti*

Gastroenterologie

- *„Wie verhält sich der Schmerz, beim oder nach dem Essen? “*
- „Leiden Sie unter Übelkeit?“
- „Haben Sie Schluckbeschwerden *bei fester* oder *flüssiger* Nahrung? “
- „Haben Sie sich erbrochen / übergeben? Wie oft? Wie viel? “
- „Wie sieht das Erbrochene aus? `` *gallig, schleimig, blutig?*
- „Wie lange nach dem Essen war das?“
- „Geht es Ihnen besser, nachdem Sie sich erbrochen haben?“
- „Hatten Sie **kaffeesatzartiges Erbrechen**? “
- „Haben Sie Sodbrennen? “ => *zu viel Magensäure* *(GÖR) / Verdauungsstörungen?“*
- „Haben Sie saures Aufstoßen?“ *Regurgitation*
- „Haben Sie Bauchschmerzen?“ *(Wenn ja → Schmerzanalyse)*

- „Haben Sie ein Völlegefühl? “
- „Haben Sie regelmäßig Stuhlgang? / Wann hatten Sie den letzten Stuhlgang? “
- „Haben Sie das Gefühl, dass Sie viel schneller als früher satt werden?“
- „Essen Sie gerne Fleisch?“
- „**Fühlen** Sie **sich** aufgebläht?“ *(Meteorismus)*
- „Treten die Beschwerden **nach dem Verzehr** bestimmter Speisen auf?“
- „Was haben Sie *in den letzten Stunden* gegessen?“
- „Haben Sie Durchfall oder Verstopfung?“
- „Welche Farbe hat der Stuhl? *Ist er blutig, teerschwarz, gelblich?“*
- „Welche Konsistenz hat der Stuhl? *Hart, fest, weich, schleimig, wässerig?“*
- „Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie zur Toilette müssen, aber es kommt eigentlich nichts?“ *(Tenesmen)*
- „Wann hatten Sie die letzte Magen- / Darmspiegelung? “ -Was war das Ergebnis?“ *(Auch hinsichtlich einer Antikoagulation)*
- „ Haben Sie bemerkt, dass Ihre Augen gelb geworden sind? “ *Ikterus*

der Verzehr: yiyip- içme

nicht zum Verzehr geeignet: yiyip- içmeye elverisli degil.

Nephrologie ↩️

- „Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?“
- „Müssen Sie häufig Wasser lassen? Wie viel? (Welche Menge?) Auch nachts?“
- „Welche Farbe hat Ihr Harn / Urin?“
- „Riecht er komisch?“
- „Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?“
- „Haben Sie Augenschwellungen oder Gesichtsschwellungen bemerkt?“
- „Haben Sie Beinschwellungen bemerkt?“
- „Haben Sie Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen?“

Vergessen Sie nicht, danach zu fragen, ob / wohin die Nierenkolik ausstrahlt! Spezifisch!***

Neurologie ↩️

- „Haben Sie Kopfschmerzen?“ „Wo genau sind die Schmerzen?“
- „Wenn die Schmerzen als Attacken kommen: Wie lange **hält** eine Attacke **an**?
- „ Sind die Kopfschmerzen ein- oder beidseitig? “

(im Augen- oder Schläfenbereich, am hinter Kopf, im ganzen Kopf oder nur auf einer Seite?)

- „Ist Ihnen *während der Schmerzen* übel?``

• „Haben Sie Probleme mit den Augen? Tragen Sie eine Brille?“
• „Haben Sie eine besondere Lichtempfindlichkeit *während der Attacken* bemerkt? Oder Lärmempfindlichkeit?“
• „Bekommen Sie Schwindel? Wann?“
• „Kommen die Kopfschmerzen plötzlich oder gibt es vorher Anzeichen? ``
*-Wie häufig kommt es **zu einer Attacke?***
• „Spüren Sie Blitze oder ein Kribbeln in den Fingern oder im Gesicht?“
• „Haben Sie neben den Kopfschmerzen begleitende Übelkeit oder Erbrechen? “
• „Haben Sie irgendwelche Begleitbeschwerden?
-Tränenfluss, Nasenverstopfung, Augenschmerzen usw.?“
• „Haben Sie das Bewusstsein verloren? “ *Synkope* ***Bewusstsein***
• „Sind Sie ohnmächtig geworden?“ *Synkope*
• „Haben Sie Schwäche **in Ihren Armen** oder **in Ihren Beinen** bemerkt? ***Motorik***
• „**Fühlen** Sie **sich** irgendwo ein Kribbeln oder Ameisenlaufen? “ ***Sensibilität***
• „Sind Ihnen Missempfindungen oder Taubheitsgefühl aufgefallen? “ (Wo?
• „Erinnern Sie sich an etwas, das während, vor oder gleich nach diesen Ohnmachtsanfällen passiert ist?“
• „Lassen Sie unwillkürlich Wasser *während der Episoden?“*
• „**Haben** Sie **sich** *während der Episoden* irgendwie **verletzt**? zB. Kopfverletzungen, Zungenbiss?“
• „Haben Sie Kopfschmerzen oder Brechreiz vor oder nach diesen Episoden?“

willkürlich: keyfi *unwillkürlich: irade harici*

Frauenheilkunde ↩️

• „Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt? “
• „Ist Ihre Monatsblutung regelmäßig? “
• „Leiden Sie unter Menstruationsbeschwerden? “
• „Wann hatten Sie Ihre erste Blutung? “
• „Wann hatten Sie Ihre letzte Blutung? “
• „Ist es möglich, dass Sie im Moment schwanger sind? “
• „Könnte es sein, dass Sie schwanger sind? “
• „Waren Sie schon einmal schwanger? “
• „Haben Sie Kinder? “
• „Gab es Komplikationen während der Schwangerschaft? “
• „Hatten Sie eine Fehlgeburt*(düşük)* oder einen Schwangerschaftsabburuch? *(Abort)* “
• „Nehmen Sie Pille oder benutzen Sie andere Verhütungsmethoden? “
• „Haben Sie Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern?

aHT + Proteinurie → *Präeklampsie?* → Methyldopa. Ausschluss eines *HELLP* (Thrombozytopenie + hämolytische Anämie [Hb ↓ und Bilirubin ↑] + ↓ Haptoglobin + ↑ GOT, GPT, GGT) → Einleitung / Notsectio! Acil Sezeryan

Sexualanamnese ↩️

- „Könnten Sie mir etwas über Ihre Beziehung erzählen?“

(mit einer offenen Frage anfangen.)

- „Wie oft haben Sie Geschlechtsverkehr?“
- „Wann hatten Sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr?“
- „Wie viele Sexualpartner hatten Sie in letzter Zeit?“
- „Hatten Sie schon mal eine sexuell übertragbare Erkrankung?“

Hautheilkunde ↩️

- „Hatten Sie schon einmal einen Hautausschlag?“
- „Wo genau haben Sie den Hautausschlag?“
- „Juckt es?“ Haben Sie Juckreiz?
- „Tut es weh?“
- „Ist die Stelle größer geworden?“
- „Haben Sie eine solche Veränderung / Verfärbung solma / einen Hautausschlag auch irgendwo anders?“
- „Wie sieht der Hautausschlag aus?“
- „Wie groß ist die Stelle, die von Hautausschlag betroffen ist? War das immer so? Wie sah es am Anfang aus?“
- „Ist der Ausschlag trocken oder eher nass?“
- „Welche Farbe hat er?“
- „Ist er schuppend pullu?“
- „Haben Sie auch Bläschen kabarcıklar bemerkt? Wie groß sind sie?

Welche Farbe haben sie? Sind sie mit klarer Flüssigkeit oder mit etwas Eitrigem gefüllt?“

- „Seit wann haben Sie das ... (Muttermal: doğum lekesi) hier?“
- „War es immer so groß / unregelmäßig ...?“
- „Haben Sie eine Blutung bemerkt?“
- „Waren Sie schon mal bei der Hautkrebsvorsorge?“
- „Haben Sie Allergien?“
- „Haben Sie etwas darauf gemacht / darauf geschmiert?“
- „Welche Medikamente nehmen Sie ein?“
- „Hat jemand in der Familie etwas Ähnliches im Moment?“

Orthopädie ↩️

- „Haben Sie ein Taubheitsgefühl / Schmerzen / Kribbeln in Ihrem ……....? Seit wann?“
- „Können Sie den …….. normal bewegen?“
- „Haben Sie bemerkt, ob Ihr .....kälter oder blasser / wärmer oder bläulich wurde?“
- „Sind Sie gestürzt?“
- „Trugen Sie einen Helm?“
- „Sind Sie auf Erde, Sand, Asphalt, Zement usw. gestürzt?“
- „Auf welche Seite sind Sie gefallen?“
- „Sind Sie ohnmächtig geworden?“
- „Haben Sie auch andere Verletzungen, z. B. Abschürfungen?“

****DMS nicht vergessen!*
Durchblutung: Fragen Sie nach der Temperatur: **„Haben Sie das Gefühl, dass Ihre ..... kälter ist?“**
Motorik: **„Können Sie Ihren ..... normal bewegen?“**
Sensibilität: **„Haben Sie Kribbeln / Schmerzen / in Ihren ……..?“**
+ *spezifische Fragen, vom Fall abhängig.*

- „Hatten Sie einen Unfall?``
- „Sind Sie auf dem Kopf gestürzt?``
- „Haben Sie sich am Kopf verletzt? ``

- „War Jemand dabei? ``
- „Haben Sie ungewollt Wasser gelassen? ``
- „Haben Sie sich auf die Zunge gebissen? ``
- „Ist Ihnen schwindelig oder "schwarz vor den Augen"?

Waren Sie ohnmächtig? Wie lange waren Sie ohnmächtig? ``

- „Sehen Sie doppelt? ``
- „Können Sie Ihre Finger bewegen? ``
- „Haben Sie Lähmungen oder Taubheit bemerkt? ``
- „Können Sie Ihre Zehen bewegen? ``
- „Können Sie auftreten? ``
- „Nehmen Sie eine Hormonersatztherapie? `` TVT

Hämatologie

- „Haben Sie Blutungen gehabt? Eventuell auch kleinere Mengen?“
- „Haben Sie *Blut im Erbrochenen / Auswurf / Stuhl / Harn* bemerkt?

Welche Farbe? Eher *schaumig, wässerig oder schleimig? Wie Kaffeesatz?“*

- „Fühlen Sie sich müde?“
- „Haben Sie bemerkt, dass Sie blasser worden sind?“
- „Waren Sie in letzter Zeit häufiger erkältet?“
- „Haben Sie bemerkt, dass Sie in letzter Zeit leichter als üblich blaue Flecken bekommen?“
- „Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß bemerkt?“
- „Haben Sie ungewollt ab- oder zugenommen?

Wie viel und in welchem Zeitraum?“

Infektiologie

Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie einen Verdacht auf eine infektiöse Krankheit haben.
Der „Patient“ sagt häufig in der Prüfung: „Okay, Frau / Herr Doktor, ich bleibe stationär .....
Aber bitte, bitte, würden Sie mir ein Zimmer mit einem netten Patienten geben?
Sonst habe ich zu viel Angst …… Und ich muss mit jemandem reden usw.“
NEIN! Dem Patienten muss erklärt werden, dass man zuerst einige Untersuchungen durchführen muss erst danach wird entschieden, ob er allein oder mit einem anderen Patienten im Zimmer untergebracht wird.

Hämatologie

- „Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
- „Hatten Sie Fieber? Haben Sie das Fieber gemessen?“

- „Hat jemand in Ihrer Familie / in Ihrem Umkreis ähnliche Beschwerden gehabt?“
- „Haben Sie eine Reise im Ausland gemacht?“
- „Arbeiten Sie mit vielen Menschen?“
- „Mit wie vielen Menschen sind Sie in letzter Zeit in Kontakt gekommen?“
- „Haben Sie eine Lymphknotenvergrößerung bemerkt? Wo?

ist sie hart/ weich/ verschieblich oder schmerhaft? Eine oder mehrere?

- *„Haben Sie Kontakt mit jemandem, der mit Covid-19 infiziert ist?''*

Psychiatrie ↩️

- „Was führt Sie zu uns? Erzählen Sie einfach, bitte.“

*** Mit einer offenen Frage beginnen.

- „Wann hat alles begonnen?“
- „Was, glauben Sie, ist der Auslöser dafür?“
- „Okay, das wäre der Hauptgrund. Und was ist noch passiert?“
- „Und seitdem fühlen Sie sich deprimiert?“
- „Weinen Sie oft, auch scheinbar ohne Grund?“
- „Haben Sie Ängste (auch vor kleinen Sachen) oder machen Sie sich viele Sorgen?“
- „Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie diese Ängste bekommen, auch wenn Sie in Sicherheit sind?
- „Haben Sie eine Panikattacke bekommen? Hatten Sie dabei das Gefühl, dass Sie schwer Luft bekommen, dass Sie Herzrasen oder Herzklopfen haben oder sogar, dass Sie sterben könnten?“
- „Ist es Ihnen während dieser Attacken passiert, dass Sie das Gefühl hatten, jemand würde Sie verfolgen oder jemand / etwas wäre in Ihrer Wohnung, der / das Sie verletzen möchte?“
- „Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihren Körper verlassen oder dass manche eigenen Körperteile Ihnen fremd sind?“
- „Haben Sie sich selbst verletzt? Wollen Sie sich verletzen? Wie?“
- „Können Sie **sich** gut **konzentrieren**? z.B. beim Lesen oder Lernen?“

Waren Sie früher schon einmal **bei einem Psychiater oder in psychiatrischer Behandlung?*

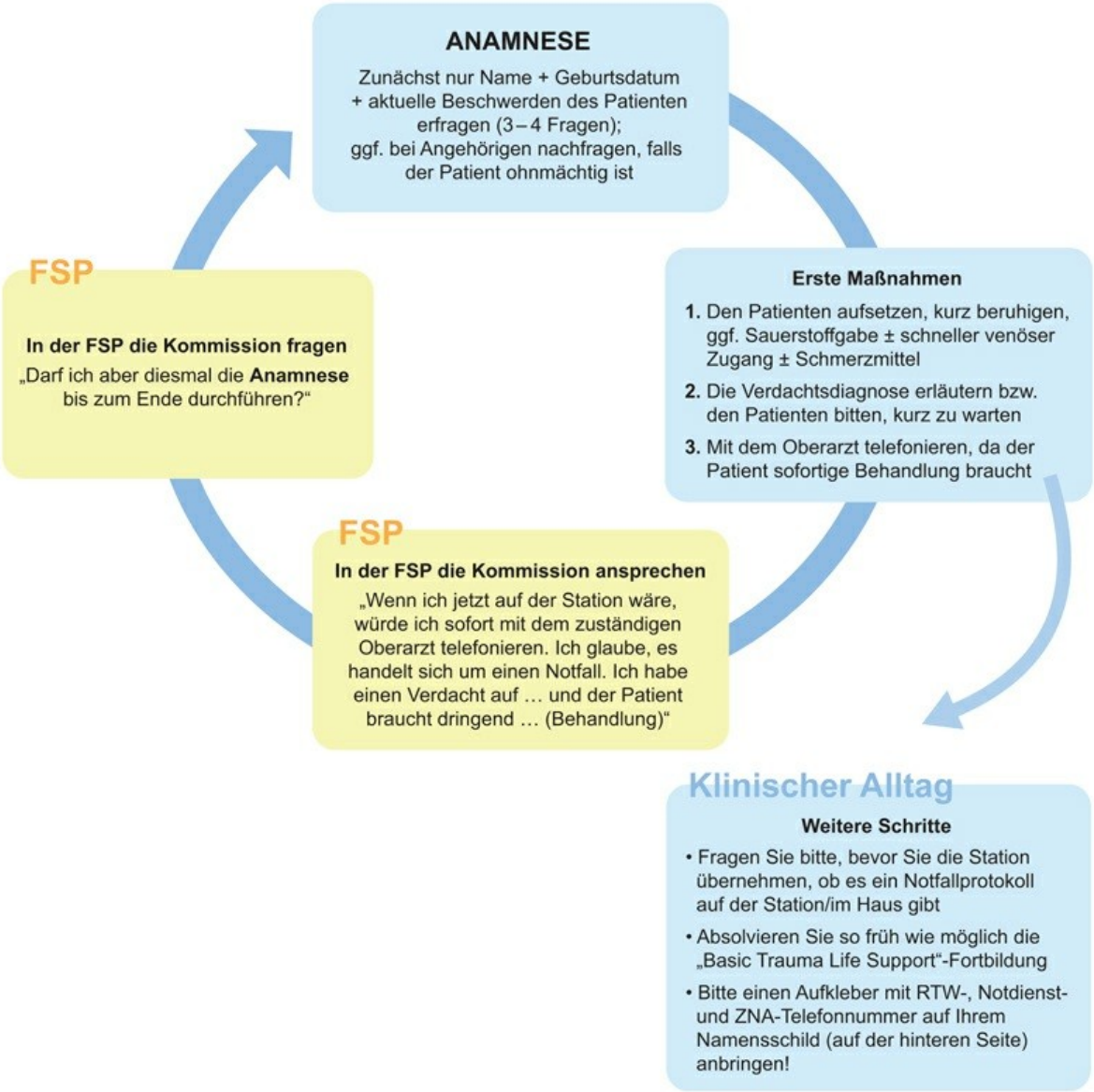
- „Fühlen Sie sich ruhelos?“
- „Waren Sie deswegen früher schon einmal bei einer Psychiatrie?“
- „Leiden Sie unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen?“(wichtige Frage!)***
- „Haben Sie an Selbstmord gedacht? *Haben Sie schon einmal Selbstmord probiert?*

- „ Haben Sie schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen?’’

***Falls der Patient das bejaht → **NOTFALL** → bleibt stationär! Und Rücksprache mit dem OA folgt, aber nach der Anamnese (also nicht wie bei MI, Lungenembolie, Apoplex, GIB).

Handlungsplan im Notfall ↩️

Rasches Handeln und Entscheiden ist wichtig und rettet Leben!
In der FSP wird manchmal geprüft, ob Sie schnell und sicher reagieren, die Situation im Griff haben und Anweisungen geben können, wenn ein Notfall eintritt. Anders als im klinischen Alltag sollten Sie in der FSP aber zur „normalen“ Anamnese zurückkehren, indem Sie die Situation souverän vor der Prüfüngskommisionen darstellen.
Hızlı eylem ve karar verme önemlidir ve hayat kurtarır! FSP bazen hızlı ve kendinden emin bir şekilde tepki verip veremeyeceğinizi, durum üzerinde kontrol sahibi olup olmadığınızı ve bir acil durum ortaya çıktığında talimat verip veremeyeceğinizi test eder. Ancak günlük klinik uygulamanın aksine, FSP'deki "normal" anamneze dönmelisiniz, durumu denetçilerle güvenle yükselterek.



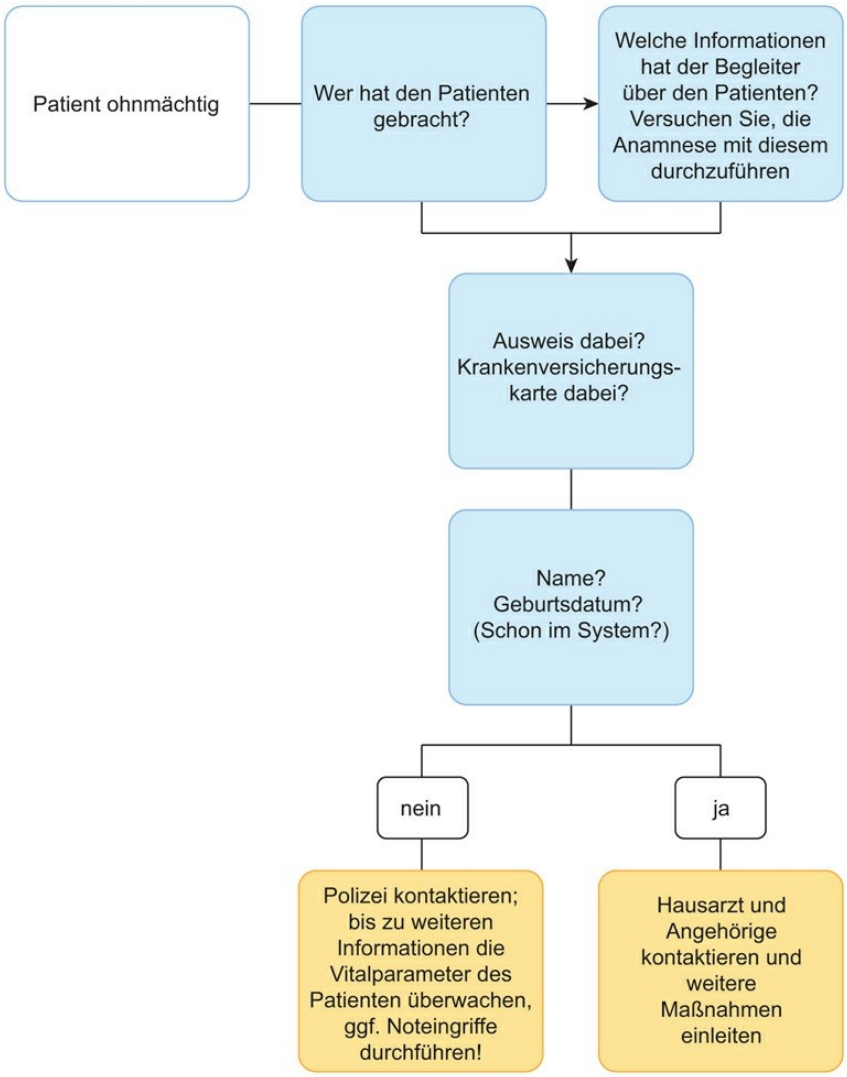
Notfall bei der Anamnese ↩️

***Notfall bei der Anamnese – Schritte in der FSP und im klinischen Alltag

Kommunikative Strategien ↩️

Nicht immer läuft die Anamnese reibungslos, nicht immer beantworten die Patienten brav alle Ihre Fragen und das gilt ganz besonders in der FSP! Die Prüfer testen, ob Sie als Arzt mit schwierigen Patienten in Stresssituationen gut umgehen können und rasch eine Antwort finden. Zeigen Sie, dass Sie das Gespräch steuern können. In den folgenden Beispielen sehen Sie typische Problem-situationen und welche kommunikativen Strategien Sie anwenden können, um diese zu lösen und zu entspannen.
(Anamnez her zaman sorunsuz gitmez, hastalar her zaman tüm sorularınızı görev duygusuyla yanıtlamaz - ve bu özellikle FSP'de geçerlidir! Prüferler, bir doktor olarak, stresli durumlarda zor hastalarla iyi başa çıkıp çıkamayacağınızı ve hızlı bir şekilde bir yanıt bulup bulamayacağınızı test eder. Konuşmayı kontrol edebileceğinizi gösterin. Aşağıdaki örneklerde tipik sorun durumlarını ve bunları çözmek ve rahatlatmak için hangi iletişim stratejilerini kullanabileceğinizi görebilirsiniz.)

Patient ist ohnmächtig***



Kommunikationswege bei schwierigen Patientensituationen ↩️

Patient zeigt keine Krankheitseinsicht ↩️

Der Patient gibt an, er habe <u>angeblich</u> „kein Problem“ und wisse nicht, <u>warum er hier sei.</u>
(İddiaya göre hastanın "hiçbir sorunu yok" ve neden burada olduğunu bilmiyor.)

- Wer hat ihn ins Krankenhaus gebracht? Wieso ist er da?

– „Wer hat Sie hierhergebracht?“ - "Seni buraya kim getirdi?"
– „Wie sind Sie hierhergekommen?“ - "Buraya nasıl geldin?"
–„ Wieso sind Sie hierhergekommen?“ -„ Neden buraya geldin?"

- Ort, Zeit, Person und Situation – orientiert?

– „ Wie heißen Sie? Können Sie mir **Ihr Geburtsdatum** nennen?“
– „ Können Sie mir **das heutige Datum** / den Wochentag / den Monat / die Jahreszeit **nennen**?“ – „Wissen Sie, wo Sie hier sind?“
– „ Wissen Sie, warum Sie hier sind?“

• Beschwerden **in letzter Zeit** (auch wenn er im Moment keine Beschwerden hat)?

– „ Hatten Sie **in letzter Zeit** Schmerzen?“
– „ Haben Sie sich **in letzter Zeit** unwohl gefühlt?“
– „ Litten Sie **in den letzten** Wochen unter Übelkeit, mussten Sie sich übergeben?“

• Auffällige Ereignisse **in letzter Zeit** (mehrfach gestürzt, Amnesie, Aufmerksamkeitsprobleme)?

– „ Ist **in letzter Zeit** etwas Besonderes passiert?“ Son zamanlarda özel bir şey oldu mu?
– „ Hatten Sie einen Unfall?“
– „ Hatten Sie Probleme, sich etwas zu merken / zu erkennen?“
– “Bir şeyi hatırlamakta/tanımakta zorlandınız mı?”

• Konflikte am Arbeitsplatz / in der Familie? Stört ihn etwas im Moment?

– „ Ist **bei Ihnen** privat alles in Ordnung?“
– „ Gibt es Probleme am Arbeitsplatz?“
– „ Verstehen Sie sich gut **mit Ihrer Familie**?“
– „ Belastet Sie **zurzeit** etwas?“

Patient verweigert Zusammenarbeit ↩️

=> Der Patient möchte lieber **mit einem Oberarzt** oder **mit einem anderen Kollegen** sprechen.

• Dem Patienten erklären, dass Sie Ihr Studium abgeschlossen haben und für das Aufnahmegespräch gut ausgebildet sind.

– „ Frau Müller, wenn ich keine ärztliche Ausbildung **hätte**, dürfte ich Ihnen diese Fragen **gar nicht fragen**. “
– „ **Meine Qualifikationen** sind in Deutschland **anerkannt**.“
– „ Ich habe mein Studium **mit guten Noten** abgeschlossen und **habe** schon **viele Aufnahmegespräche durchgeführt**.“

• Dem Patienten erklären, dass alle Entscheidungen danach zusammen **mit einem Oberarzt** getroffen **werden.**

– „ Aber keine Sorge, Frau Müller, nach diesem Gespräch werde ich alles **mit dem Oberarzt besprechen**. Die weiteren Entscheidungen **werden** wir gemeinsam **treffen**. “ – „ Sie sind hier in guten Händen.

" – „ Wir arbeiten im Team und alle Entscheidungen **werden** gemeinsam mit dem Oberarzt **getroffen.**"

• Dem Patienten erklären, dass momentan nur Sie verfügbar sind / dass Sie für die Abteilung X zuständig sind.

– „ Es tut mir leid, Frau Müller, aber **im Moment** sind **alle anderen Kollegen** auf Station oder im OP nicht verfügbar. "

– „ Keine Sorge, Frau Müller, ich bin **für diese Station** zuständig. Sie sind bei mir **in guten Händen**."

• Dem Patienten erklären, dass er, wenn er unbedingt zuerst **mit einem Oberarzt** sprechen möchte, warten muss und bis dahin keine Medikamente gegen **seine Beschwerden** bekommen kann.

– „ Okay, Frau Müller, ich **sehe**, was ich für Sie tun kann, und **versuche**, den Oberarzt schnell wie möglich zu **erreichen**.

=> Die Medikamente **können** erst danach **verabreicht werden**.

– „ In Ordnung, Frau Müller, ich **leite** Ihren Fall an den Oberarzt **weiter**. Er wird Ihnen dann auch die Medikamente verabreichen."

• Dem Patienten erklären, dass er, wenn er unbedingt zuerst mit einem Oberarzt sprechen möchte, warten muss und sich sein Zustand verschlechtern kann / könnte.

– „ Wenn Sie zuerst **mit dem Oberarzt** sprechen möchten, darf ich Ihnen leider noch keine Medikamente **gegen Ihre Beschwerden** geben. Ich **fürchte** allerdings, dass sich **Ihr Zustand** dadurch verschlechtern könnte." – „Na schön, Frau Müller, **nach unserem Gespräch** könnte ich Ihnen die entsprechenden Medikamente verabreichen, sodass sich Ihr Zustand schneller verbessert. Aber okay, wenn Sie gern auf den Oberarzt warten möchten, müssen Sie **Geduld** haben und ich weise Sie klar **auf das Risiko** hin, dass sich **Ihr Zustand** verschlechtern könnte."

Patient spricht nicht klar und deutlich ↩️

Der Patient spricht zu schnell.

• Dem Patienten erklären, dass Sie Notizen machen müssen, er deshalb bitte langsamer sprechen möge.

– „ Langsam bitte, Frau Müller, ich notiere **mir** alles."

Der Patient spricht zu langsam.

• Dem Patienten höflich erklären, dass er ein bisschen Tempo machen solle, weil Sie schnellstmöglich mit der Behandlung beginnen wollen und die Zeit drängt. –Geben Sie gern ein bisschen Gas.

–„ Frau Müller, antworten Sie bitte gern kurz und knapp, denn wir möchten keine Zeit verlieren."

Der Patient spricht zu leise.

• Den Patienten einfach darum bitten, dass er etwas lauter spricht.

– „ Würden Sie bitte etwas **lauter** sprechen, sodass ich Sie **gut** verstehen kann?"

Der Patient spricht im Dialekt.

• Den Patienten höflich bitten, er solle Hochdeutsch sprechen.

– „ Würden Sie bitte **Hochdeutsch** sprechen und das noch einmal wiederholen?“

Der Patient unterbricht Sie mit Fragen. (Hasta sizi sorularla böler.)

• Dem Patienten erklären, dass die Zeit knapp ist und Sie zuerst eine Diagnose stellen wollen, sodass Sie ihn schnell behandeln können; ankündigen, dass Sie danach alle Fragen beantworten werden.

– „ **Lassen Sie** mich bitte aussprechen, Frau Müller,
damit wir schnell durch das Aufnahmegespräch kommen und mit der Therapie beginnen können.

=> **Ihre Fragen** können Sie bitte am Schluss stellen.

Der Patient erzählt zu ausführlich. (Hasta çok şey anlatıyor.)

• Dem Patienten eine effiziente Gesprächsstruktur vorschlagen.

– „ Frau Müller, alle **diese Informationen** sind wichtig,
aber **lassen Sie uns** zuerst über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen.

- „ **Bitte beantworten Sie** zunächts meine Fragen, und zum Schluss **werde** ich Sie **fragen**, ob wir noch etwas vergessen haben.‘‘

Patient fordert sofortige Diagnose ↩️

- Der Patient ist aufgeregt und fordert die sofortige Diagnosestellung.
(Hasta heyecanlanır ve acil teşhis talep eder.)

– „Habe ich Krebs?“ – „Was habe ich?“
– „Brauche ich eine Operation?“ usw.

1. *Sie glauben nicht*, dass der Patient Krebs hat. / eine Operation braucht usw.

=> Frau Müller, **wieso** denken Sie gleich an **das Schlimmste**?
=> **Versuchen Sie** bitte **sich** ein wenig **zu** beruhigen,
damit ich meine Fragen zu Ende **stellen** kann.
=> Ich glaube nicht, dass **es sich bei Ihnen um Krebs handelt,**
aber wir **werden** einige Untersuchungen **durchführen**,
sodass **wir sicher sein können, dass alles in Ordnung ist**.

2. *Sie glauben*, dass der Patient Krebs hat / eine Operation braucht usw.

=> Frau Müller, ich bitte Sie **um** ein wenig **Geduld**.
=> Im Moment **kann** ich leider noch nichts **ausschließen**.
=> Wir **werden** jetzt **dieses Gespräch** zu Ende **führen**,
=> danach **werde** ich **weitere Untersuchungen** für Sie **organisieren**.

=> Wenn dann **alle Ergebnisse** da sind, **können** wir uns besser **orientieren** und hoffentlich eine klare Diagnose **stellen**.
=> Ich **werde** Ihnen alles Schritt für Schritt **erklären**, inklusive der Therapie.
=> Frau Müller, ich glaube, dass eine Operation **notwendig sein könnte.**
=> Aber **versuchen Sie bitte, sich** nicht zu viele Sorgen **zu machen**.
=> Die Kollegen hier sind sehr gut ausgebildet und solche Operationen **werden** bei uns routinemäßig **durchgeführt**.
=> Sie sind hier in guten Händen.

3. *Sie haben keine Ahnung*, was der Patient hat und was Sie in dieser Prüfung überhaupt machen;

=> Frau Müller, ich bitte Sie **um** ein wenig **Geduld**.
=> Im Moment **kann man** leider noch **keine Diagnose stellen**.
=> Ich **werde** Ihren Fall mit dem Oberarzt **besprechen** und wir **werden** zusammen das weitere Vorgehen **abstimmen**.
=> Ich **werde** Ihnen **alles Schritt für Schritt erklären**, inklusive der Therapie.

Es ist nicht schlimm, wenn Sie in der FSP die Diagnose noch nicht stellen können. Schlimm wird es, wenn Sie gar nichts sagen. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie die Fallvorstellung vor einem Oberarzt / Chefarzt machen. Das heißt, er ist da, um Sie zu **unterstützen** und Ihnen zu helfen.
Sie dürfen also Fragen stellen!

- Ein Arzt-Arzt-Gespräch enthält immer Fragen; das heißt, auch Sie können **Fragen stellen** oder um Hilfe bitten.

-„Ja, Herr Professor Y, genau das **wollte** ich mit Ihnen **besprechen**. Ich will ehrlich sein, ich bin mir nicht sicher, was der Patient hat. Deswegen **möchte** ich Sie um **Ihre Meinung** zur **Verdachtdiagnose** bitten.“
"Evet Profesör Y, sizinle tam olarak bunu tartışmak istiyordum. Dürüst olacağım, hastanın ne olduğundan emin değilim. Bu nedenle sizden şüphelenilen tanı hakkında fikrinizi almak istiyorum."

Patient fordert sofortige Therapie ↩️

Patient fordert sofortige Therapie (Hasta acil tedavi talep ediyor)

Der Patient ist ungeduldig und fordert sofortige Behandlung / Medikation.

- Dem Patienten erklären, dass Sie ihm nichts verabreichen können, bevor Sie genau wissen, was ihm felt. Dafür muss er ein paar Fragen beantworten; erst danach kann er die bestmögliche Therapie bekommen.

– „Ich **muss** Sie noch um etwas Geduld bitten, Frau Müller. “
– „**Lassen Sie uns** zuerst genau klären, was Ihnen fehlt. “
–„Dafür **müssen** Sie ein paar Fragen **beantworten**. “
–„Dann kann ich entscheiden, welche Therapie Ihnen am besten hilft.“
– “Sizden biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum Müller Hanım. "Önce tam olarak neyi kaçırdığınızı netleştirelim. "Bunun için birkaç soruya cevap vermen gerekecek. “ –“O zaman hangi terapinin size en iyi şekilde yardımcı olacağına karar verebilirim.”

- Wenn der Patient sehr **aufgeregt** ist, können Sie ggf. Sauerstoff verabreichen. *Doch erst dann*, wenn Ihnen klar ist, was er hat, geben Sie ihm auch ein Schmerzmittel.

– „Frau Müller, ich **verstehe** Ihre Situation und dass Sie Angst / Schmerzen **haben**. “

–„Um **Ihre Situation** zu verbessern, **bekommen Sie** erst einmal etwas Sauerstoff. Dann **wird** es Ihnen wahrscheinlich etwas besser **gehen**. "–„Ein Schmerzmittel darf ich Ihnen aber erst verabreichen, wenn Sie alle meine Fragen **beantwortet** haben.''

– "Müller Hanım, durumunuzu/korktuğunuzu/acı çektiğinizi anlıyorum. "Durumunuzu iyileştirmek için önce biraz oksijen alın. O zaman biraz daha iyi hissedeceksin. "Ama tüm sorularıma cevap verdiğin zaman sana ağrı kesici verebilirim."

- **Beruhigung und Zuversicht:** Wenn der Patient **in Panik** ist und fragt, **ob** er stirbt, **ob** er Krebs hat, **ob** er eine Operation braucht usw.***

„Frau Müller, ich glaube nicht, **dass es sich um Krebs handelt**"

„Machen Sie sich bitte **nicht solche** Gedanken."

„Ich bitte Sie um ein bisschen Geduld. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, **können wir die richtige Diagnose stellen**. => Dann **werden wir alles** gemeinsam **besprechen**."

"Bayan Müller, durumun böyle olduğunu sanmıyorum .....".lütfen böyle endişelenmeyiniz. Tüm sonuçlar gelene kadar biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum, ancak o zaman doğru teşhisi koyabiliriz. O zaman her şeyi birlikte tartışırız."

Arztbrief (Dokumentation) ↩️

Der Arztbrief dokumentiert im Klinikalltag fortlaufend die Ergebnisse – von der stationären Aufnahme bis zur Entlassung des Patienten. Er gibt einen Überblick über den Krankheitsverlauf und die Behandlungsmaßnahmen und ist zugleich die Basis für weitere Schritte der Therapie.
Die FSP-Kandidaten sollen einen Arztbrief an einen Kollegen schreiben, wobei das Gedankenspiel etwa Folgendes ist: Sie nahmen den Patienten gerade stationär auf. Sie haben nur die Anamnese und eine Verdachtsdiagnose. Ein Kollege sagt: „Ich möchte jetzt wissen, *welche Informationen* Sie in der Anamnese erhoben, *welche Verdachtsdiagnose* Sie stellen, welche *Differenzialdiagnosen* infrage kommen und welche *Untersuchungen* notwendig sind, um diese Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Wenn sich diese Diagnose bestätigt, möchte ich auch wissen, wie Sie den Patienten *therapieren* **würden** und wie die *Prognose* für diesen Patienten ist."

(Doktorun mektubu, yatan hasta kabulünden hastanın taburcu edilmesine kadar günlük klinik uygulamadaki sonuçları sürekli olarak belgelemektedir. Hastalığın seyri ve tedavi önlemleri hakkında bir genel bakış sağlar ve ayrıca tedavideki diğer adımlar için temel oluşturur.FSP adaylarından bir meslektaşına bir doktor mektubu yazmaları isteniyor ve düşünce oyunu şuna benziyor: Hastayı yeni hastaneye yatırdınız. Sadece tıbbi geçmişiniz ve şüpheli bir teşhisiniz var. Bir meslektaşım şöyle diyor: "Şimdi anamnezde hangi bilgileri aldığınızı, hangi şüpheli tanıya sahip olduğunuzu, ayırıcı tanıların neler olduğunu ve bu şüpheli tanıyı doğrulamak için hangi testlerin gerekli olduğunu bilmek istiyorum. Bu tanı doğrulanırsa, tedavinizin ne olacağını ve bu hasta için prognozun ne olduğunu bilmek isterim.")

Im klinischen Alltag schreibt man Arztbriefe anhand realer Ereignisse und Ergebnisse.
Dadurch ist alles deutlich strukturierter. Wir bleiben aber hier bei unserem „ Einhorn-Arztbrief''.

Der Arztbrief in der FSP ist eine Kombination aus Epikrise, Verlegungsbrief, Entlassungsbrief und mit ein wenig Blick in die Kristallkugel. Eine Art Einhorn, wenn Sie so wollen. Trotzdem ist davon abzuraten, dass Sie in der FSP Laborwerte oder andere paraklinische Ergebnisse erfinden. (uydurmak) (dies gilt ebenso für das Arzt-Arzt-Gespräch).

Kleine Tipps mit großer Wirkung

Konjunktiv I

Verwenden Sie im Arztbrief möglichst den Konjunktiv I, wenn Sie Informationen darstellen, die Sie vom Patienten erhalten haben, das heißt, wenn Sie die Äußerungen des Patienten in der Anamnese (Haupt- und Nebenbeschwerden, vegetative Anamnese, Vorerkrankungen, Voroperationen, Medikamentenanamnese, Allergien, Noxen, Familienanamnese, Sozialanamnese, s. Beispiele unten) wiedergeben. Das Gleiche gilt bei der Fallvorstellung im Arzt-Arzt-Gespräch – wenn möglich auch dann im **Konjunktiv I** sprechen.

Passiv

Benutzen Sie Passivkonstruktionen, wenn Sie über die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sprechen beziehungsweise darüber schreiben (s. Beispiele unten).

Brief-Formeln

Achten Sie bei der Anrede darauf, den Arztbrief formell zu beginnen:
• Sehr geehrte Frau Prof. / Dr. ...
• Sehr geehrter Herr Prof. / Dr. ...
Schließen Sie den Arztbrief auch formell ab:
• Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dr. Savran
Verwenden Sie diese höflichen Formeln auch dann, wenn Sie in der Prüfung keine Zeit mehr haben, um z. B. über die Therapie zu schreiben. Wer das vergisst, [wird eine 7 Jahre dauernde Allergie auf Schokolade bekommen und]
dem **werden** viele Punkte **abgezogen.**

Über die Anamnese berichten ↩️

Einleitung ↩️

Wenn Sie die Anrede vergessen, kann es vielleicht sogar passieren, dass Sie die Prüfung NICHT bestehen. [und eine Allergie gegen Schokolade bekommen] ☺

• Sehr geehrte Frau Prof. / Dr. X, / Sehr geehrte Frau Kollegin,
•Sehr geehrter Herr Prof. / Dr. Y, / Sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten Ihnen nachfolgend über Frau / Herrn Z, geb. TT.MM.JJJJ, wohnhaft in (ggf. Straße, Hausnr., PLZ) Stadt,
die / der sich am TT.MM.JJJJ in unserer Notaufnahme vorstellte.

Nach der Anrede steht ein Komma, in der zweiten Zeile geht es klein weiter: „wir“ soll hier mit kleinem „w“ geschrieben werden!

• Die Patientin / Der Patient befand sich in ... AZ und ... EZ.
Sie / Er war zu Ort, Zeit, Person und Situation (voll) orientiert / desorientiert.
AZ = Allgemeinzustand: gut, schlecht, schmerzbedingt, leicht/stark/deutlich reduziert ...
EZ = Ernährungszustand: schlank, mager, (prä-)adipös, kachektisch ...

• Frau / Herr Müller hat sich **mit**$^{+Dativ}$ ***seit***$^{+Dativ}$ ....2.....Minut*en* / Stund*en* / Tag*en* / Monat*en* / Jahr*en* bestehend**en** stark**en** epigastrisch**en** Schmerz**en** (N-Deklination!) bei uns vorgestellt.
• Des Weiteren klagt sie / er über ...
• Die Patientin / Der Patient gibt noch an, dass ...

Wenn der Patient die stationäre Aufnahme ablehnt, soll er eine *Entlassung gegen ärztlichen Rat* unterschreiben; erst danach darf er nach Hause. (Hasta hastaneye kabul edilmeyi reddederse, tıbbi tavsiyeye karşı taburculuk imzalamalıdır; ancak o zaman eve gidebilir.)***
Sie müssen dem Patienten erklären, welche Risiken dabei bestehen. Notieren Sie diese Risiken auf

dem Bogen *„Behandlungsverweigerung“* ("tedaviyi reddetme") und ergänzen Sie (oder lassen Sie den Patienten schreiben): „Mir wurden die Risiken der gegen ärztlichen Rat vorzeitigen Entlassung erklärt und ich habe sie verstanden.“ ("Tıbbi tavsiyeye karşı erken taburcu olmanın riskleri bana açıklandı ve ben onları anladım.)
"*Lassen Sie den Patienten dieses Formular am Ende des Gesprächs unterschreiben.* Dasselbe gilt, wenn der Patient eine bestimmte Therapie oder ein Medikament ablehnt.
*** Aynısı, hastalar belirli bir tedaviyi veya ilacı reddederse de geçerlidir.

Arztbrief: Aktuelle Anamnese

Arztbrief : Aktuelle Anamnese - schriftliches Dokument:

würden=> ausstrahlen
wurde=> sei worden

Einleitung + Hauptsymptom

Frau Müller ist eine 49-jährig**e** Patientin, die…
Herr Müller ist ein 49-jährig**er** Patient, **der**….
…. sich heute wegen starke**r** Oberbauchschmerzen bei uns vorstellte.
…. sich heute wegen seit gestern Abend bestehende**r**, starke**r** Oberbauchschmerzen bei uns vorstellte.
Die Schmerzen seien gestern Abend erstmal**s** aufgetreten.

Charakter der Schmerzen

Der Patient beschreibt die Schmerzen **als** kolikartig. (Hasta ağrıyı kolik olarak tanımlıyor.)
Die Schmerzen würden **als** stechend und brennend beschreiben.
Der Patient berichtet/ sagt / gibt an, die Schmerzen seien kolikartig. (Kon I)*
Der Patient berichtet/gibt an, dass die Schmerzen kolikartig seien. (Kon I)*
Die Patientin berichtet, sie habe kolikartig**e** Schmerzen. (Kon I)*
Die Patientin berichtet, die Schmerzen **hätten** einen kolikartigen Charakter. (Kon II)**
Die Patientin berichtet, die Schmerzen **würden** gürtelförmig **in den Rücken ausstrahlen.**
Der Patient berichtet, die Schmerzen **hätten** unterschiedliche Intensität und Charakter.
Er klagt **außerdem** über ein starkes Krankheits**gefühl** und Schwäche.

Intensität der Schmerzen

Der Patient ordnet die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 bei 9 ein. ***
Diese Kopfschmerzen wurden **bei** 8/10 bewertet.***

Charakter und Intensität der Schmerzen in einem Satz

Er beschreibt die Schmerzen **als** kolikartig und ordnet sie auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 9 ein.

Subjektive Symptome

Außerdem klagt er **über** einen Gewichtsverlust, Inappetenz und Fieber bis 39° ständig seit gestern Abend.
Die Fragen nach Medikamenten**einnahme** und **Aufenthalt im Ausland** wurden verneint.

Begleitsymptome

Als Begleitsymptome berichtet er über Fieber bis 39 °C Grad und einen aufgeblähten Bauch mit Druckschmerzen.

Des Weiteren berichtet er, die Schmerzen **seien von** Fieber, Übelkeit und Schüttelfost **begleitet.**

Objektive Symptome

Weiterhin seien **ein** Sklerenikterus sowie Hämatome am ganzen Körper **bei der Patientin** bemerkbar.
bei dem Patienten

Vegetative Anamnese

Die vegetative Anamnese ist/sei unauffällig.
Die vegetative Anamnese ist/sei bis auf Obstipation unauffällig.
Die vegetative Anamnese ist/sei bis auf die oben genannten (o.g.) Symptome unauffällig.
Bei der vegetativen Anamnese sind/seien Insomnie, Fieber und Gewichtsverlust auffällig.

Operative Anamnese

Die operative Vorgesichte sei unauffällig.

Vorerkrankungen

An Vorerkrankungen **gibt** die Patientin/der Patient Mammakarzinom vor 5 J., Cholelithiasis vor 2 Monaten und Pyelonephritis vor 3 J. **an.**
An Vorerkrankungen **gibt** die Patientin/der Patient Mammakarzinom vor 5 J. mit Chemo- und Radiotherapie und anschließender Brustrekonstruktion, Cholelithiasis vor 2 Monaten und Pyelonephritis vor 3 J. **an.**
An Vorerkrankungen **gibt** die Patientin/der Patient mit Chemotherapie behandelten Mammakarzinom vor 5 J. mit anschließender Brustrekonstruktion, Cholelithiasis vor 2 Mon. und Pyelonephritis vor 3 J. **an.**
Außerdem leide die Patientin/der Patient an arterielle Hypertonie und DM Typ II.
Die Patientin/der Patient sei vor 3 J. an einer **Hernia inguinalis** operiert worden. => TANI
Bei der Patient**in/dem** Patient**en** sei vor 3 J. eine **Appendektomie** durchgeführt worden. => Yöntem

***Die meisten Kandidaten neigen hier dazu, „seit" statt „vor" zu schreiben. Dearies, glücklicherweise dauert keine Operation jahrelang! …

Verdachtsdiagnose/Differentialdiagnosen

Die anamnestischen Angaben **deuten** am ehesten **auf** eine akute Pankreatitis **hin.**
Als Differentialdiagnose(n) kommt/kommen Cholezystitis, Cholangitis, Gastritis und Ileus in Betracht.
Differentialdiagnostisch kommt/**kommen** ……..**in Betracht.**

Weiteres Vorgehen/Therapie:

***Zur weiteren Abklärung sollten** eine körperliche Untersuchung, eine Laboruntersuchung (kleines BB, BSG, CRP, Nierenwerte, Leberwerte,), **ein** Röntgen-Thorax, eine Sonographie des Abdomens, eine Röntgenaufnahme des Handgelenks in zwei Ebenen, eine EEG, **ein** EKG, eine EMG, eine CT des Abdomens, eine Abdomen CT und ggf. eine MRT **durchgeführt werden.** gerceklestirilmelidir
Um die Verdachtsdiagnose **zu** bestätigen oder aus**zu**schließen, sollte(n)..... durchgeführt werden.
=>Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, …. süpheli tani dogrulanirsa
… sollte eine Flüssigkeitssubstitution verabreicht werden. verilmelidir
….sollte eine Antibiotikatherapie verschrieben werden.

….sollte eine operative Behandlung in Erwägung gezogen werden. Cerrahi tedavi düsünülmelidir
….sollte eine Chemotherapie eingeleitet werden. baslatilmalidir
….sollte ein onkologisches Konsil angefordert werden. talep edilmelidir
…. sollte eine Appendektomie in Betracht gezogen werden. Appendektomi düsünülmelidir
…..... sollte eine Thromboseprophylaxe eingeleitet werden. baslatilmalidir
....sollte eine Kompressionsstrümpfe, Hochlagerung des Beines, Bewegung, ASS, Clopidogrel, Marcumar, ggf. Thrombolyse und Thrombektomie eingeleitet werden.
....empfehlen wir Bettruhe und Kühlung/eine Antibiotikatherapie.

Allergien:
Beispiele:
-Pollenallergie - **äußert sich durch** Rhinokonjuktivitis allergica.
-Pollenallergie (allergische Rhinokonjuktivitis)
-Hausstauballergie/Milbenallergie/Hausstaubmilbenallergie
-Katzenhaarallergie/Pferdehaarallergie/Katzenallergie/Hundeallergie
-Mehlstauballergie (allergisches Asthma)
-Penizillinallergie
-Laktoseintoleranz – **äußert sich durch** Diarrhö und Meteorismus

Verdachtsdiagnose / Differentialdiagnosen ↩️

Noxen:
Beispiele:
-Nikotin/Zigaretten: 20 P/Y / 20 Zigaretten /Tag seit 20 Jahren / Nichtraucher(in)
-Alkohol: Gelegentlich / täglich ein Bier/ regelmäßiger Alkoholabusus / wurde verneint / kein
-Drogenkonsum wurde verneint /gelegentlich Cannabis /regelmäßiger Cannabiskonsum

Familienanamnese

Weiteres Vorgehen / Therapie ↩️

- Familienanamnese sei unauffällig.
- Der Vater des Patienten **leide an DM Typ II** / **habe an DM TYP II gelitten.**
- Die Mutter der Patientin **sei an den Folgen** eines …MI**s**… **verstorben**. +Genitiv

Beispiele:
-Mutter (70 J.): Niereninsuffizienz , arterielle Hypertonie, Z.n. Appendektomie
-Vater: mit 70 J. **an** Niereninsuffizienz **verstorben**, **litt an** Diabetes mellitus Typ II
-Geschwister :

Sozialanamnese

- Die Patientin / Der Patient sei ledig / verheiratet / verwitwet / in einer Partnerschaft-lebend / geschieden.
- Sie / Er wohne allein / mit seiner Partnerien / ihrem Partner / Ehefrau / Ehemann in einer Wohnung / einem Haus usw., xy. Etage, mit / ohne Aufzug.
- Sie/Er habe ein Kind/xy Kinder/einen Bruder/eine Schwester (aber keinen Kontakt mehr)

- Sie / Er habe einen Hund.
- Frau / Herr Müller arbeite als …….. (z.B. Angestellter in einer Fabrik)

-verheiratet, geschieden, getrennt lebend, verwitwet, ledig, Scheidung, Ehe scheiden, alleinstehend, in Partnerschaft lebend, alleinerziehend, alleinlebend, wohnt in WG,
wohnt im Pflegeheim/Studentenwohnheim/Seniorenresidenz, Obdachlos
-1 Kind / 2 Kinder
-Installateur, selbständig, Beamter-in, Angestellter im öffentlichen Dienst
schlechte Arbeitsbedingungen (Schadstoffe / muss viel stehen / gefährlich / einseitige Belastung bestimmter Körperregionen. -Stress in der Arbeit (am Arbeitsplatz). -familiäre Probleme
Er habe eine -berufliche Probleme

Diagnose, Therapie, Prognose ↩️

- Differenzialdiagnostisch kommt/kommen..... **in** Betracht.
- Eine körperliche Untersuchung wurde durchgeführt. Fizik muayene yapıldı.
- Der Patient wurde stationär aufgenommen. Hasta hastaneye kaldırıldı.
- Bei V. a. ..... wurde Blut abgenommen (BB, CRP, BSG, GOT, GPT, GGT, Krea usw. – abhängig vom Verdacht).
- Urin- und Stuhlprobe wurden entnommen. İdrar ve dışkı örnekleri alındı.
- Ein EKG wurde **ge**schrieben.
- Ein Röntgen-Thorax wurde angefertigt. Göğüs röntgeni çekildi.
- Ein CT von Thorax und Abdomen wurde geplant.
- Ein chirurgisches Konsil zur Mitbeurteilung der Therapie wurde angemeldet.
- Die Ergebnisse stehen noch aus.

  - V. a. = Verdacht auf (die Messung der Vitalparameter)

- Eine X-Therapie wurde eingeleitet. X tedavisi başlandı.
- N (Medikament) wurde **ver**schrieben.
- Eine Sauerstoffgabe wurde angeordnet. Oksijen tedavisi verildi.
- Das X-Gelenk wurde fixiert.
- Eine Operation wurde geplant.
- Der Patient wurde darüber aufgeklärt. Hasta bu konuda bilgilendirildi.
- Ein psychologisches Konsil wurde **an**gemeldet.
- Eine Psychotherapie wurde geplant.
- Je nach **den** Ergebniss**en** der Laboruntersuchungen wird eine entsprechende Therapie eingeleitet.
- Empfehlungen:

➔Wir empfehlen eine Ernährungsberatung, eine Patientenschulung, (hasta eğitimi) Gewichtsabnahme sowie regelmäßige Kontrollen.

• Medikation: ...
• ggf. wurde der Patient für 5 Tage krankgeschrieben.

Das sind nur Beispiele. Notieren Sie bitte keine Peinlichkeiten (unpassenden Untersuchungen), wi z.B „Röntgen-Thorax“ bei einem verstauchten Knöchel oder „EKG“ bei einem eingewachsenen Nagel.

• Die Prognose ist positiv/negativ. Die Prognose ist fraglich und abhängig von der Compliance der Patientin / des Patienten.

Schlussformeln ↩️

Häufige Redemittel für den Arztbrief:	
Therapie **wurde** (Medikamente, O_2 usw.)	**eingeleitet.** *hazırlamak, başlamak*
	angeordnet. *sıralamak, düzenlemek*
	durchgeführt. *yapıp bitirmek*
Medikamente **wurden**	**verabreicht / verschrieben.**
Der Patient **wurde**	**auf…..eingestellt.** *(einstellen auf) :hazır olmak*
Die Therapie	**richtet sich** nach den **klinischen und apparativen** Untersuchungen. Terapi klinik ve enstrümantal muayenelere bağlıdır.
Je nach den Ergebnissen	**der apparativen Untersuchungen wird** eine passende Therapie **eingeleitet.** Teknik incelemelerin sonucuna göre uygun bir tedavi başlatılacak.
Konsil oder Untersuchung **wurde**	**angemeldet.**
	organisiert.
	geplant.
	durchgeführt.
	erbeten. rica etmek, dilemek

Wenn Sie diese Schlussformeln vergessen, werden Ihnen jede Menge Punkte abgezogen. Bu kapanış formüllerini unutursanız çok puan kaybedersiniz.

• Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dr. Savran

⇨ Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus.***

Typische Formulierungen ↩️

• Der Patient wurde bei bekannten ... stationär aufgenommen.
• Bei Verdacht auf …wurde eine entsprechende Untersuchung durchgeführt.
• Zum Ausschluss eines+Genitiv ... wurde ... (Untersuchungen / Konsile)
• Die Ergebnisse / Befunde stehen noch aus. (bekleyen bulgular)
• Es erfolgte eine deutliche / rasche / leider keine Verbesserung.
• Zur weiteren Abklärung wurde der Hausarzt kontaktiert.
Daha fazla açıklama için Hausarzt ile iletişime geçildi.
• Wegen früherer Medikation / Vorerkrankungen / Voroperationen **wird** der Hausarzt **kontaktiert.** => Passiv
• Rücksprache mit dem Hausarzt wegen früherer Medikation / Vorerkrankungen / Voroperationen erfolgt.
• Sie können bestimmte Blutwerte nachbestellen, das heißt, Sie haben die Röhrchen schon abgeschickt, aber etwas vergessen; Sie würden dann im Labor anrufen und etwas nachbestellen.

„Medikamente werden **ver**schrieben. Ein EKG wird **ge**schrieben.``
***„*Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus*“ – eine Ausrede, falls Sie keine Ahnung haben, was der Patient eigentlich hat. Vergessen Sie bitte nicht: Das Ziel der Prüfung ist Kommunikation.
Auch in der Klinik wird es Ihnen passieren, dass Sie die Hilfe des Chefarztes / Oberarztes / Facharztes brauchen. Das ist völlig normal. Dafür stehen sie auch zur Verfügung.
Bei Infektionen (s. Anhang, „Meldepflicht nach dem IfSG“) schreiben Sie bitte:
***„*Das Gesundheitsamt wurde informiert.*“ Das Gesundheitsamt wird informiert.
Bei Kindern / Angehörigen, die allein zu Hause geblieben sind und Hilfe brauchen, schreiben Sie bitte: ***„Der ***psychosoziale*** *Dienst wurde kontaktiert*.“ *Das* ***Sozialamt*** *wird kontaktiert!****

***“Inceleme sonuçları hala beklemede”Hastanın gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yoksa bir bahane. Lütfen unutmayın: Sınavın amacı iletişimdir. Klinikte başhekim / kıdemli hekim / uzman yardımına ihtiyaç duymanız da başınıza gelecektir. Bu tamamen normaldir. Bunun için de mevcutturlar.
Enfeksiyon durumunda (bkz. ek, "IFSG'ye göre bildirim yükümlülüğü"), lütfen şunu yazın:
***"Sağlık departmanı bilgilendirildi."
Evde yalnız bırakılan ve yardıma ihtiyacı olan çocuklar/akrabalar için lütfen
***"Psikososyal servis ile iletişime geçilmiştir" yazınız.

Die Ergebnisse der Untersuchungen **stehen** noch **aus.**

Arztbrief Striktur:

wurde= ist worden

-Herr Alfred **Müller** ist **ein** 85-jährige**r** Patient, der **sich** heute bei uns wegen starke**r** Oberbauchschmerzen **vorstellte.**
-Herr Alfred Möller ist **ein** 85-jährige**r** Patient, **der** heute bei uns nach einem Motorradunfall vom Rettungsdienst **eingeliefert wurde.** (=> worden sei)
-Herr Müller **ist** ein 85-jährige**r** Patient, **der** heute bei uns nach einem Motorradunfall vom Rettungsdienst/von ihrem Mann zu uns gebracht / **eingeliefert wurde.**
-Er **berichtet** über Fatigue, Arthralgie und Urtikaria.
-Außerdem / Darüber hinaus **klagt er** über Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen.
-Er **gibt an**, dass er Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen **habe.**
-Er **gibt an,** er **habe** Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. (Kon I)
-Die Patientin gibt an/berichtet/**erwähnt**, dass die Schmerzen sehr stark **seien.**(Kon I)
-Der Patient **gibt an,** dass die Schmerzen am Sonntag **begonnen hätten**. (Kon II)
-Die vegetative Anamnese sei unauffällig. **(aufgetreten seien)** (Kon I)
-Die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie **unauffällig.**
-Die vegetative Anamnese ist bis auf oben genannte Symptome unauffällig.
-Bei der vegetativen Anamnese **sind** Insomnie, Inappetenz, Fieber, Nachtschweiß, Schüttelfrost und Pruritus **auffällig.**
-An Vorerkrankungen leide der Patient seit 20 J. an Diabetes mellitus, seit der Kindheit an Asthma bronchiale, seit 5 Monaten an Divertikülose und seit 8 J. an Hyperlipidämie.
-**An** Vorerkrankungen **gibt** der Patient Diabetes mellitus, Asthma bronchiale, Divertikel und Hyperlipidämie **an.**
-Vor 6 J. **habe** er an einer Pneumonie **gelitten,** die **stationär behandelt worden sei.**
-Vor 6 J. **sei** er wegen einer Pneumonie 4 Tagen **stationär behandelt worden.**
-Vor 6 J. **erlitt** er eine Pneumonie, die für 4 Tagen **stationär behandelt worden sei.**
-Außerdem **erlitt** der Patient vor 6 J. einen Herzinfarkt.
-Außerdem **habe** der Patient vor 6 J. einen Herzinfarkt **erlitten.**
-**Seitdem** leide er unter Vorhofflimmern (AF).
-Vor 5 J. **sei** bei ihm **einer Vasektomie durchgeführt worden.**
-Vor 5 J. **habe** er **sich einer Vasektomie unterzogen**
-1995 **erlitt** er einen Bänderruptur am Knie, der **konservativ behandelt worden sei.**
-Er **habe sich** vor 2 J. bei einem Unfall eine Femurfraktur **zugezogen**, die **konservativ/operativ/durch Osteosynthese behandelt worden sei.**
-Wegen des Herzinfarktes **sei** dem Patienten **eine PTCA durchgeführt** und zwei Stents **eingesetzt worden.**
-Die operative Vorgeschichte **sei unauffällig.**
-Vor 6 J. **sei** dem Pat. **wegen Urolithiasis einen Ureterkatheter eingesetzt worden.**
-Mit 4 **sei** dem Pat. **wegen Hypakusis** ein Ohrröhrchen **eingesetzt worden.**
-Er habe stressbedingte/belastungsbedingte Diarrhoe. -Der Großzeh wurde amputiert.
-Er nehme gegen DM Lantus 20 IE nach Schema.
-Er habe diabetesbedingte Netzhautsstörrung (diabetische Retinopathie).
-In 2 Wochen **wird** er **sich** einer Hüftgelenk-TEP-OP **unterziehen.**
-Vor 6 J. **habe** er **sich** einer Stentimplantation **unterzogen.**

der Bruch=die Fraktur

sich eine Krankheit zuziehen: bir hastaliga tutulmak
sich einer Op. unterziehen: ameliyat olmak
➔ Zur weiteren Aufklärung **wird** Ihr Hausarzt **kontaktiert.**
➔ Die Diarrhöfrequenz **sei** wesentlich **gestiegen.**
➔ Das Sozialdienst **wird** Informiert.
➔ In einem Pflegeheim **werden die Pflegebedürftigen stationär betreut.**

Arzt-Arzt-Gespräch / Fallvorstellung ↩️

In der Fallvorstellung werden Sie einen neuen Fall einem Kollegen oder Vorgesetzten vorstellen. Der Gesprächspartner ist ein Arzt, daher sollten Sie **Fachsprache verwenden**. Der Zweck ist, dass Sie die wichtigsten Informationen über die Krankheit mitteilen, die Untersuchungen nennen, die Sie angemeldet haben, und die eventuelle Therapie präsentieren.
Die Prüfer werden Sie unterbrechen – das ist aber normal.
Sie dürfen auch Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht wissen! Es soll genau wie im Klinikalltag laufen: Sie stellen den Fall vor, erzählen, was Sie gemacht haben, und bekommen Empfehlungen oder Lösungen von Ihrem Kollegen, wenn diese nötig sind.
Es werden nicht die medizinischen Kenntnisse beurteilt, sondern Ihre Einstellung zum Klinikalltag, Ihre Reaktionen und kommunikativen Fähigkeiten. Erzählen, zuhören, Fragen stellen: ***„Das weiß ich leider nicht“ und „Was meinen Sie, Frau / Herr X?“ dürfen Sie ruhig sagen!

(Vaka sunumunda yeni vakayı bir meslektaşınıza veya Prüfere sunacaksınız. Muhatap bir doktor, bu yüzden lütfen teknik bir dil kullanın. Amaç, hastalık, kayıt olduğunuz muayeneler ve olası tedavi hakkında en önemli bilgileri ona sunmaktır. Sınav görevlileri sizi rahatsız edecek - ama bu normal. Bir şey bilmiyorsanız da soru sorabilirsiniz! Tıpkı günlük klinik uygulama gibi olmalı: Olguyu sunuyorsunuz, ne yaptığınızı anlatıyorsunuz ve gerekirse meslektaşınızdan tavsiye veya çözüm alıyorsunuz. Değerlendirilen tıbbi bilgileriniz değil, günlük klinik uygulamalara karşı tutumunuz, tepkileriniz ve iletişim becerilerinizdir. Konuşun, dinleyin, sorular sorun: ***“Maalesef bilmiyorum” ve “Ne düşünüyorsunuz Bayan / Bay X?” demekten çekinmeyin!)

**Wer einen Arztbrief schreiben kann, kann auch die Fallvorstellung meistern!

Die Fallvorstellung im Arzt-Arzt-Gespräch ist der dritte Teil der FSP „Kandidat versus Prüfer“. Oder eher: Ihre *Chance* zu zeigen, dass Sie motiviert sind, Ihr **Fach Medizin** beherrschen und sich gut auf Deutsch verständigen können.
Doktor-doktor tartışmasındaki vaka sunumu, FSP'nin "aday ve muayene eden kişi"nin üçüncü bölümüdür. Ya da daha doğrusu: motive olduğunuzu, tıp alanında uzmanlaştığınızı ve Almancada iyi iletişim kurabildiğinizi gösterme şansınız.

Sie werden nur Ihre Notizen aus der Anamnese vor sich haben. ***(nicht den Arztbrief!). Deshalb ist mein Vorschlag für Vorbereitung und Training, dass Sie zuerst direkt die Fallvorstellung üben – und den Arztbrief am Ende schreiben.
Sadece tıbbi geçmiş notlarınız önünüzde olacak ***(doktorun mektubu değil!). Bu nedenle, hazırlık ve eğitim için önerim, önce vaka sunumunu doğrudan uygulamanız ve sonunda doktorun mektubunu yazmanızdır.

=> Bekannte Vorerkrankung(en) ist/sind bei ihm/ihr unauffällig.

=> Die Medikamentenanamnese sei unauffällig.
=> Die Fragen nach Tabak-, Alkohol-, Drogenkonsum wurden verneint.
=> Die Familienanamnese sei nicht relevant.

Das Arzt-Arzt-Gespräch ↩️

=> **Guten Tag** Herr / Frau Oberarzt-in,
Einleitung => Wir **haben** einen neuen Patienten / eine neue Patientin, Herr/Frau Müller **aufgenommen** und ich **würde** gerne über ihn/sie **berichten**. => Darf ich? (*„Ja."*) =>Vielen Dank. => Er **ist** 52 Jahre alt, am 03.01.1974 **geboren**, 1,78 m **groß**, 80 kg **schwer**. Hauptbeschwerde => Herr Müller **stellte sich** heute bei uns wegen seit gestern bestehender starker Cephalgie vor. => Er **kam** zu uns ***auf Einweisung des Hausarztes*** wegen seit gestern bestehender starker Cephalgie.
=> Herr Müller **wurde** heute nach einem Motorradunfall in Begleitung seiner Frau zu uns **gebracht** / mit dem Rettungsdienst bei uns **eingeliefert.** *Er **sei** zu Fuß in die Notaufnahme **gekommen**.*
=> Dem Patienten zufolge **sei** der Unfall vor 2 Stunden **passiert** / **geschehen.**
=> Die Beschwerden **würden** seit 5 Tagen **bestehen / auftreten.** Die Intensität **sei** variabel.
=> Die Beschwerden **seien** erstmals, plötzlich/ langsam beim/nach dem Essen **aufgetreten.**
=> Der Patient **beschriebt** die Schmerzen als drückend, ziehend, stechend.....
=> Der Patient **berichtete** über Cephalgie, Tachykardie,.....,.....
=> Außerdem **klagte** er über Zervikalgie,.....,.....,..... (Akk.)
=> Weitere Beschwerden **seien** ……, ……., …… und .....
Nebenbeschwerde => Bei der vegetativen Anamnese **sind**.....,.....,.....und..... **auffällig**. Vegetative Anamnese => **An** Vorerkrankungen **gab** er DM seit 3 J., aHT .....**an.** Vorerkrankungen
=> Er **nehme** gegen aHT Beloc ZOK 20 mg morgens/mittags/abends täglich **an**. Med-Imp => Die operative Vorgeschichte **sei** unauffällig.
OP => Vor 5 J. **habe** er **sich** einer Vasektomie **unterzogen.**
=> Erdnussallergie,..... **sei** / seien bei ihm / ihr **bekannt.**
Allergien => Er **reagiere** allergisch **auf**..... , die sich durch..... **äußere.**/ **habe** eine Laktoseintoleranz. => Er **rauche** 5 Zigaretten täglich seit 5 J. und **trinke** 1-2 Bier täglich seit 5 J. Noxen
=> Die Frage nach Drogenkonsum **wurde verneint.** Er **habe** in der Jugend Marihuana **konsumiert.**
=> Er **trinke** keinen Alkohol. Sie **rauche** E-Zigaretten täglich seit seinem 40. Geburtstag. Zuvor **habe** er 5 Jahre lang 15 Zigaretten pro Tag **geraucht.**
=> In der Familienanamnese **fanden sich** folgende Erkrankungen: Ich komme nun zur Familienanamnese.
pAVK bei dem Vater und Katarakt bei der Mutter.
Familienanamnese Sozialanamnese

• Der Vater **des** Patienten **leide** an Herzinsuffizienz. • Die Mutter **des** Patienten **sei** altersbedingt **verstorben.** • Die Mutter der Patientin **leide** an Mammakarzinom. • Der Vater der Patientin **sei** an Herzinfarkt **verstorben.** • Die Familienanamnese **ist** nicht relevant.	• Der Patient / Die Patientin **sei** verheiratet/ in Scheidung /verwitwet /in einer Partnerschaft lebend/ geschieden usw. und **wohne** allein / mit seinem / ihrem Partner / Partnerin / Ehefrau / Ehemann in einer Wohnung / in einem Haus, 8. Etage, mit / ohne Aufzug. • Der Patient **habe** 2 Kinder. • Der Patient **habe** 2 Hunde. • Der Patient **habe** keine Haustiere. • Frau Müller **arbeite als** Lehrerin.

- ⇨ Der Patient **sei** verheiratet und **lebe** mit seiner Frau zusammen.
- ⇨ Er **habe** zwei gesunde Kinder / eine Tochter und einen Sohn.
  Er **sei** Rentner, aber er **habe** früher als Lehrer **gearbeitet.** Verdachtsdiagnose/Differentialdiagnosen
- ⇨ Die anamnestischen Angaben **deuten** am ehesten **auf** eine akute Appendizitis **hin.**

Dafür **spricht** **plötzlich auftretende Schmerzen** im Epigastrium und
die angegebene Wanderung des Schmerzens in den rechten Unterbauch.

- ⇨ Differentialdiagnostisch **kommen** Pankreatitis, Myokarditis und Divertikulitis **in Betracht.**
- ⇨ Er leide unter Durchschlafstörungen aufgrund von Nykturie. (4-mal pro Nacht)
- ⇨ Herr Müller, **machen** Sie **sich** keine Sorgen. Sie **sind** bei uns in guten Händen.

Es **gibt** auch viele andere Diagnosen, die **zu** Ihrem Krankheitsbild **passen könnten.**
Versuchen Sie bitte, positiv **zu denken.** Wir **müssen** zuerst noch einige Untersuchungen **durchführen. Sollten wir** sofort KU **durchführen, könnten** mögliche Komplikationen frühzeitig **erkannt** und **behandelt werden.**

Weiteres Vorgehen/Therapie:

=> **Zur weiteren Abklärung würde** ich **den** Patient**en** / die Patientin körperlich **untersuchen,** => **Dann würde** ich Blut **abnehmen,**
=> **Danach würde** ich eine Urin- und Stuhluntersuchung/-kultur,
=> **Anschließend würde** ich ein(e) Röntgen/MRT/CT/Echo/EMG/EKG/US **durchführen** und ein onkologisches Konsil **veranlassen.**
=> Um **die Verdachtsdiagnose** zu **bestätigen** oder **auszuschließen,** sollten witere.....,.....,.....,..... durchgeführt werden. ***
=> Um **die Verdachtsdiagnose** zu **bestätigen, müssen** wir **ein Röntgen veranlassen.**
=> **Eine CT ist** notwendig, um **die Verdachtsdiagnose** zu **bestätigen.**
=> **Mit einer MRT** können wir sehen, **ob ein** LWS-Diskusprolaps **vorliegt.**
=> In diesem Fall **ist** eine Koloskopie mit Biopsie **erforderlich.**

- **Als erste Maßnahme würde** ich **den** Patient**en** körperlich **untersuchen,**
mit Inspektion des Pharynx und Auskultation der Lunge.
- **Dann würde** ich **einen** PCR-Test **durchführen.**
- **Als erste Maßnahme würde** ich die Patientin körperlich **untersuchen,**
mit Palpation des Abdomens und Perkussion des Nierenlagers.
- Außerdem **nehme** ich Blut **ab** und **mache** einen Urinstatus. => *TiT*
- Außerdem **nehme** ich Blut **ab** und mache/**veranlasse** eine Stuhl-/Urin**untersuchung**.
- Ich **könnte** Hepatitis-Serologie **bestimmen**, z.B. *anti-HBs-AK, HBs-Antigen, anti-HAV-AK, anti-HCV-AK*

=> Eine körperliche-, Laboruntersuchungen **werden durchgeführt.**
=> Der Patient **wird für drei Tage** stationär **aufgenommen.**
=> Urin- und Stuhlprobe **werden entnommen.**
=> EKG **wird geschrieben.**
=> Röntgen-Thorax **wird in zwei Ebenen angefertigt**. => *2 düzlemde Röntgen yapilir*
=> Ein CT von Thorax und Abdomen **wird geplant.**
=> Ein chirurgisches Konsil **zur Mitbeurteilung der Therapie wird angemeldet.**
=> **Die Ergebnisse stehen noch aus.**
=> Eine entsprechende Therapie **wird eingeleitet**.
=> N (Medikament) **wird verschrieben.**
=> Eine Sauerstoffgabe **wird angeordnet.**
=> Das betroffene Gelenk **wird fixiert.**
=> Eine Operation **wird geplant**.
=> Der Patient **wird** darüber **aufgeklärt.**
=> Ein psychologisches Konsil **wird angemeldet.**
=> Eine Psychotherapie **wird geplant.**
=> **Je nach die Ergebnissen der Untersuchungen wird eine passende Therapie eingeleitet.**
=> Der Patient berichtet über **subjektives Fiebergefühl.**
=> Der Patient berichtet über **krampfartige Schmerzen** im linken Unterbauch.

=> Der Patient klagt über **wässrige, schleimige, blutige, Diarrhön** mit einer Frequenz **bis zu 8-mal** am Tag.
=> **Tachykardie wurde als Herzrasen beschrieben.*** => Das hat zu keiner Minderung beigetragen.
=> Das kann zu..... führen. = Das kann..... verursachen. => Das **wurde** erfolgreich **behandelt.** => Er **sei** als Kind wegen Morbilli mit begleitende Pneumoniae stationär **aufgenommen worden.** => Ich **würde** bei Ihnen eine Ultraschalluntersuchung **durchführen.**

Empfehlungen:

=> Wir **empfehlen** eine **Ernährungsberatung**, eine **Patientenschulung**, **Gewichts-abnahme**.
Ich rate der Patientin, auf das Rauchen zu verzichten/das Rauchen zu vermeiden.

Zur weiteren Abklärung **sollten** die folgenden Maßnahmen **durchgeführt werden.**

- ⇨ **Als erste Maßnahme würde** ich den Patienten **körperlich untersuchen** und **eine Laboruntersuchung veranlassen** (kleines BB, Elektrolyte, BSG, CRP, Herzenzyme, Lipase, sowie einen Urinstatus) **ein Röntgenthorax** in 2 Ebenen, eine Sonographie des Abdomens, eine CT, bei unklaren Befunden eine Gastroskopie **durchgeführt werden.**

Therapie:
Sollte sich **die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage** ich **die folgende Therapien vor:**

- ⇨ stationär **Aufnehme**, Monitoring, EKG, Messung der Sauerstoffsättigung, Blutdruckmessung
- ⇨ Sauerstoffgabe, Anlage von zwei venösen Zugängen, **legen** Infusionstherapie, Volumenersatztherapie, Kreislaufstabilisierung, Flüssigkeitszufuhr bei positiven Befunden, appendektomie bei Perforation der Appendix oder bei einer Peritonitis eine offene Operation (eine Laparotomie)
- ⇨ Analgetika, Spasmolytika, Antiemetika und Antibiotika, Blutprodukte **bestellen** (z.B. Erythrozytenkonzentrate), Lebensstiloptimierung **um** das Risiko **zu** senken.
- ⇨ Wir **verordnen** einen PPI / einen Protonenpumpen-Inhibitor / regelmäßige Verlagskontrollen, Blutzuckereinstellung, Blutdruckeinstellung, intensive stationäre Überwachung, Schmerztherapie nach dem WHO-Stufenschema, Stress vermeiden, Ruhe und Bettruhe.

- ⇨ Frau Schmidt, Sie **sollen** unbedingt **auf** Ihren Zigarettenkonsum **verzichten**!

- ⇨ Lebensstilumstellung wie z.B. Nikotinkarenz, Limitierung des Alkoholkonsums und Gewichtsreduktion, diätische Maßnahmen Kochsalzreduktion, erhöhter Konsum von Gemüse und Früchten, niedriger Fleischkonsum, angepasste körperliche Aktivität sowie Schwimmen oder Radfahren. Ich **schlage vor**, den Lebensstil zu verändern, den Nikotin-konsum zu reduzieren.
- ⇨ Logopädie, Physiotherapie, Massage, Krankengymnastik und Wärmetherapie.
- ⇨ Lokale Kältetherapie und Hochlagerung.
- ⇨ Ich **würde** Sie jetzt körperliche **untersuchen**, Blut **abnehmen** und einen Ultraschall **durchführen** und auch ein Röntgenbild **veranlassen**. Danach **würde ich** Ihr Röntgenbild **ansehen** und dann mit dem Oberarzt **sprechen.** Danach **sage** ich Ihnen sofort **Bescheid.**
- ⇨ **Aufgrund der Symptomatik habe** ich den Verdacht auf **einen Schub der Colitis ülcerosa.** Belirtilere dayanarak ülseratif kolitin nüksettiğinden şüpheleniyorum.
- ⇨ Die Symptome **sprechen für** ein Kolonkarzinom. Der Gegenbegriff da**von wäre** eine CED.

Diagnostische Maßnahmen ↩

- ⇨ Als erste Maßnahme **würde** ich den Patienten körperlich **untersuchen**, ich **veranlasse** ein EKG, um eine Herzrhythmusstörung auszuschließen.
- ⇨ Bitte **vereinbaren Sie** einen Kontrolltermin in 7 Tagen.
  Der Patient **wird** für 5 Tage **krankgeschrieben.**
- ⇨ Die häufigste Ursache dafür **ist**... => Es **kommt** nicht häufig **vor.** Bu çok sık olmaz.
- ⇨ Man **sollte** *alle 5 Jahre* bei Risikopatienten die Untersuchung **wiederholen.**
- ⇨ Herr Müller, das kann ich sehr gut verstehen. Trotzdem würde ich Ihnen empfehlen, bei uns zu bleiben. Sie sind *mit starken Schmerzen* gekommen und wir müssen genau untersuchen, warum Sie diese Schmerzen haben. Es könnte für Sie im Moment gefährlich

sein, nach Hause zu gehen. Bestimmt finden wir eine Lösung *dafür*, wer sich um *Ihre Mutter / Ihre Kinder* kümmern kann.

⇨ Ich **hoffe**, dass Sie jetzt ganz schnell wieder **auf die Beine kommen.**

Glasgow-Koma-Skala dient insbesondere in der Intensivmedizin der Abschätzung einer Bewusstseinsstörung. Glasgow koma skalası, özellikle yoğun bakım tıbbında bilinç bozukluğunu değerlendirmek için kullanılır.		
Öffnen der Augen (gözleri açma)		
spontan	kendiliğinden	4 Punkte
bei Ansprache	sesli uyarana	3 Punkte
bei Schmerzreiz	ağrılı uyarana	2 Punkte
kein Öffnen der Augen	yok	1 Punkt
Beste verbale Antwort (sözel cevap)		
konversationsfähig,orientiert	yeterli, oryante	5 Punkte
konversationsfähig,desorientiert	uygunsuz konuşma	4 Punkte
„Wortsalat“	kelime salatasi	3 Punkte
sinnlose Laute	anlamsız sözler	2 Punkte
Ø verbale Antwort	yok	1 Punkt
Beste motorische Antwort (motor cevap)		
bei Aufforderung	istekleri yapma	6 Punkte
gezielte Bewegung bei Schmerzreiz	dokunma ile hareket	5 Punkte
ungezielte Bewegung bei Schmerzreiz	ağrıya tepki olarak hareket	4 Punkte
Beugesynergismen	dekortike postür	3 Punkte
Strecksynergismen	deserebre postür	2 Punkte
Ø motorische Reaktion	yok	1 Punkt
Gesamtpunktzahl (3–15 Punkte)		
Interpretation		
15–14 Punkte	keine Bewusstseinsstörung	keine diesbezüglichen Maßnahmen
13–12 Punkte	leichte Bewusstseinsstörung	Monitoring
11–9 Punkte	mittelschwere Bewusstseinsstörung	Intubationsbereitschaft entübasyon için hazır olma
8–3 Punkte	schwere Bewusstseinsstörung, komatös	Schutzintubation wegen fehlender Schutzreflexe Koruyucu reflekslerin olmaması nedeniyle koruyucu entübasyon

FSP Vorbereitungskurs – Notizen

A: Guten Tag, mein Name *ist* ..... und ich *bin* hier / in der Praxis / in der Notaufnahme Assistenzarzt / neuer Arzt.
Was *kann* ich für Sie *tun*?

Sınavda önemli olan uzun cümleler *zu bilden* değil, kurze, korrekte und verständliche Sätze *zu bilden.*

Bir Prüfer olan kurs hocam der ki:
„Wenn du im Alltag normal *sprichst*, *sprich* im Examen genauso."

Ezber yapanlardan *hoşlanmıyoruz*, bazen sıkıştırmaya yönelik sorular *soruyoruz*.
Von natürlich sprechenden Kandidaten *sind* wir immer zufriedener.
Sosyal medya gruplarında yazılanları hiç *önemsemeyin*.

A: Ich *brauche* jetzt ein paar persönliche Daten und dann *sprechen* wir weiter, ok.

Hastanede ve Notaufnahme'de Assistenzarzt, Praxis'te neuer Arzt *denebilir*.
Praxis'te de asistan Dr. *olabilirsin*, ama sınavda genelde Praxis'te Hausarzt olarak kabul *ederler*.

Bu yüzden bazıları vertretender Arzt / Hausarzt vs. de *diyor*.
Ama kafan karışıp ne söyleyeceğini *bilemezsen*, neuer Arzt *diyebilirsin*.

Yani hastayı ilk defa *göreceksin* ve sorduğun hiçbir soru garip karşılanmaz.

„Neuer Arzt" tabirini hem in der Notaufnahme als auch in der Praxis *kullanabilirsin*.

Öykünün sonunda anamnez konuşmasını *bitirip* hastaya söz *vermeden* önce şöyle *söylüyoruz*:

A: Ich *habe* alle wichtigen Fragen *gestellt*.
Möchten Sie etwas *hinzufügen* oder *haben* Sie Fragen?

P: Herr Doktor, was *denken* Sie, was *ist* los mit mir? /
Was *machen* Sie jetzt?

A: Herr/Frau ..., Sie *haben* wahrscheinlich eine Gastritis, Pankreatitis ...

Ich *untersuche* Sie jetzt (körperlich) und *nehme* Ihnen Blut *ab*, und dann *sehen* wir weiter.

Vielleicht *müssen* wir Sie zu einem Facharzt *überweisen*.

(Burada können *kullanılırsa*, göndermek istiyorum manasına *gelir*.
Müssen *dersek*, gerekirse göndereceğim anlamında.)

Burada „Ich *spreche* noch mit dem Oberarzt“ *demene* gerek yok.
Bu hasta için kötü bir algı *olur*.

Sen *bist* der Arzt und *stellst* eine Diagnose und *behandelst* den Patienten.
Düşündüğün tanıyı *söyle*, yapacaklarını *söyle*, sorulara cevap *ver*, yeter.

Wie alt *sind* Sie und wann *sind* Sie *geboren*?

Bu soruları ayrı ayrı *sormak* daha mantıklı olabilir.
Çünkü böyle *sorunca* hasta ikisini beraber *söylüyor* ve sayıları *anlamak* zor.

Wie groß *sind* Sie, wie viel *wiegen* Sie? /
Wie schwer *sind* Sie?

Kilo için ikisi de *sorulabilir*.
Ama ilk soru daha naziktir, özellikle bayanlar için.

A: Also Herr/Frau ..., Sie *haben* gesagt, dass ...

P: Ja, richtig Herr Dr.

Aralarda ne soracağını *unuttuğunda* vs. zaman *kazanmak* için „Also“ kelimesini *kullanabilirsin*.
Aralarda sık sık „also“ *demekte* hiç sıkıntı yok.

Alternatif:
„Gut, Frau/Herr …“

Ama
„Okay, Frau/Herr …“ *kullanmak* yanlış, „Okay“ *deme*.

- COVID düşündüğüm bir hastada: Hastaya COVID için PCR testi yapacağımı söyledim.
  Hasta: „Test sonucu çıkana kadar ne yapmam lazım? Pozitif veya negatif çıkarsa ne olacak?“ diye *sordu*.
  Karantinada kalması gerektiğini *söyledim*. Sonra:

A: Mit einem negativen Test *können* Sie die **Quarantäne** *beenden* und wieder nach draußen *gehen*.
Mit einem positiven Test *können* Sie sich nach **10 Tagen** *freitesten*.
Melden Sie sich bitte beim **Gesundheitsamt**.

(Negatif bir test ile karantinayı bitirebilir ve tekrar dışarı çıkabilirsiniz. Olumlu bir test ile **10** gün sonra kendinizi ücretsiz test edebilirsiniz. Lütfen sağlık departmanına bildirin.)

Prüfer Almanya'nın sağlık sistemi kurallarını bilmemizi *beklemiş*.
Hasta yukarıdaki gibi sorular *sorarsa* „Ich weiß es nicht“ *demek* pek iyi olmazmış.

- Boğaz ağrısı ve burun akıntısı olan bir hasta bana ilaç yaz dedi. Buna karşılık şunu *söylüyoruz*:

○ Ich *verschreibe* Ihnen ein Schmerzmittel und **abschwellende Nasentropfen**,
aber Sie *dürfen* sie nicht länger als **5 Tage** *anwenden*, weil sie abhängig *machen können*.

(Size ağrı kesici ve burun tıkanıklığını giderici burun damlası yazacağım ama **5** günden fazla kullanmamalısınız çünkü bağımlılık yapabilir.)

- Hasta ile **Vorerkrankungen** hakkında *konuşurken* şu aşağıdaki **3** soru mutlaka *sorulmalı*.
  İlk soruyu *sorduğunda* hepsini *anlatır* diye *düşünmemeli*:

○ *Haben* Sie irgendwelche **Vorerkrankungen**?
○ *Waren* Sie schon mal im **Krankenhaus** oder *wurden* Sie schon einmal *operiert*?
○ *Gibt* es noch weitere **Erkrankungen**, **Unfälle** oder **Operationen**?

- Hastanın önemli olduğunu düşündüğün bir hastalığı var ve üstüne *gidiyorsun* diyelim.
  Örn: Göğüs ağrısı ile gelen hastada **aHT** öyküsü gibi.
  Hastalığın ne durumda olduğunu, tedavinin nasıl *gittiğini* mutlaka *sor*:

○ *Wann waren* Sie das letzte Mal zur **Kontrolle**?
○ *Wann wurden* Ihre Werte das letzte Mal *kontrolliert*?
○ *Notieren* Sie Ihren **Blutdruck** / **Blutzucker** täglich?

- Hasta biraz yaşlıysa **Familienanamnese** *alırken* şöyle *başlayabilirsiniz*:

○ *Leben* Ihre Eltern noch?
○ *Haben* oder *hatten* Ihre Eltern irgendwelche **Erkrankungen**?

- Hastaya tanısından *bahsederken* ve hastalığını *açıklarken*:

○ Herr/Frau Müller, die **anamnestischen Angaben** *deuten* auf eine
→ **Harnblasenentzündung** hin.
○ Herr/Frau Müller, Sie *haben* wahrscheinlich eine
→ **Harnblasenentzündung**.

Beispiel:

▪ Herr/Frau Müller, die anamnestischen Angaben deuten auf eine **Magenschleimhautentzündung** (Gastritis) hin. Ich verschreibe Ihnen ein Medikament, das die Magensäure neutralisiert. Sie können einen sogenannten **Protonenpumpenhemmer** einnehmen. Dadurch wird die Produktion der Magensäure reduziert.

▪ Frau Müller, Sie haben wahrscheinlich eine **Herzschwäche** (Herzinsuffizienz). Das ist eine komplizierte Erkrankung, aber wir können Sie mit verschiedenen Medikamenten behandeln. Ich verschreibe Ihnen etwas gegen **die aktuellen Symptome** und etwas gegen **Begleiterkrankungen**, z. B. Bluthochdruck. Bewegen Sie sich regelmäßig und reduzieren Sie Ihren Alkohol- und Nikotinkonsum.

▪ Herr Müller, Sie haben wahrscheinlich eine **Gefäßerkrankung im Bein**, die sogenannte **pAVK** (periphere arterielle Verschlusskrankheit). Bei dieser Krankheit ist ein Gefäß im Bein verengt. Das Bein wird nicht genug mit Sauerstoff versorgt, deshalb ist es so blass und Sie haben diese Schmerzen. Wir müssen herausfinden, **welche Gefäße betroffen sind**.

- **In einem pAVK-Fall** habe ich dem Patienten gesagt, dass er mit dem Rauchen aufhören muss.
  „Nasıl yapacağım, çok zor“ dedi. Almanya’da **Raucherentwöhnungskurse** varmış.
  (**Bei einem Raucherentwöhnungsprogramm handelt es sich um einen multimodalen Therapieansatz.**)
  Bunları **die Krankenkassen organisieren bzw. unterstützen**. Şu şekilde açıkladık:
  ○ Informieren Sie sich **bitte einmal bei Ihrer Krankenkasse**.
  Es gibt verschiedene Programme, **um mit dem Rauchen aufzuhören**.
  „Jede Zigarette weniger ist ein wichtiger Schritt.“
  ○ **„Sie sollten Ihren Alkoholkonsum einschränken.“**

  Machen wir jetzt die Untersuchung und sehen wir weiter.
  Hasta ile konuşurken böyle **Umgangssprache** kullanmak öneriliyor.

  ○ **Bei einem Patienten, bei dem ich eine Cholezystitis vermute**, fragte der Patient:
  „Was soll ich jetzt machen, soll ich nach Hause gehen?“
  Yatırmak gerektiğini söylüyoruz:

1. **Wir nehmen Sie stationär auf.**
2. **Wir müssen Sie stationär aufnehmen.**
3. **Sie müssen bei uns bleiben.**

- **Pankreatit** düşündüğüm bir hastaya sorusu üzerine **Pankreatit** sebeplerini *saydım*.
  Kanser dediğimde hasta çok *korktu*.
  „Yoksa ben kanser miyim?“ diye tepki *gösterdi*.
  Şu şekilde cevap *verdik*:

○ – Ich *will* nur *sichergehen*.
(Sadece emin olmak istiyorum.)

- Hastaya **Apandisit** düşündüğümü ve opere olması gerektiğini *söyledim*.
  Ne zaman taburcu olurum diye *sordu*.
  Cevaben:

○ Eine **Blinddarmentfernung**, sogenannte **Appendektomie**, *ist* relativ einfach.
○ Sie *werden* operiert und dann in einigen Tagen *entlassen werden*.
○ Wir *müssen* nur sicher *sein*, dass es keine **Komplikationen** *gibt*.

○ Hasta *geldi*, çok ağrısı *var*, devam *edemiyor*.
Anamnezi *kesip* önce hastaya ilaç *veriyoruz*, sonra devam *edeceğiz*.
İlaç vereceğinizi *söyleyip* hastayı *rahatlattıktan* sonra
(Prüfer burada tamam devam et, ilacı verdin manasında sözlü veya hareketle bir işaret *veriyor*).
Anamnese’ye devam etmeden önce şimdi nasıl olduğunu *sorup* giriş *yapıyoruz*:
○ – Wie *geht* es Ihnen jetzt?

- Hastaya **Diabetes mellitus (DM)** olabileceğini *söyledim*.
  Annesi insülin *kullanıyormuş*, ben de mi *kullanacağım* diye *sordu*.
  Cevaben:

○ Wir *müssen* erst *feststellen*, wie **ausgeprägt** die **Erkrankung** *ist*.
○ Das *ist* abhängig von Ihren **Blutzuckerwerten**.
– Önce hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu *belirlemeliyiz*.
– Bu, kan şekeri seviyenize *bağlıdır*.

- **Heißhungerattacken** → açlık atakları.
  DM için önemli.

○ Hasta evde şekerimi nasıl *ölçeceğim* dedi.
Şöyle tarif *ettik*:
– Sie *brauchen* **Lanzette**, **Teststreifen** und ein **Blutzuckermessgerät**.
– *Stechen* Sie mit der **Lanzette** in die **Fingerkuppe** und *nehmen* mit dem **Teststreifen** einen Tropfen **Blut**.
– Danach *schieben* Sie den **Teststreifen** ins **Gerät**.
***

• Es sei auch ganz wichtig zu befragen, ob der Patient **eine Schulung** über die Behandlung von DM mit Insulin hatte!
-Wenn nicht, dann sollen wir es während des Krankenhaus-Aufenthaltes auch erledigen.
• Dann sollte ich den Patienten aufklären, wie es jetzt weiter geht.

• Hastanın DM'nin insülin ile nasıl tedavi edileceği konusunda herhangi bir eğitimi olup olmadığının sorulması da çok önemliydi! Değilse, o zaman hastanede kalış sırasında da yapmalıyız. • Daha sonra hastaya ne yapacağını açıklamalıyım.

- Hasta bir şey yaptığını söyledi ve siz de bunu onaylıyorsunuz:

○ Sie *haben* das richtig *gemacht*. / Sie *machen* das richtig.

- **Gicht** ön tanısı ile başvuran bir hasta:
  „Neden **Harnsäure** artıyor da **Gicht** oluyor?
  Ben her zaman da çok et *yerdim*, ama hiçbir şey *olmazdı*. Bana bunu *erklären können* misiniz?“ dedi.

○ Natürlich *kann* ich das *erklären*.
Mit dem Alter *verändern* sich unsere Körperfunktionen und unsere **Nieren** *können* nicht mehr alle **Abfallstoffe** *ausscheiden*.
○ Alkohol, Fleisch und besonders **Innereien** *enthalten* sogenannte **Purine**.
○ Diese **Purine** *erhöhen* die **Harnsäure** im **Blut**.
Die **Harnsäure** *sammelt* sich in den **Gelenken** und *kann* Schmerzen *verursachen*.
○ **Innereien** → **Leber**, **Niere**, **Herz**

○ Hasta geldi, şiddetli ağrısı var, ama sen muayeneyi maskelemesin diye ağrı kesiciyi muayenenin sonunda vermek istiyorsun ve hastaya o zamana kadar dayanabilir misin diye soruyorsun.
Biz bunu yapıyoruz ama hocamız dedi ki:
Kesinlikle hastaya böyle söylemeyin. Hastanın ağrısı varsa mutlaka ilacını verin ve sonra devam edin.
○ *Können* Sie das *aushalten*?

○ Hasta elinin üzerine düşmüş.
Ne tarafa, iç tarafına mı, dış tarafına mı?
○ *Sind* Sie auf die Innen- oder Außenseite Ihrer **Hand** *gefallen*?

- Hasta ayağını burkmuş.
  „Operasyon mu olacak, ne kadar süre üstüne basamayacağım?“ dedi.
  Muayene ettikten sonra kesin konuşabilirim / duruma bağlı dedim. Eğer kırık varsa:

○ Wenn der **Fuß** *gebrochen* ist, …
○ Vielleicht *ist* der **Fuß** *gebrochen*, …
○ Sie *müssen* den **Fuß** *schonen*.
In **4–6** (für **Distorsion**) / **10** (für **Fraktur**) Wochen *sind* Sie wieder fit.

- Yaşı biraz ileri olan hastada hâlâ **Menstruation** olup olmadığını sorarken **noch** kullanıyoruz:

○ *Haben* Sie noch Ihre **Regelblutung**?

SiSTEMLERE / SiKAYETLERE YÖNELiK ÖNEMLi ANAMNEZ SORULARI:

Husten mit Auswurf:

- Können Sie den Auswurf beschreiben?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?
- Gibt es einen Auslöser für den Husten?
- Haben Sie einen Auslöser bemerkt?
- Was verbessert oder verschlechtert den Husten?
- Tritt der Husten **zu einer bestimmten Zeit** auf?
- Haben Sie Probleme beim Atmen? (wenn ja) Beim Ein- oder Ausatmen?
- Seit wann haben Sie den Husten/die Beschwerden?
- Sind Sie gegen Covid 19 geimpft?
- Was machen Sie beruflich?

Atembeschwerden:

- Seit wann haben Sie die Beschwerden?
- Können Sie die Beschwerden beschreiben?

- Gibt es einen Auslöser für den Husten?/Haben Sie einen Auslöser bemerkt?
- Haben Sie Probleme beim Atmen? (wenn ja) Beim Ein- oder Ausatmen?
- Haben Sie auch Husten?
- Rauchen Sie?
- Was machen Sie beruflich?
- Haben Sie die Atembeschwerden nur **bei Belastung** oder auch **in Ruhe**?
- Wie viele Treppen können Sie ohne Pause/beschwerdefrei steigen / laufen?

Brustschmerzen:

- Yukaridaki sorulara ek olarak:
- Strahlen die Schmerzen aus?
- Können Sie die Schmerzen beschreiben, z.B. drückend oder stehend?
- Können Sie mir zeigen, wo genau die Schmerzen sind?
- Sind Sie gefallen oder waren Sie bewusstlos?

Herzerkrankungen:

- Haben Sie Atemprobleme, wenn Sie flach liegen?
- Benutzen Sie mehrere Kissen beim Schlafen?
- Haben Sie Husten oder geschwollene Beine?
- Haben Sie Schmerzen im Brustkorb oder ein Engegefühl?
- Wie viele Treppen können Sie beschwerdefrei laufen?
- Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte?
- War Ihnen schwindlig?/Waren Sie ohnmächtig?
- Haben Sie Veränderungen bei Ihrem Herzschlag bemerkt, zum Beispiel Herzrasen oder Herzstolpern?
- Hatten Sie Schweißausbrüche?
- Gibt es **in Ihrer Familie** Herzerkrankungen, zum Beispiel Herzschwäche oder Herzinfarkt?
- Haben die Schmerzen ausgestrahlt, zum Beispiel **in den linken Arm?**

Gefäßerkrankungen:

- Gibt es in Ihrer Familie Gefäßerkrankungen?
- Haben Sie vor Kurzem eine längere Reise gemacht, zum Beispiel mit dem Auto oder Flugzeug?
- Machen Sie Hormonersatztherapie?
- Ist bei Ihnen eine Herzerkrankung bekannt?
- Lassen Sie diese (Vor)erkrankungen regelmäßig kontrollieren?
- Nehmen Sie die Pille?
- Nehmen Sie andere hormonelle Verhütungsmittel?
- Fühlen Sie sich auch schwach und müde?
- Was machen Sie beruflich? Sitzen Sie viel?
- **Fühlt sich** Ihr Bein heiß/kühl **an**?
- Ist Ihr Bein blass/bläulich/gerötet?

- Ist Ihr Bein geschwollen?
- Wurden Sie kürzlich operiert?
- Hatten Sie ähnliche Beschwerden schon mal in Vergangenheit?

Leber- und Gallenblasenerkrankungen:

- Wie ist Ihr Appetit?
- Waren Sie **in der letzten Zeit** im Ausland? Wo waren Sie?
- Gibt es in ihrer Familie Lebererkrankungen?
- Sind Sie gegen Hepatitis geimpft?
- Haben Sie erbrochen?
- Ist die Übelkeit mit dem Essen verbunden?
- Gibt es oder gab es **in Ihrem Umkreis** ähnliche Beschwerden?
- Haben Sie **ab**- oder **zu**genommen?

Pankreas- und Milzerkrankungen:

- Haben Sie Verdauungsprobleme?
- Hatten Sie einen Unfall?
- Haben Sie mehr Durst als gewöhnlich?
- Sind die Schmerzen gürtelförmig?
- Leiden Sie unter Müdigkeit und Abgeschlagenheit?
- Gibt es in Ihrer Familie Krebserkrankung?
- Hat sich Farbe oder Konsistenz Ihres Stuhls verändert?
- Ist die Übelkeit mit dem Essen verbunden?
- Gehen Sie öfter zur Toilette?

Magenerkrankungen:

- Wo **genau** sind die Schmerzen?
- Wie ist Ihr Appetit?
- Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?
- Haben Sie Sodbrennen?
- Hängen die Beschwerden mit dem Essen zusammen?

- Wann treten die Schmerzen auf? **Vor oder nach dem Essen**?
- Essen Sie oft stark gewürzte Speisen?
- Haben Sie erbrochen?
- War das Erbrochene blutig?
- Sieht das Erbrochene aus **wie Kaffeesatz**?
- Fühlen Sie sich voll und aufgebläht?
- Haben Sie Blähungen?
- Müssen Sie oft aufstoßen?
- Trinken Sie viel Kaffee? Wie viel?

- Fühlen Sie sich gestresst?
- Gibt es in ihrer Familie Krebs?
- Haben Sie ungewollt abgenommen?

Darmerkrankungen:

- Wie sind Farbe und Konsistenz de**s** Stuhl**s**?
- **Was** und **wo** und **wann** haben Sie **zuletzt gegessen**?
- Wir ernähren Sie sich?
- Haben Sie Probleme auf der Arbeit oder im Privatleben?
- **Leiden** Sie **unter** Durchfall oder Verstopfung?
- Ist **bei Ihnen** eine Unverträglichkeit (gegen irgendwelche Lebensmittel) bekannt?
- Haben Sie Fieber oder Nachtschweiß?
- Haben Sie Menstruationsbeschwerden?
- Wann war die letzte Regelblutung?

Harnapparat und Geschlechtsorgane:

- Haben Sie Schmerzen in den **Flanken**?
- Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen?
- Haben Sie Schmerzen oder ein **brennendes Gefühl**?
- Können Sie **den Urin bis zur Toilette** halten?
- Hat sich Ihre **Urinmenge** verändert?
- Hat sich Geruch oder Farbe des Urins verändert?
- Wieviel trinken Sie pro Tag?
- Haben Sie **Blut im Urin** bemerkt?
- Müssen Sie öfter auf die Toilette als gewöhnlich?
- **Verlieren Sie** manchmal Urin zum Beispiel beim Laufen, Husten oder Niesen?
- Haben Sie Schwellungen **an** Armen, Beinen oder im Gesicht?
- Haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr?
- Ist Ihre Periode regelmäßig?
- Wann war die letzte Periode?

Gynäkologische Anamnese, Sexualverhalten, Verhütung:

- Waren **Sie schon mal** schwanger?
- Verhüten Sie? Wie?
- Haben Sie einen **unangenehmen Geruch** bemerkt?
- Haben Sie häufig wechselnde Sexualpartner?
- **Könnten Sie schwanger sein?**
- **Verlief** die Schwangerschaft normal?

- Wann waren Sie **das letzte Mal** beim Frauenarzt?
- Hängen die Schmerzen mit der Periode zusammen?
- Haben Sie einen Ausschlag oder Schwellungen **im Intimbereich**?
- Haben Sie **Ausfluss** (=Sekret) bemerkt?
- Waren die Geburten **natürlich**?
- Haben Sie **noch** Ihre Regelblutung?

Hirnerkrankungen:

- Können Sie sich **an** alles erinnern?
- Was machen Sie beruflich?
- Haben Sie berufliche oder private Probleme?
- Haben Sie Stress?
- Haben Sie **Lähmungserscheinungen**?
- Haben Sie **Taubheitsgefühle** oder **Empfindungsstörungen**, zum Beispiel im Gesicht oder in den Armen?
- Ist Ihnen schwindlig?
- Wurden Sie verletzt?
- Hatten Sie einen Unfall?
- Waren Sie bewusstlos?
- Habe Sie Probleme **beim** Sprechen, Hören, Sehen, Riechen oder Schmecken?
- Sind in Ihrer Familie **Schlaganfälle** oder andere **Hirnerkrankungen** bekannt?
- Sind Sie oft müde oder traurig?
- Wissen Sie, **wo Sie sind** und **welcher Tag heute** ist?

HNO-Erkrankungen:

Mundhöhle:

- Sind Sie gegen etwas allergisch?
- Haben Sie Schluckbeschwerden?
- Rauchen Sie?
- Haben Sie auch Kopfschmerzen?
- Haben Sie **noch** Ihre Mandeln?
- Sind Sie manchmal **heiser**?
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Hals geschwollen ist?
- Haben Sie Mundgeruch?

Nase:

- Haben Sie **auch** Schnupfen?
- Haben Sie Heuschnupfen oder andere Allergien?
- Läuft **die Nase** oder ist **sie** eher verstopft?
- Wie sieht das Nasensekret aus?
- Benutzen Sie oft Nasenspray?

- Verstärken sich die Schmerzen, wenn Sie den Kopf tief nach unten beugen?
- Haben Sie Gesichtsschmerzen?
- Müssen Sie oft **niesen**?
- Ist ihr **Geruchssinn** gestört?

Ohr:

- Waren Sie kürzlich schwimmen?
- **Juckt es im Ohr**?
- **Fließt** ein Sekret aus dem Ohr?
- Sind Sie **in letzter Zeit** geflogen?
- Hören Sie schlecht?
- Haben Sie **Ohrgeräusche**?
- Haben Sie noch andere Beschwerden wie zum Beispiel Husten oder Schnupfen?
- War Ihnen übel oder hatten Sie **Schweißausbrüche**?

Schilddrüsenerkrankungen:

- Sind Sie **gestresst**? hyper
- Sind Sie oft **müde**? hypo
- Haben Sie Probleme, **sich** zu **konzentrieren**? hyper-hypo
- **Frieren**/schwitzen Sie oft? hypo-hyper
- Wie ist Ihr Appetit?
- Haben Sie **in letzter Zeit ab**- oder **zu**genommen? hyper-hypo
- Haben Sie Durchfall/Verstopfung? hyper-hypo
- Haben Sie **feuchte Hände**? hyper
- Haben Sie **Haarausfall** bemerkt? hyper
- Haben Sie **trockene Haut**? hypo
- Haben Sie **Schluckbeschwerden**? **Struma**
- Ist der Hals **dicker** geworden? **Struma**
- Spüren Sie ein **Druckgefühl** im Hals? **Struma**
- Sind Sie in letzter Zeit **antriebslos**? hypo
- Fühlen Sie sich **gereizt** oder **aggressiv**? hyper
- Gibt es in Ihrer Familie **Schilddrüsenerkrankungen**?

Hauterkrankungen:

- Haben Sie ein **neues Pflegeprodukt** benutzt?
- Haben Sie das **Waschmittel** gewechselt oder neue Kleidung gekauft?
- Haben Sie häufig wechselnde Sexualpartner?

- Haben Sie weitere Beschwerden zum Beispiel Gelenkschmerzen?
- Haben Sie Allergien?
- Gibt es **in Ihrer Familie** Hauterkrankungen?
- Wie **ernähren** Sie **sich**?
- Hatten Sie die Beschwerden **schon einmal**?
- **Gibt es einen Auslöser?**
- Hat sich der Fleck/Ausschlag **in der letzten Zeit** verändert?
- Ist der Ausschlag plötzlich aufgetreten?
- Können Sie den Ausschlag beschreiben?
- Welchen **Lichtschutzfaktor** benutzen Sie?
- **Juckt es?**

Bewegungsapparat: Ortopedi vakalarında mutlaka sorulmalı, olayın nasıl olduğu sorgulanmalı. **(Koyu puntolar)**

Allgemein:

- Spüren Sie ein **Knirschen** (Krepitation) im Gelenk?
- **Was ist passiert?**
- Sind die Beschwerden **plötzlich** aufgetreten?
- **Welche Bewegungen sind schmerzhaft?**
- Waren Sie bewusstlos/ohnmächtig?
- **Sind Sie auf den Kopf gefallen?**
- Ist das Gelenk **geschwollen**, **gerötet** oder **überwärmt**?
- Treten die Schmerzen bei einer bestimmten Bewegung auf?
- Haben Sie die Beschwerden auch in anderen Gelenken?
- Treiben Sie Sport? Welchen und wie oft?
- Gibt es in Ihrer Familie **Rheuma**, **Gicht** oder **Knochenschwund**? (Osteoporose)

Der Rücken: Unfall ile gelen , (elinin/bacağının/dizinin vs.)yaralandığını söyleyen her hastada kesinlikle sorulacak.***

- Spüren Sie **Kribbeln**? (form der Parästhesie)= Ameisenlaufen
- Haben Sie **Taubheitsgefühle**? (form der Parästhesie) =Sensibilitätsstörungen
- Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen?
- Haben Sie etwas Schweres gehoben?
- Können Sie laufen, sitzen und liegen?
- Sitzen Sie normalerweise viel?

Die Hüfte:

- Fühlen Sie sich **bei den täglichen Aktivitäten** eingeschränkt?
- Verschlimmern sich die Beschwerden, wenn Sie Treppen runterlaufen?
- Können Sie das Bein in der Hüfte **beugen** und **strecken**?

- Hatten Sie einen Unfall oder sind Sie gestürzt?
- Sind Sie auf die Hüfte gefallen? Haben Sie Schmerzen in der Leistengegend?
- Haben Sie **Anlaufschmerzen**, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen?
- Können Sie das Bein **abspreizen**?
- Schmerzt die Hüfte **auch in Ruhe?**

Anlaufschmerzen: Baslama agrisi

abspreizen: Yana dogru yaymak, acmak

Die Schulter:

- Können Sie etwas tragen, zum Beispiel Einkaufstasche?
- Spielen Sie oft Basketball, Volleyball oder Tennis?
- Haben Sie Probleme beim **an**- oder **aus**ziehen?
- Treiben Sie regelmäßig Sport?
- Können Sie den Arm ohne Schmerzen heben?
- Treten die Schmerzen nur bei Bewegung auf?

Der Arm:

- Arbeiten Sie viel am Computer?
- Spielen Sie viel Tennis oder Golf?
- Spüren Sie ein Kribbeln?
- Können Sie den Arm belasten?
- Können Sie den Arm und die Hand bewegen?
- Haben Sie Taubheitsgefühle?
- Können Sie greifen?
- Zeichnen oder malen Sie viel?

Das Knie:

- Knirscht es **bei Bewegung** im Gelenk?
- Können Sie das Knie **beugen** oder **strecken**?
- Verstärken sich die Schmerzen, wenn Sie die Treppe runterlaufen?
- Treten die Schmerzen beim Knien und Hocken auf?
- Können Sie das Knie belasten?

Der Fuß:

- **Ist Ihnen** ein Geräusch aufgefallen, bevor die Schmerzen aufgetreten sind?
- **Sind Sie umgeknickt** ? (wenn ja) nach außen oder nach innen?
- Sind Sie sportlich aktiv?
- Können Sie den Fuß bewegen/belasten?

PATIENTENVORSTELLUNG (PV)/ARZT-ARZT GESPRÄCH: ↩️

Aktuelle und vegetative Anamnese:

**mit ➔ Dativ Arzt-Art Gespräch'de mit kullan, yazarken wegen kullan.
wegen ➔ Genitiv Amaç yazma ve konuşmayı ayırt edebildiğini göstermek.***

*Herr/Frau Müller ist ein 49-jähriger Patient /eine 49-jährige Patientin, der/die sich heute bei uns/ in der Notaufnahme /in der Praxis/ auf unserer Station vorgestellt hat.
➔Arzt-Art Gespräche`de***

*Frau/Herr Müller, 46 Jahre, stellte sich heute **mit** Cephalgie bei uns/ in der Notaufnahme /in der Praxis/ auf unserer Station vor. ➔ Arzt-Art Gespräche`de***

*Frau/Herr Müller, 46 Jahre, hat sich heute **mit** Cephalgie bei uns/ in der Notaufnahme /in der Praxis/ auf unserer Station vorgestellt. ➔ Arzt-Art Gespräche`de***

*Frau Müller ist eine 46jähriger Patient, die sich heute **wegen** stark**er** Cephalgie bei uns/ in der Notaufnahme /in der Praxis/ auf unserer Station vorgestellt hat. ➔ **Arztbrief `de.*****

*Die Symptome/Beschwerden **bestehen** seit 3 **Tagen.**

*** (irgendwelches Symptom als Fachbegriff) **wurde als** (hastanın söylediği) **beschrieben.**

- z.B.
  *„Rhinitis **wurde als** verstopfte Nase/laufende Nase **beschrieben.**"
  (Rhinit burun tıkanıklığı/akması şeklinde tariflendi).

***Konuşma sırasında yakınmayı çok kısa söyle. Böylece hata yapma ihtimalin azalır. Konuşurken kısa cümleler kurmak çok büyük avantaj sağlar. Ama yazarken uzun tanımlar kullanılabilir. İlerleyen sayfalarda hepsi için örnekler mevcuttur.

*Frau/Herr Müller beschrieb die Schmerzen als (drückend/ziehend/…..

***Außerdem** klagte/berichtete der Patient/die Patientin über Nausea. (Symptome als Fachbegriffe)

veya ***Darüber hinaus leidet** er/sie **unter** Tinnitus. (Symptome als Fachbegriffe)

veya *Er/Sie erwähnte Vertigo. (Symptome als Fachbegriffe) Vertigodan bahsetti.

***Yakınma cümle halinde verilebilir. Mesela „Hasta sandalyeden düştüğünü, yanında kimse olmadığını, ne kadar süre baygın kaldığını bilmediğini söyledi/belirtti" gibi.

***Weitere Symptome/Beschwerden sind ……, ……., …… und …..... (çok fazla semptom olduğunda böyle birkaç tanesini arka arkaya söyleyip kısa kesebilirsin)

*Die weitere vegetative Anamnese war/ist unauffällig.

***Sunum sırasında ve yazarken sürekli ayni şekilde der Patient / die Patientin veya er/sie veya Herr/Frau…. kullanmak iyi değil. Her cümlede farklı bir özne kullanmak çok iyi olur. Bu üç özne seklini sırayla dönüp dönüp kullanabilirsin.

***Die Beschwerden sind erstmalig aufgetreten.
(İlk kez oluyorsa şikâyetler, bunu mutlaka söylemek gerek. Tabi sormak da gerek öncesinde)

Vorerkrankungen, OPs, Medikamente:

***Bekannte Vorerkrankung/Vorerkrankungen ist/sind aHT, DM Typ II .

veya An Vorerkrankungen sind/ist eine …….. bekannt.

***Dagegen nimmt er/sie Beloc ZOK 20 mg (ilac ismi ve dozu)
morgens/mittags/abends/einmal-zweimal täglich, …… (ikinci ilac ismi ve dozu)
morgens/mittags/abends/einmal-zweimal täglich.

***Önce hastalıkları arka arkaya sayıp sonraki cümlede ilaçları arka arkaya say. Hangi hastalığa hangi ilaç kullanıldığını özellikle belirtmene gerek yok. Sen hastalıkları ve ilaçları saydığında hangi ilaç hangi hastalık için kullanılır, meslektaşın biliyor zaten. Pille nin dozunu ifade etmeye gerek yok.

***Vor .....(.z.B. 5 Jahren) oder ...../.....(Jahr, z.B. 2017) wurde eine …….(Operation, z.B. Appendektomie/Osteosynthese) vorgenommen. Bu kalip cok güzel her türlü OP icin kullanilabilir.

- **erleiden** → leiden an fiili gibi. Ama bu sadece kaza ve yaralanmalar için kullanilir ve cok güzel bir fiildir.
  - Vor 8 Jahren **erlitt** er eine Patellafraktur.
  - 1995 **erlitt** sie einen Bänderriss im Knie.

Noxen, Alkohol:

***Er/sie raucht …… Zigaretten pro Tag/täglich seit ……. und trinkt 1-2 Bier pro Tag/täglich seit …….

- z.B. Er raucht seit 20 Jahren ein Schachtel Zigaretten pro Tag.
  Er raucht 20 Zigaretten täglich seit 20 Jahren.

***Sigara için paket/yıl kullanımına gerek yok. Günde ne kadar (mümkünse sigara sayısı, yoksa paket sayısı), kaç yıldır içiyor, bunu yaz. Ayrica rauchen fiili Zigaretten ve Gras (Marihuana) icin kullanilir. O nedenle ne kullaniyorsa (Zigaretten/...) bunu söyle/yaz mutlaka.

Allergien, Unverträglichkeit:
*** Es sind Allergien/Unverträglichkeiten gegen Katzehaare, Milchprodukt bekannt.
veya ***Er/Sie hat eine Allergie/Unverträglichkeit gegen Laktose.

Familienanamnese:

•Der Vater der Patientin leide an Herzinsuffizienz.
•Der Vater der Patientin sei altersbedingt verstorben.
•Die Mutter des Patienten leide an Mammakarzinom.
•Die Mutter des Patienten sei an Herzinfarkt verstorben.

Verdachtsdiagnose:
*Ich habe den Verdacht auf eine ……(Akkusativ)…..

*Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine ……(Akkusativ)…..

Differenzialdiagnose:
*Eventuell leidet der Patient/die Patientin auch **an** ……../…….. und ……

* …… und …….. kommen auch in Betracht. (iki tane ayırıcı tanı yeter. Istersen daha fazla da söyleyebilirsin ama her söyledigin sana soru olarak dönebilir.) ☺

Diagnostik:

*Zuerst werde ich den Patienten/die Patientin körperlich untersuchen und dann Blut abnehmen. Danach mache ich eine Urin-/Stuhluntersuchung/-kultur.

*Anschließend werde ich eine Röntgen/MRT/CT/Echo/EMG/EKG/US Untersuchung durchführen.

*Um den Verdacht zu bestätigen, müssen wir …….. (z.B. ein Röntgen veranlassen)

*Eine MRT ist notwendig, um die Diagnose zu bestätigen.

*Mit einer CT (z.B. Röntgen) können wir sehen, ob der Patient LWS Diskusprolaps habe.

Therapie und Empfehlungen:

- Ich empfehle der Patientin/dem Patienten, ….. =>Dativ*
  ***Bu kısımda ve tedavi kısmında yapabileceklerin acısından dikkatli olman gerek. Praxiste isen elinde muhtemelen sadece US ve laboratuvar olacak ve laboratuvar en az bir gün sonra eline geçecek. O yüzden hastanede misin yoksa Praxis te mi bilmen ve ona göre gerekirse hastayı Überweisung zum CT/MRT/.... Veya Einweisung ins Krankenhaus yapman gerekebilir.
  - Wenn sich mein Verdacht bestätigt, … => eğer tanı doğrulanırsa,....
  - Wenn sich die Diagnose bestätigt, … => eğer tanı doğrulanırsa,....

Einige Tipps für Patientenvorstellung: ↩️

- erstmalig = zum ersten Mal (ilk kez, ilk defa oluyor)
- ≠ als Erstes (ilk başta, en başta, başlangıçta)
  (als Erstes Umgangsprache'da kullanılır. Profesyonel konuşmalarda tercih etme.)

- **klagen über/leiden unter** → Bu fiilleri hastanın ciddi yakınması varsa, özellikle emotionelle Belastung, kullan. Hasta çok acı çekiyor, kıvranıyor falan gibi.
- Ama hasta çok Nötral anlatmışsa **berichten über/erwähnen/sagen** kullan.
- Hasta şikayetlerini anlatmak için 4-5 tane fiil bilsen yeter, gerisi gereksiz.

- In der Jugend => Als Jugendlicher
- In der Kindheit => Als Kind

- die Erkältung → 3 Tage, ohne Fieber
- der grippale Infekt → 10 Tage, leichtes Fiber
- die Grippe/die Influenza → 14 Tage, hohes Fieber

- Hasta sunumu yaparken yapacağın tüm testlerin, muayenelerin detaylı söylenmesi şart değil. Kısa kesmek en iyisi. Prüfer sorarsa o zaman açıklarsın.
- Hasta sunumunda ilk 1-2 cümle çok önemli. Kısa, öz, yanlışsız başlayınca her zaman iyi puan gelir. Sonraki hatalar daha az göze batarmış.

  - Arzt-Arzt Gespräch sırasında sık kullanılan bazı fiiller:
    auf/treten, zeigen sich → ohne Objekt
  - beobachten, finden, hören, tasten, sehen, bemerken + Akk.;
    auffallen + Dativ + Akk. → mit Objekt
  - hin/deuten auf, hin/weisen auf + Akk. → mit Fester Präposition

- Hasta anamnezin başında hastalığı eşinden kaptığını söyledi. Anamnezin sonunda ben evli misiniz diye sordum. Hasta tepki gösterdi, size eşime söyledim, beni dinlemiyor musunuz diye. Bu durumda alttan alıp şöyle söylemem gerekiyor:
  - ***Ja stimmt, das hatte ich vergessen.

- PV sırasında bolca kısaltma kullan. Prüferler bunları kullanabildigini görmek ister.
  *Sınavda prüfer PV'nin başında bana mümkün olan yerlerde kısaltma kullanarak konuşmamı söyledi.

↩️

Beispiele für Patientenvorstellung: ↩️

Fall 1.

- Andreas Müller, 56 Jahre, trockener Husten seit 3 Tagen, leichte Atemnot bei Belastung, Fieber 39,2ºC, schmeckt und riecht nichts, leichte Übelkeit.
    - -Herr Müller, 56 Jahre, stellte sich heute mit trockenem Husten bei uns vor.
      -Die Beschwerden bestehen seit 3 Tagen.
      -Er hat auch leichte Atemnot bei Belastung und Fieber 39,2ºC.
      -Er berichtete über Geruchs- und Geschmacksverlust.
      -Außerdem klagte Herr Müller über leichte Übelkeit.
      -Die weitere vegetative Anamnese war unauffällig.
      -Ich habe den Verdacht auf eine COVID-19 Infektion.
      -Erkältung und grippaler Infekt kommen nach in Betracht.
      -Zunächst würde ich den Patienten körperlich untersuchen mit Inspektion des Rachens und Auskultation der Lunge.
      -Dann werde ich einen PCR-Test durchführen.
      -Weitere diagnostische Maßnahmen sind vorerst nicht notwendig.
      (Şu an için daha fazla teşhis önlemi gerekli değildir.)

Fall 2.

- Marie Müller, 43 Jahre, brennende Schmerzen beim Wasserlassen seit 2 Tagen, ständiger Harndrang, kein Blut im Urin, kein Fieber, Beschwerden erstmalig.
    - -Frau Marie Müller, 43 Jahre, stellte sich heute mit Dysurie (brennenden Schmerzen) beim Wasserlassen bei uns vor.
      -Die Beschwerden bestehen seit 2 Tagen.
      -Außerdem klagte sie über ständigen Harndrang. (sürekli idrara çıkma isteği)
      -Blut im Urin und Fieber wurden verneint.
      -Die Beschwerden sind erstmalig/zum ersten Mal aufgetreten.
      -Ich habe den Verdacht auf eine Zystitis.
      -Pyelonephritis kommt auch in Betracht.
      -Zunächst werde ich die Patientin körperlich untersuchen mit Palpation des Unterbauchs und **Perkussion des Nierenlagers**.
      -Außerdem nehme ich Blut ab und mache einen Urinstatus.

Fall 3.

- Konrad Pohl, 25 Jahre, seit 4 Stunden krampfartige Bauchschmerzen, 3x Durchfall, 5x erbrochen, starke Übelkeit, Fieber nicht gemessen, Beschwerden erstmalig.
    - -Herr Konrad Pohl, 25 Jahre, stellte sich heute mit krampfartigen Bauchschmerzen bei uns vor.
      -Die Beschweren bestehen seit 4 Stunden.
      -Außerdem klagte er über dreimaligen Durchfall (oder: dreimalige Diarrhö), starke Übelkeit (oder: starke Nausea) und fünfmaliges Erbrechen (oder: fünfmalige Emesis).
      -Fieber wurde nicht gemessen.
      -Die Beschwerden sind erstmalig aufgetreten.
      -Ich habe den Verdacht auf eine Gastroenteritis.
      -Zunächst werde ich den Patienten körperlich untersuchen.
      -Außerdem nehme ich Blut ab und mache/veranlasse eine Stuhluntersuchung.

-Gastroenterit (GE) vakasında mutlaka sorulması ve bilinmesi gereken şeyler:

- Was-Wo-Wann haben Sie zuletzt gegessen?
- Gibt es in Ihrem Umkreis Personen mit ähnlichen Beschwerden?
- Wie viel Stunden nach der letzten Mahlzeit sind die Beschwerden aufgetreten?
  - Nach 1-2 Stunden → Lebensmittelintoxikation (-vergiftung)
  - Nach 6-8 Stunden → Lebensmittelinfektion

    *Almanya'da Gastroenterit vakaları (hepsi değil) bildirilmeli ve lokanta vs hemen kapatılıp incelenmelidir.

    -Arzt-Arzt Gespräch şöyle devam etti:
- Gastroenterit vakası var. Ne yapacaksın şimdi:
  - Ich muss beim Gesundheitsamt melden.
- Neden?
  - Weil das meldepflichtig ist.
- Meldepflicht ne demektir?
- Bütün GE nedenleri meldepflichtig midir?
  - Hayir
- Hangileri zorunlu?
  - Rotavirus, Salmonella, Shigella, vs.
- En sık neden hangisi?
  - E. Coli, dedim, dogru mu bilmiyorum ☺ EHEC, ETEC?
- Hasta ise gidebilir mi?
  - Hayir.
- Neden?
  - Cünkü baskasina bulastirabilir.
- Peki eve gidebilir mi?
  - Siddetli dehidratasyonu yoksa veya düzeltildikten sonra gidebilir.

    Seni biraz izlemem gerek dedim. Bunu iki sekilde söyleyebilirz:

    -Ich muss Sie überwachen → monitörize etmek, servis sartlarinda, daha ciddi sekilde yani.

    -beobachten → servis disinda, normal acilde, poliklinikte gözlemlemek, daha hafif yani.
- Peki evde dikkat etmesi gereken bir sey var mi? cocuklarina falan bulastirabilir.
  - Mümkünse esyalarini ayirabilir, tuvalet hijyenine, el yikamaya dikkat etmeli.
- Hastaya ilac verecek misin?
  - Muayene bulgularina göre agir dehidrate ise Flüssigkeitszufuhr yapmam gerekebilir. Ancak burasi praxis ve bu imkan yok, belki hastaneye sevk edebilirim. Eve gönderirken belki Antidiarrhoikum recete edebilirim.
- Hasta evde kendisi neler yapabilir, ne tavsiye edersin?
  - Ich empfehle der Patientin, sich auszuruhen, Banane, Zwieback, griebener Apfel und Joghurt (als Probiotika) zu essen und viel zu trinken.
- Hasta yeni Brezilya'ya seyahat etmis. Ne olabilir bununla ilgili?
  - Hepatit.
- Hangi hepatitler var
  - Hep A, B, C, …

Tanıyı nasıl koyarsın Laboratuvar ile?

- Ich kann Hepatitis-Serologie überprüfen, z.B. anti-HBs-AK, HBs-Antigen, anti-HAV-AK, anti-HCV-AK

- Bu hastada en olasi hangisi?
  - Hep A
- Hep A nasil bulasir?
  - Fekal-oral yoldan
- Fekal-oral yoldan bulasan enfeksiyonlarin Almanca ismi ne?
  - **Schmierinfektion :** von Mensch zu Mensch durch Kontamination
- Hepatitin tedavisi veya asisi var mi?
  - Ja, aber es gibt noch keinen Impfstoff gegen Hep C.
- Diger hepatitler hangi yollardan bulasir?
  - Am meisten durch Geschlechtsverkehr und Blutübertragung.
- Hasta hepatit ise evde ne yapsin?
  - Wie ich schon gesagt habe, sollte die Patientin eigene Sachen von anderen entfernen und den Geschlechtsverkehr und die Blutspende vermeiden.

- Bir hasta kendisi başvurmamış, ambulansla getirilmiş ise şu şekilde ifade ediyoruz:

  - Frau Vogel, 54 Jahre, **wurde** heute wegen starker Schmerzen im linken Oberbauch **mit dem Rettungswagen (RTW)** bei uns/in die Notaufnahme **eingeliefert**.
  - Oder:* Frau Vogel, 54 Jahre, **wurde** heute **vom Rettungswagen (RTW)** bei uns/in die Notaufnahme **eingeliefert**. Sie klagte über starke Schmerzen im linken Oberbauch.

-Pankreatit hastası dedi ki, ağrı öne eğilmekle (ve dizlerini kendine çekmekle) rahatlıyormuş. Bunu şöyle sunuyoruz:

- Die Schmerzen verbessern sich beim Nachvornebeugen/Beugen nach vorne/ **in Embryonalstellung**. (Ağrı, öne eğilme/ileri eğilme/fetal pozisyon sırasında düzelir.)

- Pankreatit vakasinda Prüfer dedi ki:
  - Inspeksiyonda ne beklersin:
    - Bei einer Pankreatitis **befindet sich** die Patientin in einem reduzierten allgemein Zustand (AZ). Eventuell finde ich Ikterus und ich achte auf Narben, Hautveränderungen oder Wunden am/beim Abdomen.
  - Auskultation:
  - In/bei der Auskultation kann ich verminderte **Peristaltik** wegen Inflammation hören. Oskültasyonda inflamasyon nedeniyle azalmış peristalsis duyabiliyorum.
  - Palpation:

- Bei der Palpation erwarte ich **Druckschmerzen** und **Abwehrspannung.** ➔muscular defense = Bauchdeckenspannung

-Bir vakada hastada ne zamandan beri kabızlık var sorusuna „irgendwie schon immer, das kommt und geht, vielleicht so alle 2 Monate“ diye cevap verdi.
PV sırasında şöyle ifade ettik:

- Der Patient leidet seit vielen Jahren gelegentlich unter Obstipation, etwa alle zwei Monate.

-Hastanın şikayetlerini anlatırken zaman ifade eden kısmın cümledeki yeri kritik. Süre semptoma mı yoksa fiile mi atıf yapıyor dikkat etmek gerek. Örneğin:

- ➔Der Patient klagte **seit 3 Wochen** über Bauchschmerzen.
  Hasta üç haftadır sürekli şikayet ediyor. (karın ağrısından) [yanlış kullanım]
  ➔ Der Patient klagte über Bauchschmerzen **seit 3 Wochen.** (hasta üç haftadır olan karın ağrısından (şimdi) şikayet ediyor). [doğru kullanım]
  ➔Er berichtete **gelegentlich** über Obstipation.
  Hastanın her zaman kabızlığı var ama arada bir bahseder. [yanlış kullanım]
  ➔ Er berichtete über **gelegentliche** Obstipation.
  Hasta arada bir olan kabızlıktan bahsediyor (şimdi) [doğru kullanım]

- Hafta sonunda göğüs ağrısı öyküsü olmuş bir hasta şimdi Praxise geldi:

  - „Bir anda **kendimi çok kötü hissettim, oturmak zorunda kaldım**. Kalbim hızlı hızlı çarptı ve bulantım oldu“ dedi. Bunu şu şekilde sunduk:

    - Die Patientin hat gesagt, dass sie **Schwächeanfall** mit Herzrasen und Übelkeit hatte. Hasta taşikardi ve mide bulantısı ile halsizlik atağı geçirdiğini söyledi.

  - Die Beschwerden sind am Wochenende erstmalig aufgetreten und haben circa 15 Minuten gedauert/**angehalten.** ➔C1 seviyesi güzel bir fiil.
  - Außerdem klagte sie über Kurzatmigkeit (oder: Dyspnoe), **Schweißausbrüche** (MI öyküsünde çok önemli. Ani aşırı terleme manasında), Schwindel (oder: Vertigo) und **Todesangst.** Ich dachte, ich werde sterben/sterbe jetzt.
  - Darüber hinaus berichtete Frau Bergmann über ziehende und drückende Schmerzen im Nacken und zwischen den Schulterblättern.
  - Momentan ist die Patientin beschwerdefrei. (Bu cümleyi söyleyerek bunun bir Notfall olmadığını belirtmiş oluyorsun. Şart değil ama söylemek şık olur. Hasta momentan semptomsuzdur manasinda)

- Sigarayı bırakmış olma durumu şöyle anlatılabilir:

- Sie hat vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, aber früher hat sie 35 Jahre zwei Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht.

- Sigara sayısı son iki yılda artmış:

  - Der Patient raucht seit 25 Jahren ca. 20 - 30 Zigaretten täglich und **in den letzten 2 Jahren** bis zu 40 Zigaretten pro Tag.
    Hasta 25 yıldır günde yaklaşık 20-30 adet, son 2 yılda günde 40 adete kadar sigara içmiştir.

- Hasta VE'leri sayarken en son ne zaman kontrole gittiğini sordum. Aldığım cevabı hasta sunumu sırasında hemen VE'lerden sonra söylersem su şekilde olur:

  - Sie war **das letzte Mal** vor 8 Monaten **zur Kontrolle**.
  - Ama bunu unutup sonradan söylersem farklı şekilde ifade ederim:
    Ich habe vergessen zu sagen, dass die Patientin das letzte Mal vor 8 Monaten bei ihrem Hausarzt zur Kontrolle war. / oder: …..
    Ich habe vergessen zu sagen, dass Blutwerte und Blutdruck das letzte Mal vor 8 Monaten kontrolliert wurden.

- Hasta eski hastalıklarından bahsederken ögrendik ki Hiperkolesterolemi tanısı konmuş ama tedavi edilmemiş. Hasta takiplere gitmemiş. Bunu şöyle ifade ediyoruz:

  - Die Hypercholesterinämie ist **unbehandelt**.

- Prüfer **EKG**'de ne göreceksin, niye yapiyorsun dedi:

  - ***Ich führe ein EKG durch, ob es ein**en** Herzinfarkt **gibt**/ oder:
    ob ein Herzinfarkt **vorliegt**/oder: ob **es** **sich um** ein**en** Herzinfarkt **handelt**.

    *vorlegen → olmak, bulunmak. önemli bir fiildir.
    *sich um etwas handeln → (bir şey) olma(k) durumunda bulunmak.

- **aHT** hastası olan ve göğüs ağrısı ile gelen hastada ayırıcı tanıda hypertensive Krise olabileceğini söyledim. Oberärztin bu mümkün mü, hipertansif kriz agri ile gelir mi diye sordu. Cevap olarak:

  - Das **kommt** nicht so häufig **vor**, aber man kann das nicht **ausschließen**.
    O kadar sık olmaz, ancak göz ardı edilemez.

- Yukaridaki hastaya tedavi disinda ne tavsiye edersin:

- Ich würde der Patientin/dem Patienten empfehlen, abzunehmen und leichten Sport treiben, z.B. Schwimmen oder Fahrrad fahren.

- Hasta tekrar kontrole gelmeli:
  - Die Patientin sollte sich nach 3 Monaten **zur Kontrolle** vorstellen.

- **pAVK** vakasında bakılması gereken nabızlar:
  - dorsalis pedis => a. dorsalis Pedis
  - tibialis posterior => a. tibialis Posterior
  - Femoralpuls => a. Femoralis

- **pAVK** vakasında KU:
  - **der Knöchel-Arm-Index** → Verhältnis von Unterschenkel Blutdruck zu Oberarm Blutdruck. **Je** kleiner Quotient wird, **desto** größer ist die Durchblutungsstörung. (Normal: 0,9-1,3) => Alt bacak kan basıncının üst kol kan basıncına oranı. Bölüm ne kadar küçükse, dolaşım bozukluğu o kadar büyük olur.

  - **Ratschow-Lagerungsprobe/Lagerungstest** → Der Patient liegt auf dem Rücken und streckt die Beine nach oben. Er kreist ca. eine Minute mit den Füßen. Der Patient setzt sich auf die Liege und lässt die Beine hängen. Bei einer pAVK füllen sich die Venen langsamer. Hasta sırt üstü yatar ve bacaklarını uzatır. Ayaklarını yaklaşık bir dakika daire içine alır. Hasta kanepeye oturur ve bacaklarının sarkmasına izin verir. pAVK da damarlar daha yavaş dolar.

- **pAVK** vakasını hastanede gördüysen:
  - ich fordere ein gefäßchirurgisches Konsil an. (Damar cerrahisi konsültasyonu talep ediyorum.)
- Praxis'te gördüysen: anfordern: talep etmek
  - Ich überweise zum Gefäßchirurgen.

- Das Stadium/die Stadien
  - **Je nach Stadium** entscheidet sich die Therapie-Methode, konservativ oder operativ. (Evreye bağlı olarak, tedavi yöntemine karar verilir, konservatif veya cerrahi.)

- **TVT** vakasında KU:

  - **Homans-Zeichen** → Das Zeichen ist positiv, wenn der Patient **bei Dorsalflexion des Fußes** Schmerzen in der Wade hat. (Ayak dorsifleksiyondayken hastanın baldırında ağrı varsa, işaret pozitiftir.)
  - **Payr-Zeichen** → Das Zeichen ist positiv, wenn der Patient **beim Druck in die Fußsohle** Schmerzen hat. (Ayak tabanına basıldığında hasta ağrı hissederse işaret pozitiftir.)

- **Cholezystitis** vakasında KU:

6

- **Das Murphy-Zeichen** → Die Patientin liegt auf dem Rücken und atmet tief ein. Ich palpiere unter dem rechten Rippenbogen auf MCL (Medioclavicularlinie). Wenn die Patientin wegen Schmerzen den Atem anhält, ist das Zeichen positiv. Es weist auf eine Cholezystitis hin.
- **Das Courvoisier-Zeichen** → Die Patientin liegt auf dem Rücken. Ich palpiere unter dem rechten Rippenbogen auf der MCL. Wenn ich eine prall elastische Gallenblase taste, ist das Zeichen positiv. Es deutet auf eine Cholestase hin.

- Hasta kustugunu söyledi. Essenreste kelimesini kullandi. Bunu söyle sunuyoruz:
  - Sie/er hat Mageninhalt erbrochen.

- Kadın hasta 6 aydır düzensiz ve ağrılı adet oluyormuş. Bazen 3 hafta bazen 5-6 hafta sürüyormus.
  - Die RB ist schmerzhaft und unregelmäßig, etwa alle 3-5 Woche.
  - Die Patientin klagte über unregelmäßigen Zyklus.

- **DM** hastasinda insulin kullanimi su sekilde ifade edilir: IU: International Unit
  Hasta: Ich nehme Lantus 100 Einheiten. IE: International Einheit
  - Sie/Er nimmt gegen DM Lantus 100 IE nach Schema. => bunu söylemek gerekiyor

- Stresli zamanlarda ishal oluyormus: Stress iliskili . Cok önemli bir sifat....bedingte -- bircok sey icin kullanilabilir
  - Sie hat **stressbedingte** Diarrhö. =>ibs=> Reizdarmsyndrom

- **Nephrolithiasis** vakasında tedavi olarak ESWL Aufklärung ve açılımını sormayı severlermiş.
  - ESWL → ekstrakorporale Stoßwellenlithotripsie
  - Bunu aciklarken anahtar kelime: **zertrümmern:** yıkıntı haline getirmek, paramparça etmek

***ESWL ist eine Therapie-Methode, die die energiereiche Schallwellen auf der Haut in den Körper sendet. Mit dieser Methode können wir die Nierensteine **zertrümmern**. => (Bunu mutlaka duymak isterlermis.)
Die Fragmente werden mit dem Urin **ausgeschieden**.=> aktif şekilde enerji harcamadan dışarı atmak, boşaltmak

Defäkation/Miktion = Ausscheidung

- Hasta bir şey söyledi, ama sen onu kaçırmışsın. Sonra PV sırasında konusu geçti. Diyeceksin ki ben onu kaçırmışım:
  - Das ist mir entgangen.

- Hasta bir ilaç/tablet kullandığını ama ismini, dozunu hatırlamadığını söyledi.
  Şu şekilde dökümante ediyoruz:

- BPH, seit 10 Jahren, Medikament (ggf. noch abklären)
- Glaukom, seit 5 J., Augentropfen (oder: Medikament) (ggf. noch abklären)
  ggf. noch abklären: Ne olduğu belli değil, gerekirse açıklığa kavuşturulur.

- Aile öyküsünde önemli bir bulgu yok. Söyle ifade et:
  - Die Familienanamnese ist nicht relevant. (Aile öyküsü önemli değildir.)

- Hastaya osteoporosu (veya belirli başka bir risk faktörü) olup olmadığını sordum ve hasta bunun olup olmadığını bilmiyordu. Şöyle ifade ettik:
  - Osteoporose ist nicht bekannt.

- Hasta ağır bir valiz kaldırmış ve bununla beraber aniden sırtında batıcı ağrı başlamış:
  - Frau Lustig hat/habe einen schweren Koffer gehoben und **dabei** sind/seien plötzlich stechende Schmerzen aufgetreten.

- Hasta postmenopozal dönemde:
  - Sie ist/sei postmenopausal.

- Hastaya ne tedavi vereceksin diye sordu Prüfer. Cevaben:
  - Wenn sich mein Verdacht bestätigt, … => eğer tanı doğrulanırsa,....
  - Wenn sich die Diagnose bestätigt, … => eğer tanı doğrulanırsa,....

KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG: ↩️

- **die Inspektion: inspizieren, anschauen**, betrachten, begutachten, **ansehen, untersuchen etwas auf etwas**
- **die Auskultation:** auskultieren, abhören (Organ – dinlenen organ), hören (Resultat – dinlediğinde duyduğun şey)
- **die Perkussion:** perkutieren, abklopfen (Organ)
- **die Palpation:** palpieren, abtasten (Organ ismi belirterek kullanılır. Organin şeklini kıvamını anlarsın. Örneğin, karaciğer büyük/sert/çentikli.),
  tasten= Bu fiil „aramak amacıyla dokunmak“ manası verir, hissetmek vs. Örneğin, lenf noduna dokunuyorsun ama amaç; palpe edilen bir lenf nodu „var veya yok“.

- Beispiele:

- Ich untersuche die Haut auf Narben, Wunden und Verfärbungen. (Ciddi yara izi, yara ve renk değişikliği açısından (gözle) inceliyorum.)
- Ich höre die Lunge ab.
- Ich kann feuchte Rasselgeräusche in der Lunge hören. (Akciğerlerde ıslak çıtırtılar duyabiliyorum.)
- Ich kann vermehrte Peristaltik hören. (Artmış peristalsis duyabiliyorum.)
- Ich klopfe die Nieren ab.
- Ich taste das Abdomen ab.
- Ich taste die Leber ab.
- Ich taste die Lymphknoten.

ALLGEMEINE TIPPS und INFORMATIONEN: ↩️

- Graphie = Grafie → ikisi de kullanilabilir. Ikisi de dogru
- Echokardiographie → Herzecho (transösophageal und transthorakal)
- PTCA → perkutane transluminale Koronarangiographie/-plastie
- ERCP → endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie

Girisimler icin önemli fiiller:

- Eine Operation/einen Eingriff durchführen/vornehmen.
- Die Narkose einleiten.
- Die Vitalfunktionen überwachen.
- Einen Schnitt setzen.
- Gewebe entnehmen.
- Einen Stent setzen/implantieren.
- Eine Drainage legen/einlegen.
- Die Wunde nähen/vernähen.
- Überbrückung → köprüleme
- Überbrückung der Engstelle der Herzkranzgefäße → Koronar-Bypass-OP
- Umgehungen von Blutgefäßen → Bypass
- Blutgerinnsel → Thrombus
- Gefäßverschluss durch Blutgerinnsel → Thrombose
- Gefäßverschluss durch Gerinnselwanderung → Embolie

Birşeyi açıklaman gerektiğinde kullanılacak kalıplar:

- ***Unter …….…… versteht man …….……***
- ***Mit/Als ……..… bezeichnet man.....***

  Beispiel:
  - Unter KHK versteht man verengte Herzkranzgefäße.
    (KHK daralmış koroner arterler anlamına gelir.)
  - Unter Pneumonie versteht man Lungenentzündung.
    (Pnömoni, akciğerlerin iltihaplanması anlamına gelir.)
  - Mit/Als Zystitis bezeichnet man Harnblasenentzündung.
    (Mesane iltihabına sistit denir.)

- Im Bein → Bacağın içindeki bir durum. Örn. pAVK'daki ağrı, damar tıkanıklığı vs.
- Am Bein → Bacağın dışındaki bir durum. Solukluk, soğukluk, atrofi bulguları vs.

- zunehmend → progresif
- **zu** ein**em** Facharzt überweisen ➔ Dativ , **an** ein**en** Facharzt überweisen➔ Akk.
- ins Krankenhaus ein/weisen➔ Akk.
- wellenförmig → undulierend (gelip giden, azalıp artan ağrı, dalgalanma şeklinde)
- X dauerhaft → (sürekli olan)
- chronisch **rezidivierende** Zystitis→ yılda üçten fazla sistit. **(tekrarlayan)**
- Elektrolytstörung → elektrolit bozukluklari (mesela pankreatit'te)
- anderthalb → eineinhalb (1,5)
- Colon/Kolon → ikisi de dogru
- Glass ➔ Gl. -oft → sık sık, sıklıkla -häufig → yaygın, bol

Iskelet sistemi hastalıklarında tedavide :

PECH-Regel:

die Pause, das Eis, die Kompression, das Hochlagern

- P: Schonen Sie das Gelenk./Vermeiden Sie Belastung.
- E: Kühlen Sie das Gelenk.
- C: Bekommen Sie einen Druckverband.
- H: Legen/Lagern Sie das Bein hoch.

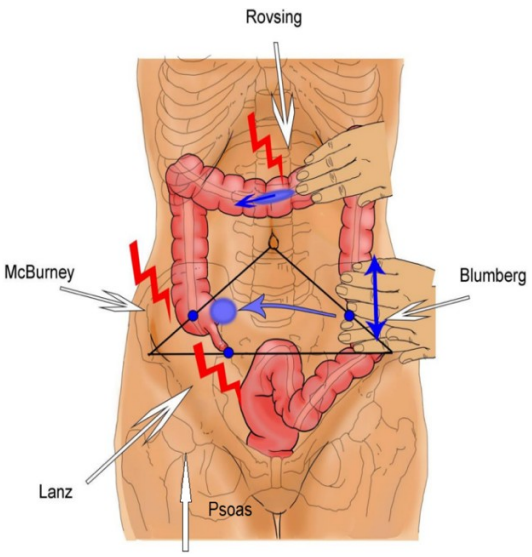
- erwarten von + Dativ → birsey (olmasini) beklemek, (bu durumda ne beklersin gibi)
- Neurodermitis (Umgangssprache) → atophische Dermatitis
- Appendizitis ayırıcı tanısı özellikle kadınlarda çok önemli. O nedenle mutlaka son adet, gebelik, korunma yöntemleri sorgulanmalı.
  Ayırıcı Tanıda: Extrauterine Gravidität (EUG)
  - Adnexitis/Oophoritis
  - Ovarial-Torsion
- Appendizitis çok çıkan bir vakaymış ve Prüferler muayene bulgularını sormayı çok severmiş. Özellikle 4 muayene bulgusu oldukça önemli imiş ve en az ikisini bilmemizi beklerlermiş.
  - **McBurney**-Punkt
  - Lanz-Punkt
  - **Blumberg**-Zeichen
  - **Psoas**-Zeichen
  - Rovsing-Zeichen → daha az önemli

McBurney-Punkt: Der Punkt liegt auf einer Linie zwischen Nabel und rechter SIAS zwischen den beiden lateralen Dritteln.

Lanz-Punkt: Der Punkt liegt auf einer Linie zwischen beiden SIAS im rechten Drittel.

Blumberg-Zeichen: Das ist ein kontralateraler Loslassschmerz. Ich palpiere kontralateral zum McBurney Punkt im linken Unterbauch.

Psoas-Zeichen: Der Patient hebt das rechte gestreckte



- Bu bulgular pozitif ve tanı koydun. Şimdi ne yapacaksın:
  In der Notaufnahme: Ich **fordere** ein chirurgisches Konsil **an**.
  In der Praxis: Ich überweise zum Facharzt / weise ins Krankenhaus ein.
- das Wasserlassen (N.) = Wasser lassen, pullern, pinkeln, urinieren ➔ alle gleiche
- Prostat büyümesi düsündügün hastada mutlaka sor:
  - Ist Ihr **Harnstrahl** schwächer geworden? (İdrar akışınız zayıfladı mı?)

IYE:

Erkrankung	Symptome	Diagnostik	Therapie
Zystitis	-Unterbauchschmerzen -Dysurie (brennen beim Wasserlassen) -Pollakisurie (häufiger Harndrang) -Hämaturie (Blut im Urin) kein Fieber	-KU -Urinstatus	-Antibiotikum Fosfomycin → einmal Nitrofurantoin -Viel Flüssigkeit (zu trinken) -Intimhygiene + Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr
Pyelonephritis	-Flankenschmerzen -Fieber -Übelkeit -Dysurie -Hämaturie	KU: -Klopfschmerz im Nierenlager -Urinstatus -Labor: BB	-Antibiotikum -Analgetikum -Viel Flüssigkeit
Prostatitis	-Pollakisurie/ -Dysurie/ -Hämaturie -Fieber/Schüttelfrost -Krankgefühl	-KU: -DRU (digital rektale Untersuchung) -Labor: BB, CRP, BSG, -PSA -Urinstatus -Sono	-Analgetikum -Antibiotikum
benigne Prostatahyperplasie	-verzögerte Miktion + Nachtröpfeln (oder: Harntröpfeln)		-5-Alpha-Reduktase Hemmer (**Finasterid**) -selektive Alpha-

(BPH)	-schwacher Harnstrahl -Druckgefühl im Unterbauch		Blocker (**Tamsulosin**) **TURP** (transurethrale Prostataresektion)
Urolithiasis **Nephrolithiasis**	-Kolik/krampfartige Bauch- oder Flankenschmerzen -Fieber -Übelkeit/Brechreiz -Hämaturie -Schweißausbrüche -Schwindel	-KU -Labor: CRP, BSG, BB, -Urinstatus -US	-Analgetikum -Spasmolytikum -ggf. Antibiotikum -**ESWL** (ekstrakorporale Stoßwellenlithotripsie)

verzögerte Miktion: Gecikmis, gecikmeli

Nachtröpfeln oder Harntröpfeln: Damla damla idrar gelmesi, tuvaletten sonra da damlalarin devam etmesi

Druckgefühl im Unterbauch: Mesane tam bosalmadigi icin.

Leitsymptome: Müdigkeit und Antriebslosigkeit		
Hypothyreose -Haben Sie trockene Haut? -Frieren Sie oft? -Wie ist Ihr Appetit? -Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? -Haben Sie Probleme, sich zu konzentrieren? -Wie ist Ihre Regelblutung?	**Anämie** -Wie ist Ihre Regelblutung? -Haben sie Atemnot oder Herzrasen? -Wie ernähren Sie sich? -Ernähren Sie sich vegetarisch/ vegan? -Wie ist Ihr Appetit? -Haben Sie Veränderungen an Ihrer Haut oder den Nägeln bemerkt? -Haben Sie Konzentrationsprobleme? -Haben Sie Veränderungen beim Stuhlgang oder Wasserlassen bemerkt? -Haben Sie Blut im Urin oder im Stuhl bemerkt?	**psych. Erkrankungen (Depression)** -Haben Sie Probleme auf der Arbeit oder im Privatleben? -Haben Sie Konzentrationsprobleme? -Haben Sie Hobbys? Haben Sie das Interesse an Ihren Hobbys verloren? -Wie ist Ihr Appetit? -Schlafen Sie gut? -Denken Sie oft über das Leben nach? -*** **Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen?** -Wie sehen Sie Ihre Zukunft? -Machen Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft? -Treffen Sie Ihre Familie oder Freunde?
Diagnostik: KU: Hals (Struma/Kropf), Augen (blasse Konjunktiva), Haut, Mundschleimhaut, Mundwinkelrhagaden, Nägel (Rillen), Landkartenzunge, weißer Belag am Zunge Labor: BB, TSH, T3, T4, TPO-AK, Tg-AK, MAK(TPO), Ferritin, Transferrin, B12 US: Schilddrüse (ggf.)		

***=> Bu soru depresyon hastasına mutlaka sorulmalı...

Struma/Kropf: Ein Kropf (Struma) ist eine Schwellung im Hals durch eine vergrößerte Schilddrüse. Ursache ist meist chronischer Jodmangel.

Mundwinkelrhagaden: Mundwinkelrhagaden sind Entzündungen der Haut in den Mundwinkeln, die schmerzhaft sind und häufig schlecht heilen.
Die Rille: Linie, Kanal
Die Lingua geographica oder Landkartenzunge ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Zunge. Die Ursache ist unbekannt.
Zungenbelag: Sichtbarer Belag auf der Zunge.(dilde görünür kaplama)

- Acil serviste depresyon hastası geldi. Ölmeyi istiyor. Bu hastanın gitmesine izin vermiyorsun. Stationäraufnahme yapıp psikiyatri ile konuşuyorsun hemen, Notfall var diyorsun. Hausarztpraxis'te ise hastayı yine göndermiyorsun. Polisi arıyorsun. Bir acil durum olduğunu söylüyorsun, durumu anlatıyorsun, polis geliyor, her şeyi organize ediyor ve hastayı hastaneye götürüyor.

  - Fazialisparese ile gelen hastada mutlaka Nöroborreliose sorgulanmalı. Almanya'da baya sık görülürmüş. Hastanın yakın zamanda ormana, pikniğe vs gidip gitmediğini, kene ısırıp ısırmadığı gibi, vücudunda kızarıklık (Erythema migrans = Wandernröte) olup olmadığı sorulmalı.
  - Zustand nach = Z.n. ➔Hastalık/OP tamamen bitti anlamına gelir, hastalık isminden hemen önce kullanılır.
    Z.n. Appendektomie/Ulcus ventriculi….

Ortopedi genel yaklaşım ve sık çıkan vakalar:

- Arthrose = Gelenkverschleiß
- Arthritis = Gelenkentzündung
- verschleißen = sich abnutzen=> yıpranmak
- Rücken:
  - die Lumbago/der Hexenschuss
  - die Ischialgie => işialgii veya iskialgii diye telaffuz ediliyor.
  - die Bandscheibenprotrusion/die Diskusprotrusion
- Hüfte:
  - die Koxarthrose/Coxarthrose
  - die Oberschenkelhalsfraktur (Collum femoris-Fraktur)
- Knie:
  - der Meniskusriss
  - der Kreuzbandriss
  - die Gonarthrose
  - die Patellafraktur
  - die Patellaluxation
- Fuß:
  - die Sprunggelenksfraktur
  - die Talusfraktur
  - die Sprunggelenksdistorsion =Sprunggelenkverstauchung
    - Supinationstrauma
    - Pronationstrauma
  - die Achillessehnenruptur
  - der Bänderriss
- Arm:

        - die distale Radiusfraktur
        - das KTS (Karpaltunnelsyndrom)
        - die Epikondylitis / Epicondylitis
        - die Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis, Tendosynovitis)
    - generell:
        - die Bursitis (die Schleimbeutelentzündung)
    - Symptome:
        - der Anlaufschmerz (başlama ağrısı)
          → z.B. morgens **nach dem Aufstehen** oder **nach längerem Sitzen**
        - Schmerzen bei Belastung/in Ruhe
        - die Morgensteifigkeit (sabah sertliği)
        - die Rötung
        - die Überwärmung
        - das Knirschen = die Krepitation
        - das Kribbeln = die Parästhesie
        - die Taubheitsgefühle = die Hypästhesie
        - die Bewegungseinschränkung
        - die Funktionsstörung
        - die Lähmung/die Parese
        - das Knacken (knak sesi, yaralanma sesi)***

Travma muayenesi kısaltması:
DMS = Durchblutung, Motorik, Sensibilität

    - Diagnostik:
        - KU: Sensibilität, Motorik, Reflexe, Pulse
          Röntgen, CT, MRT, EMG
    - Therapie:
        - Schmerzmittel (Analgetikum), Muskelrelaxans, Mineralien, Vitamine, Reha, Physiotherapie, Druckverband, Prothese, Gips (alçı, verb: gipsen), Schiene (atel, nicht flexibel), Bandage (flexibel), Handmanschette, Osteosynthese, Wärmeflasche/Wärmepflaster

- Lumbago tedavisinde hasta **Stufenlagerung** yapar. Bunu hastaya söyle anlatiriz:
    - Sie legen sich auf den Rücken und (legen) Ihre Beine auf einen Stuhl. Hüfte und Knie müssen 90 Grad gebeugt sein/… müssen im rechten Winkel sein. Das entlastet den unteren Rücken. (Sırt üstü yatarsınız ve bacaklarınızı bir sandalyeye koyarsınız. Kalçalar ve dizler 90 derece bükülü olmalıdır/… dik açılarda olmalıdır. Bu, alt sırtı rahatlatır.)

*Muskelrelaxans ist für Skelettmuskulatur, Spasmolytikum ist für glatte Muskulatur.

- Hastada kırık süphesi var. Inspeksiyonda ne görebilirsin:
    - die Fehlstellung (seviye farkı)
    - die Dislokation
    - die dislozierte Fraktur (kemikler birbirinden ayrılmış kırık)
    - die offene Fraktur (açık kırık)
    - die Deformität (die Verformung)

- Palpation/Auskultation'da ne bulursun?
    - die Krepitation
    - die Druckschmerzen

- Kırık nasıl OP yapılır?
    - Draht (tel)
    - Platte (plaka)
    - Fixateur (dışardan yapılır, außen)

➔springen – sprang – (sein) gesprungen = biryerden atlamak, zıplamak.
➔ vom Stuhl springen= sandalyeden atlamak.
➔Sprunggeleksdistorsion/-fraktur icin tipik bir anamnez: bir yerden atlamak

- KTS tedavisinde hastaya Handmanschette verilir.

- Hasta ismini hecelerken **e** ve **i** yi ayırtedemiyorsan şöyle sor:
    - **E** wie **Emil** oder **I** wie **Ida**?

EINIGE AUFKLÄRUNGEN: ↩️

MRT:

- Eine MRT-Untersuchung ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem wir die Strukturen beurteilen können. Der Patient liegt auf einer Liege und wird durch eine Röhre gefahren. Der Patient darf sich nicht bewegen. Die Struktur oder das Organ wird in Schnittbildern dargestellt. Er darf keine Metallobjekte oder Herzschrittmacher tragen.
  (MRI taraması, yapıları değerlendirmemizi sağlayan bir görüntüleme prosedürüdür. Hasta bir kanepede uzanır ve bir tüpten geçirilir. Hasta hareket etmemelidir. Yapı veya organ, kesit görüntülerde gösterilir. Metal nesneler veya kalp pili kullanmamalıdır).

US:

- Eine US-Untersuchung ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem wir die Strukturen beurteilen können. Wir tragen ein Gel auf die Haut auf. Das Gerät hat eine Schallkopf. Dieser sendet Wellen aus und wird auf der Haut bewegt. Das Bild wird auf einem Monitor dargestellt.
  (US incelemesi, yapıları değerlendirmemizi sağlayan bir görüntüleme prosedürüdür. Cilde bir jel uyguluyoruz. Cihaz bir dönüştürücüye sahiptir. Bu dalgalar yayar ve cilt üzerinde hareket eder. Görüntü bir monitörde görüntülenir).

Die Bronchoskopie/ die Spiegelung der Atemwege:

- Diese Untersuchung ist ein Verfahren, mit dem wir die Lungen beurteilen können. Diese Methode kann etwas unangenehm werden, deshalb verabreichen wir ein leichtes Betäubungsmittel. **Bei** dieser Methode wird ein dünner Schlauch mit Kamera und Licht durch den Mund eingeführt und über den Kehlkopf durch die Luftröhre in die Bronchien vorgeschoben. **Mit** dieser Methode ist es möglich, Schleim abzusaugen, Gewebeproben zu entnehmen und Fremdkörper zu entfernen.
  (Bu muayene akciğerleri değerlendirmemizi sağlayan bir işlemdir. Bu yöntem biraz rahatsız edici olabilir, bu yüzden hafif bir anestezi uygulayacağız. Bu yöntemde ağızdan kameralı ve ışıklı ince bir tüp sokulur ve soluk borusu yoluyla gırtlaktan bronşlara itilir. Bu yöntemle mukus emmek, doku örnekleri almak ve yabancı cisimleri çıkarmak mümkündür).

Angiographie:

- Das ist eine radiologische Untersuchung. Bei einer Angiografie führen wir einen Katheter in die Femoralarterie (in der Leiste) ein, spritzen ein Kontrastmittel und fertigen Röntgenaufnehmen an. Dann schieben wir den Katheter bis zur Engstelle. Dort platzieren wir einen Ballon, füllen ihn mit Flüssigkeit und glätten dadurch die Gefäßwände. Wenn nötig, können wir auch einen Stent setzen/implantieren.
  (Bu bir radyolojik muayene. Anjiyografi sırasında femoral artere (kasıkta) bir kateter yerleştirir, kontrast madde enjekte eder ve röntgen çekeriz. Ardından kateteri daralma noktasına kadar itiyoruz. Oraya bir balon yerleştiririz, sıvıyla doldururuz, böylece damarin duvarlarını yumuşatırız. Gerekirse stent de yerleştirebiliriz).

Bypass-OP:

- Das ist eine chirurgische Methode, mit der wir verengte Gefäße **überbrücken** können. Für diesen Zweck können wir ein **körpereigenes** Gefäß verwenden.
  (Daralan damarları köprülememizi sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Bu amaçla endojen bir damar kullanabiliriz).

***Ne zaman „bei“ ne zaman „mit“: Cihaz/yöntemin kendisine ait bir özellikten bahsediyorsak → bei (bu yöntemde .....)
Bu yöntemi kullanarak yaptığımız şeyden bahsediyorsak → mit (bu yöntem ile .....)

Aufklärung über medizinische Maßnahmen:

- Warum wird die Untersuchung gemacht?
- Welche Infos bringt die Untersuchung?
- Was bringt eine Operation?
- Wie wird die OP gemacht?
- Was sind die Risiken? Welche möglichen Komplikationen gibt es?
- Wie kann / soll sich der Patient darauf vorbereiten?

****Was Sie aber auf jeden Fall erklären müssen – egal ob der Patient es hören will oder nicht, sind die Risiken und möglichen Komplikationen.*

Apparative Diagnostik und Eingriffe ↩️

Röntgen ↩️

- Ich habe gerade mit dem Oberarzt gesprochen: Bei Ihnen ist eine Röntgenuntersuchung nötig. ☺
- Ich versuche, Sie über alles aufzuklären. Wenn ich zu schnell spreche oder wenn Sie etwas nicht verstanden haben, sagen Sie mir bitte Bescheid, okay?
- Wir werden einen Röntgenstrahl nutzen, um **eine bildliche Darstellung** Ihres Körperinneren bzw. von Körperteilen zu bekommen. Die Strahlenbelastung ist gering, daher ist die Röntgenuntersuchung ungefährlich.
- Sie werden auf jeden Fall eine Bleischürze oder eine Bleikapsel bekommen, sodass wir die anderen Körperregionen schützen. Meine Kollegen werden Ihnen erklären, wie Sie stehen sollen. Aber am wichtigsten ist, dass Sie sich nicht bewegen, wenn wir unser „Fotoshooting“ durchführen, okay? Alles klar.
- Vücudunuzun veya vücudunuzun bölümlerinin görsel bir temsilini elde etmek için bir röntgen kullanacağız. Radyasyona maruz kalma düşüktür, bu nedenle röntgen muayenesi zararsızdır.
- Vücudun diğer bölgelerini korumamız için mutlaka kurşun önlük veya kurşun kapsül alacaksınız. Meslektaşlarım size ayakta nasıl duracağınızı söyleyecektir. Ama en önemlisi, "fotoğraf çekimimizi" yaparken kıpırdama, tamam mı? Anladım.
- Der Kollege wird Ihnen sagen: „Jetzt einatmen, ausatmen, Luft anhalten“ usw. Seien Sie bitte aufmerksam!

- Lächeln Sie den Patienten an. Das entspannt die Situation und den Patienten :-)

Computertomografie (CT) ↩️

Ultraschall (US) ↩️

• Was besonders wichtig ist: Vermeiden Sie bitte blähende Speisen am Tag vorher – keine leckeren Bohnen, keine Kohlrouladen und so etwas, Blumenkohl geht leider auch nicht. Die Harnblase soll gefüllt sein (Wasser, Tee trinken) und am besten wäre es, wenn Sie vor der Untersuchung nichts essen würden. • Özellikle önemli olan: Lütfen bir gün önce gazlı yiyeceklerden kaçının - lezzetli fasulye yok, lahana ruloları ve benzeri, karnabahar da maalesef mümkün değil. İdrar kesesi dolu olmalı (su, çay iç) ve muayeneden önce hiçbir şey yememiş olmanız daha iyi olur.

Ehrlich gesagt habe ich noch nie eine Ultraschallgel-Allergie gesehen. Sie ist aber in der Literatur erwähnt . ☺

Bronchoskopie ↩️

• Diese Untersuchung ist ein Verfahren, mit dem wir die Lungen beurteilen können. Diese Methode kann etwas unangenehm werden, deshalb verabreichen wir ein leichtes Betäubungsmittel. **Bei** dieser Methode wird ein dünner Schlauch mit Kamera und Licht durch Mund eingeführt und durch Kehlkopf über Luftröhre in die Bronchien geschoben. **Mit** dieser Methode ist es möglich, Schleim abzusaugen, Gewebeprobe zu entnehmen und Fremdkörper zu entfernen.

• (Bu muayene akciğerleri değerlendirmemizi sağlayan bir işlemdir. Bu yöntem biraz rahatsız edici olabilir, bu yüzden hafif bir anestezi uygulayacağız. Bu yöntemde ağızdan kameralı ve ışıklı ince bir tüp sokulur ve soluk borusu yoluyla gırtlaktan bronşlara itilir. Bu yöntemle mukus emmek, doku örnekleri almak ve yabancı cisimleri çıkarmak mümkündür).

Angiographie ↩️

• Das ist eine radiologische Untersuchung. Bei einer Angiografie führen wir einen Katheter in die Femoralarterie (in der Leiste) ein, spritzen ein Kontrastmittel und fertigen Röntgenaufnahmen an. Dann schieben wir den Katheter bis zur Engstelle. Dort platzieren wir einen Ballon, füllen ihn mit Flüssigkeit und glätten dadurch die Gefäßwände. Wenn nötig, können wir auch einen Stent setzen/implantieren.

• (Bu bir radyolojik muayene. Anjiyografi sırasında femoral artere (kasıkta) bir kateter yerleştirir, kontrast madde enjekte eder ve röntgen çekeriz. Ardından kateteri daralma noktasına kadar itiyoruz. Oraya bir balon yerleştiririz, sıvıyla doldururuz, böylece damarin duvarlarını yumuşatırız. Gerekirse stent de yerleştirebiliriz).

Bypass-Operation ↩️

• Das ist eine chirurgische Methode, mit der wir verengte Gefäße **überbrücken** können. Für diesen Zweck können wir ein **körpereigenes**

Gefäß verwenden.

• (Daralan damarları köprülememizi sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Bu amaçla endojen bir damar kullanabiliriz).

ÖGD ↩️

Koloskopie ↩️

ERCP ↩️

• Die ERCP erlaubt es, Erkrankungen der Gallenwege und / oder der Bauchspeicheldrüse nachzuweisen und ggf. gleich zu behandeln.
Was für Sie besonders wichtig ist: Nach dem Abendessen am Vortag (spätestens um 20 Uhr) dürfen Sie keine Speisen mehr zu sich nehmen. In den letzten 2 Stunden vor der Untersuchung auch kein Wasser mehr trinken. Das heißt nicht, dass Sie stattdessen etwas anderes trinken dürfen. Nichts.

• ERCP, safra kanalları ve/veya pankreas hastalıklarının tespit edilmesini ve gerekirse hemen tedavi edilmesini sağlar. Sizin için özellikle önemli olan: Bir gün önce akşam yemeğinden sonra (en geç 20:00'ye kadar) daha fazla yemek yemenize izin verilmez. Sınavdan önceki son 2 saat içinde su içmeyin. Bu, onun yerine başka bir şey içebileceğiniz anlamına gelmez. Hiç bir şey.

• Sie bekommen eine Kurznarkose. Sie werden auf der linken Seite liegen und einen Zahnschutz im Mund behalten. Dann kann alles losgehen. Das Gerät sieht aus wie ein Schlauch, ist ganz dünn, mit einer Kamera am Ende. Es wird durch den Mund eingeführt und weiter bis zur Mündung der Gallenwege und des Bauchspeichel-drüsenganges im Zwölffingerdarm geschoben. Wir werden auch ein bisschen Luft hineinblasen, sodass wir mehr Raum haben und alles in „Ultra HD“ sehen. Also nicht wundern am Ende werden Sie ganz elegant Luft aufstoßen. Wir können durch diesen „Schlauch“ auch andere Geräte schieben, z. B. um Gewebeproben zu entnehmen, eine Blutung zu stillen, Ausstülpungen oder Gallensteine zu entfernen, Gallen oder Bauch-speicheldrüsengang zu erweitern usw. Manchmal nutzt man auch ein Kontrastmittel und Röntgenstrahlen, um alles besser beurteilen zu können. Die Pathologie-Ergebnisse bekommt Ihr Hausarzt innerhalb einer Woche per Fax.

• Size kısa bir anestezi verilecektir. Ağzınızda bir sakız kalkanı ile sol tarafınıza yatacaksınız. O zaman her şey başlayabilir. Cihaz bir tüp gibi görünüyor, çok ince ve ucunda bir kamera var. Ağızdan sokulur ve safra kanallarının ağzına ve duodenumdaki pankreas kanalına doğru itilir. Orada da biraz hava üfleyeceğiz, böylece daha fazla alanımız olacak ve her şeyi "Ultra HD" olarak göreceğiz. Bu yüzden şaşırmayın, sonunda oldukça zarif bir şekilde hava üfleyeceksiniz. Diğer cihazları da bu "hortumdan" geçirebiliriz, örn. B. doku örnekleri

almak, kanamayı durdurmak, çıkıntıları veya safra taşlarını çıkarmak, safra veya pankreas kanallarını genişletmek vb. Her şeyi daha iyi değerlendirebilmek için bazen bir kontrast madde ve röntgen kullanılır. Aile doktorunuz patoloji sonuçlarını bir hafta içinde faksla alacaktır.

Laparoskopie ↩️

• Zur Untersuchung des Bauchraums wird kein Bauchschnitt durchgeführt, keine Sorge. In der Laparoskopie machen wir stattdessen üblicherweise 3 sehr kleine Schnitte – einen am Nabel und die anderen seitlich dazu. Durch diese kleinen Schnitte führen wir einen Schlauch mit einer Kamera am Ende und anderen Instrumenten in ihren Bauchraum ein. Bevor wir das aber machen, werden wir Ihren Bauch aufblasen, sodass wir alles gut sehen können und genug Platz zum Operieren haben. Das Gute an dieser Methode ist, dass die Heilung sehr schnell und mit wenig Schmerzen verbunden ist. Natürlich werden Sie aber – wie bei einer „klassischen" Operation – eine Narkose bekommen.

• Karın muayenesi için karın kesi yapılmaz, merak etmeyin. Laparoskopide bunun yerine genellikle 3 çok küçük kesi yaparız - biri göbekte, diğeri yanlarda. Bu küçük kesiklerden karnına ucunda kamera ve diğer aletlerin olduğu bir tüp yerleştiriyoruz. Ama bunu yapmadan önce, her şeyi iyi görebilmemiz ve ameliyat için yeterli alana sahip olabilmemiz için karnınızı şişireceğiz. Bu yöntemin iyi yanı, çok çabuk ve az acıyla iyileşmesidir. Tabii ki, tıpkı "klasik" bir operasyonda olduğu gibi anestezi uygulanacaktır.

• Üblicherweise bekommen die Patienten danach 2 Tage eine Drainage, das heißt einen sehr dünnen Schlauch, durch den krankhafte oder vermehrte Körperflüssigkeiten abgeleitet werden können. Das ist normal nach einer Operation. Nach 2 Tagen werden Sie sich viel besser fühlen. Doch auch wenn man von außen fast nichts sehen kann, vergessen Sie bitte nicht, dass es eine Operation war: Innerlich haben Sie noch Wunden, die heilen müssen. Schonen Sie sich daher einige Tage und übertreiben Sie es nicht mit Sport oder dem Heben schwerer Sachen.

• Hastalara genellikle 2 gün sonra drenaj yapılır, yani patolojik veya artmış vücut sıvılarının boşaltılabileceği çok ince bir tüp. Ameliyattan sonra bu normaldir. 2 gün sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ama dışarıdan pek bir şey göremeseniz bile bunun bir ameliyat olduğunu unutmayın: İçinizde hala iyileşmesi gereken yaralar var. Bu yüzden birkaç gün rahatlayın ve spor yaparak veya ağır şeyler kaldırarak aşırıya kaçmayın.

Allgemeine OP-Aufklärung ↩️

Die größte Angst einiger Patienten, wenn sie sehen, dass Sie die Aufklärung machen, ist, dass Sie auch (allein) operieren werden. „Machen Sie sich keine Gedanken, Herr / Frau X. Auf keinen Fall werde ich die Operation (allein) durchführen. Nein, das machen die Oberärzte. / Nein, die Oberärzte sind immer dabei. Ich möchte mit Ihnen nur den Verlauf und die Risiken besprechen.“

Bazı hastaların sizi keşif yaparken gördüklerinde gördükleri en büyük korku, sizin de (kendi başınıza) ameliyat olmanızdır. "Merak etmeyin Bay / Bayan X. Ameliyatı (tek başıma) yapmama imkan yok. Hayır, kıdemli doktorlar bunu yapar. / Hayır, kıdemli doktorlar her zaman oradadır. Sadece süreci ve riskleri seninle tartışmak istiyorum.”

• Sie werden vor der Operation auf jeden Fall eine Narkose bekommen und darüber werden Sie auch mit den Kollegen in der Anästhesie noch einmal sprechen. Sie dürfen vor der Operation nichts essen oder trinken. Das ist uns ganz wichtig. Ich weiß, dass viele Patienten sich Sorgen machen, dass es wehtut oder dass es unangenehm ist – aber Sie werden schön „schlafen“ und nichts mitbekommen. Wir werden auf ... (Ort) einen Schnitt machen. Dadurch können wir die Organe sehen. Dann ... *(hier 2–3 Sätze bzgl. der Technik nennen, wenn möglich).* Ich weiß, das klingt ganz schrecklich, aber es ist viel leichter getan als erklärt.

Her durumda, ameliyattan önce size anestezi verilecek ve anestezideki meslektaşlarınızla tekrar konuşacaksınız. Ameliyattan önce hiçbir şey yiyip içmemelisiniz. Bu bizim için çok önemli. Birçok hastanın acıtacağından veya rahatsız olacağından endişe ettiğini biliyorum - ama güzelce "uyuyacaksınız" ve hiçbir şey fark etmeyeceksiniz. Bir kesim yapacağız... (konum). Bu, organları görmemizi sağlar. Sonra ... (mümkünse teknikle ilgili 2-3 cümle belirtin). Kulağa korkunç geldiğini biliyorum, ama bunu yapmak, açıklamaktan çok daha kolay.

13. Kapselendoskopie:

• Mithilfe einer Videokapsel ist es möglich, den gesamten Verdauungstrakt zu spiegeln und ein schönes Video von Ihrem Dünndarm zu drehen. So kann man Entzündungen finden, Blutungen, Verengungen oder Tumore. Ich muss übrigens etwas erwähnen: Verengungen mögen wir gar nicht, wenn wir die Kapsel nutzen. Ich erkläre gleich warum. Die Minikamera ist so klein wie eine normale Tablette. Sie wird mit etwas Wasser eingenommen. Bitte beißen Sie nicht auf die Kamera.
[Es tut ihr weh, die ist teuer und uns lieb.] Nach etwa 3 Tagen werden Sie ein *Ü-Ei* im Stuhlgang finden unsere Minikamera. Die Kapsel brauchen wir nicht, die können Sie ruhig wegwerfen. Die Kamera ist aber wichtig. • Bir video kapsül yardımıyla tüm sindirim sistemini yansıtmak ve ince bağırsağınızın güzel bir videosunu yapmak mümkündür. Enflamasyon, kanama, daralma veya tümörleri bu şekilde bulabilirsiniz.Bu arada bir şeyden bahsetmek zorundayım: Kapsülü kullandığımızda daralmaları hiç sevmiyoruz. Nedenini birazdan açıklayacağım. Mini kamera normal bir tablet kadar küçük. Bir miktar su ile alınır. Lütfen kamerayı ısırmayın. [Onu incitiyor, pahalı ve biz onu seviyoruz.] Yaklaşık 3 gün sonra taburede sürpriz bir yumurta bulacaksınız - mini kameramız. Kapsüllere ihtiyacımız yok, atmaktan çekinmeyin. Ama kamera önemli.

- Blutabnahme: Wir nehmen Ihnen Blut ab, und bestimmen verschiedene Werte und Parameter, die uns einen Überblick geben, wie Ihre Organe funktionell arbeiten. Gibt es irgendwo eine Entzündung? Leiden Sie an einer Blutarmut? Und so weiter.

- B.G.A ist eine Abkürzung für Blutgasanalyse, und zwar handelt es sich um eine Blutuntersuchung, bei der die Blutgase, also Sauerstoff sowie Kohlendioxid, und der Säuregehalt Ihres Blutes untersucht werden. Dazu muss man Ihnen nur ein wenig Blut abnehmen.

- Röntgen-Thorax ist eine Untersuchung des Brustkorbs mit Röntgenstrahlen. Die Untersuchung ist schmerzfrei, aber dabei muss der Patient den Oberkörper frei machen und sich vor eine Platte stellen. Die Strahlenbelastung ist hier zu gering, und mit dieser Untersuchung können wir viele Sachen beurteilen, wie zum Beispiel die Lungen, die Herzgröße, das Zwerchfell und so weiter.

- CT ist eine Abkürzung für Computertomographie, und zwar handelt es sich um eine schmerzfreie Röntgen-Untersuchung. Mit Hilfe eines Computers werden viele Schnittbilder Ihres Körpers angefertigt. Bei der Untersuchung muss der Patient für einige Zeit ruhig in einer Röhre liegen. Wenn das für Sie ein Problem darstellt, können wir Ihnen vorher ein Beruhigungsmittel geben.

- MRT ist eine Abkürzung für Magnetresonanztomographie. Das heißt eine Kernspin-untersuchung, und zwar handelt es sich um eine schmerzfreie sowie strahlenfreie Untersuchung. Sie gehört zu den bildgebenden Verfahren, und damit kann man Schnittbilder des menschlichen Körpers erzeugen. Diese Untersuchung dient der Beurteilung vieler krankhafter Organveränderungen. Bei der Untersuchung muss der Patient für einige Zeit ruhig in einer Röhre liegen. Wenn das für Sie ein Problem darstellt, können wir Ihnen vorher ein Beruhigungsmittel geben.

- Sonografie darunter versteht man eine Ultraschalluntersuchung. Damit kann man auf schmerzfreie Weise und ohne Belastung von Strahlung viele innere Strukturen Ihres Körpers untersuchen. Bei der Untersuchung wird ein Gel als Kontaktmittel auf Ihre Haut aufgebracht, und darauf wird der sogenannte Schallkopf gesetzt. Mit Hilfe von Schallwellen werden viele innere Organe sichtbar gemacht und können als Bild aufgezeichnet werden.

- EKG ist eine Abkürzung für Elektrokardiographie. Das ist eine schmerzfreie Untersuchung des Herzens. Hierbei wird über verschiedene Elektroden, die am Körper angebracht werden, die elektrische Aktivität des Herzens gemessen und auf Papier aufgezeichnet. Diese Untersuchung hat mehrere Typen. Die Standard-Untersuchung ist das Ruhe-EKG. Hierbei liegt der Patient ruhig auf einer Liege. Anderer Typ is das sogenannte Belastungs-EKG. Das benutzen wir, um zu beurteilen, wie sich das Herz bei Belastung verhält. Also dabei muss der Patient zum Beispiel ein Rad fahren, aber unter engmaschiger Überwachung. Und schließlich gibt es auch als dritter Typ das sogenannte Langzeit-EKG, bei dem der Patient 24 Stunden ein portables EKG-Gerät tragen muss.

- Koronarangiographie ist eine Darstellung der Herzkranzgefäße beziehungsweise eine Herzkatheteruntersuchung. Hierbei wird ein dünner spezialisierter biegsamer Kunststoffschlauch durch eine punktierte Schlagader von der Leiste über die Hauptschlagader bis zum Herzen eingeführt. Nach Kontrastmittelgabe beleuchten

sich die Herzkranzgefäße durch Röntgen wie ein Weihnachtsbaum, und damit können wir den Herzmuskel und die Herzkranzgefäße beurteilen. Vorteilhaft ist, dass wir sofort therapeutisch vorgehen können, falls wir zum Beispiel eine Engstelle entdeckt haben. Das erfolgt durch eine Ballonaufdehnung oder das Einsetzen eines Stents, was das Gefäß offen behält.

- Angiographie ist eine Untersuchung, bei der die Gefäße mit Bildern dargestellt werden. Um die Gefäße sichtbar zu machen, brauchen wir ein Kontrastmittel, und dieses Kontrastmittel wird Ihnen über eine Vene eingespritzt, ansonsten ist die Untersuchung schmerzfrei. Mit dieser Untersuchung können wir überprüfen, ob es in Ihren Gefäßen irgendwelche Verkalkungen, Einengungen oder Verschlüsse gibt. Noch etwas. Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Blutung, Weichteilverletzung, Allergie oder so. Diese kommen aber sehr selten vor, und unser Team könnte das gegebenenfalls in den Griff kriegen. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben.

- Gastroskopie ist eine Spiegelung. Hierbei wird ein spezialisierter biegsamer optischer Schlauch durch den Mund über die Speiseröhre bis zum Magen beziehungsweise Zwölffingerdarm vorgeschoben. Damit schauen wir uns den Verdauungstrakt von innen an, und können auch die Veränderungen an der Schleimhaut sehen. Gegebenenfalls können wir auch Proben entnehmen, welche im Labor genauer untersucht werden können. Die Untersuchung ist eigentlich schmerzfrei, aber könnte einen Würgereiz auslösen. Deshalb geben wir Ihnen vorher ein leichts Schlafmittel, und somit werden Sie nichts von dem Eingriff mitbekommen.
Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Blutung, Weichteilverletzung, Allergie oder so. Diese kommen aber sehr selten vor, und unser Team könnte das gegebenenfalls in den Griff kriegen. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben.

- Koloskopie ist eine Darmspiegelung. Hierbei wird ein spezialisierter biegsamer optischer Schlauch durch den After über den Mastdarm bis zum letzten Stück des Dünndarms vorgeschoben. Damit schauen wir uns die Wände von innen an, und können auch die Veränderungen an der Schleimhaut sehen. Gegebenenfalls können wir auch Proben entnehmen, welche im Labor genauer untersucht werden können. Vor der Untersuchung muss der Darm gereinigt werden. Dazu muss der Patient Wasser mit einem Zusatz trinken, sodass der Darm zur besseren Sicht gespült wird. Die Untersuchung ist etwas unangenehm, deshalb geben wir Ihnen vorher ein leichtes Schlafmittel, und somit werden Sie nichts von dem Eingriff mitbekommen. Noch etwas. Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Blutung, Weichteilverletzung, Allergie oder so. Diese kommen aber sehr selten vor, und unser Team könnte das gegebenenfalls in den Griff kriegen. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben.

- E.R.C.P ist eine Abkürzung für endoskopisch-retrograde Cholangiopankreatikographie, und das ist eine Untersuchung zur Darstellung der Gallengänge und Bauchspeichel-drüsengänge mit Röntgenkontrastmittel. Hierbei wird ein spezialisierter biegsamer optischer Schlauch durch den Mund über die Speiseröhre bis zum Zwölffingerdarm vorgeschoben. Vorteilhaft ist, dass wir gleichzeitig therapeutisch vorgehen können, wie zum Beispiel ein Stein entfernen, oder eine Erweiterung der Gangmündung in den Dünndarm durchführen. Die Untersuchung ist etwas unangenehm, deshalb geben wir Ihnen vorher ein leichtes Schlafmittel, und somit werden Sie nichts von dem Eingriff mitbekommen. Noch etwas. Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Blutung, Weichteilverletzung, Allergie oder so. Diese kommen aber sehr selten vor, und unser Team könnte das gegebenenfalls in den Griff kriegen. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben.
- Bronchoskopie ist eine Spiegelung der Atemwege. Hierbei wird ein spezialisierter biegsamer optischer Schlauch durch den Mund oder die Nase über die Lüftröhre bis zu Bronchien vorgeschoben. Damit schauen wir uns die Atemwege von innen an, und können wir die Veränderungen an der Schleimhaut sehen. Gegebenenfalls können wir auch Proben entnehmen, welche im Labor genauer untersucht werden können. Die Untersuchung könnte etwas unangenehm sein, deshalb geben wir Ihnen vorher ein leichtes Schlafmittel, und somit werden Sie nichts von dem Eingriff mitbekommen.
- Apendektomie(Blinddarmentfernung)/Cholezystektomie(Gallenblasenentfernung):
Die klinischen Befunde sprechen für eine Blinddarmentzündung/Gallenblasen-entzündung. Das heißt, Sie sollen sich einer Operation unterziehen, und ich möchte Sie gerne über die geplante Operation und ihre möglichen Komplikationen aufklären. Für diese Operation gibt es zwei Möglichkeiten:
Offene Operation, also konventionell durch einen Bauchschnitt, was man heutzutage selten macht.Andererseits gibt es die laparoskopische Operation, also durch kleine spezialisierte optische Geräte, was wir hier machen und Ihnen empfehlen.
Der Vorteil der Laparoskopie liegt in der Möglichkeit, die gesamte Bauchhöhle einschließlich des inneren Genitalis, insbesondere bei Frauen, beurteilen zu können, und bei unklaren Befunden andere intraabdomenale Ursachen ausschließen zu können.
Der Operateur macht einen kleinen Schnitt circa 2 Zentimeter am Bauchnabelrand, führt dadurch eine Kamera rein, und schaut sich die Bauchhöhle von innen an. Dann durch zwei weitere kleine Schnitte führt er die O.P-instrumente rein. Der entzündete Blinddarm/ die entzündete Gallenblase wird freigelegt, geklemmt und entfernt. Danach legen wir eine Drainage, um die Nachblutung zu kontrollieren, und die Wundflüssigkeiten raus abfließen zu können. Schließlich werden die Wunden natürlich zugenäht, und wenn alles wie geplant läuft, dauert die Operation ungefähr weniger als eine Stunde. Aber Sie sollen auch damit rechnen, dass Sie nach der Operation 3 bis 5 Tage bei uns zur Überwachung bleiben sollen. Außerdem sollen Sie vor der Operation auf nüchternen Magen sein. Das heißt, für etwa 12 Stunden vor der Operation dürfen Sie nur Flüssigkeiten trinken.
Noch etwas. Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Blutung, Weichteilverletzung, Allergie oder so. Diese kommen aber sehr selten vor, und unser Team könnte das gegebenenfalls in den Griff kriegen. Also,

Sie brauchen keine Angst zu haben.
Das war es. Haben Sie Fragen dazu?